



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JULI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 10

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 10

3.3.2 Rawat Inap 12

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 19

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 20

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 21

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 22

3.4.1 Instalasi Farmasi 22

3.4.2 Laboratorium 26

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 28

3.4.4 Radiologi 30

3.4.5 Gizi 33

3.4.6 CSSD - Laundry 35

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan 38

3.5.1 SDM 38

3.5.2 MFK dan K3RS 43

3.5.3 Security 48

3.5.4 Parkir 51

3.5.5 Humas Marketing 51

3.5.6 Penjaminan 55

3.5.7 PIPP – MOD - MPP 56

3.5.8 *Cleaning Service* 66

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum 68

3.6 Komite dan Tim 70

3.6.1 Komite Mutu 70

3.6.2 Komite PPI 99

3.6.3 Tim PKRS 108

3.6.4 Tim Prognas 110

3.6.5 Tim PPRA 148

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 154

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 155

3.8 Profil SDM 160

Bab IV Kesimpulan dan Saran 163

Bab V Penutup 164

LAMPIRAN 165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juli Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



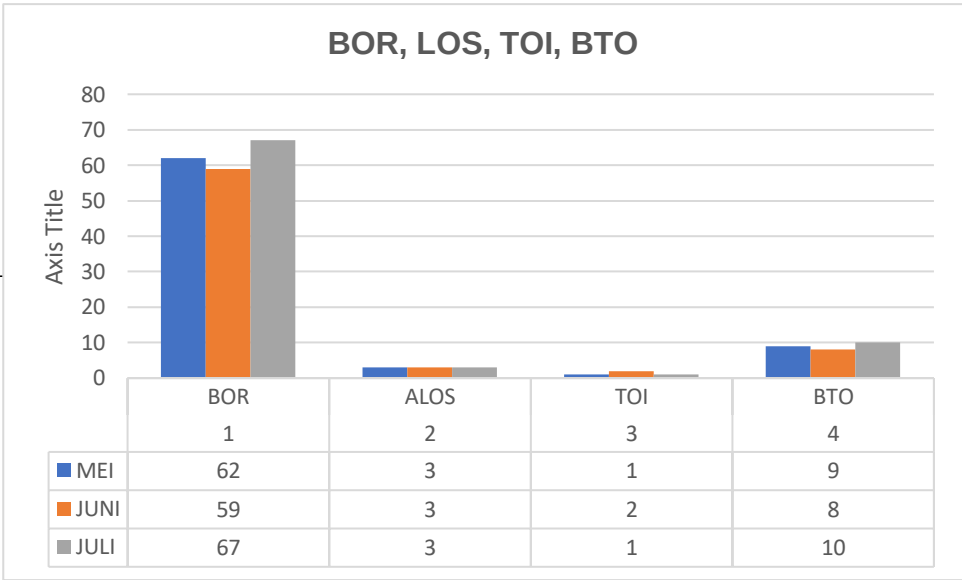
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	MEI	JUNI	JULI
1	BOR	62	59	67
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	2	1
4	BTO	9	8	10

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



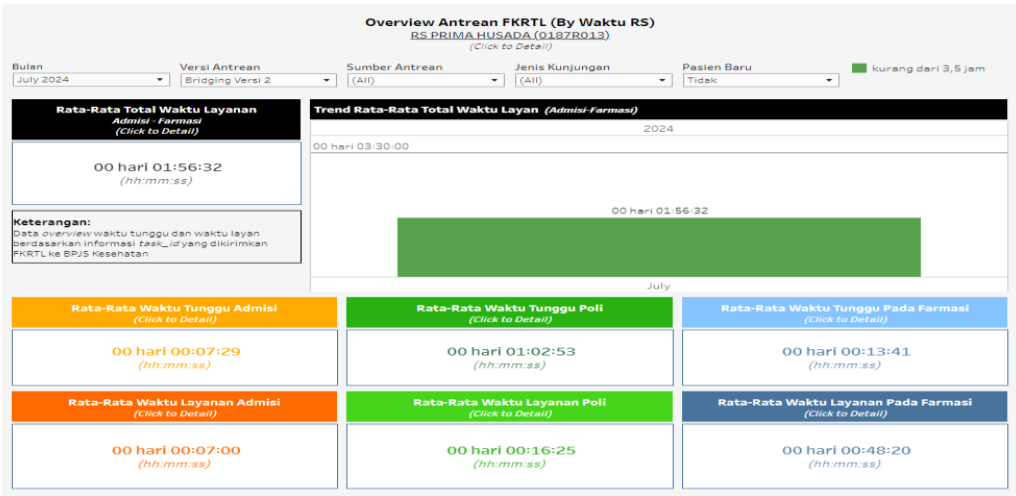
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

BOR kembali naik menjadi di atas standar (> 60%) dengan persentase peningkatan sebesar 13%, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pasien rawat inap.

ALOS masih tetap berada pada rata-rata 3 hari, yang masih berada di bawah standar 6-12 hari. Hal ini disebabkan karena pasien dominan jaminan BPJS, dimana terdapat keterbatasan plafon sehingga pasien yang sudah stabil dapat dipulangkan pada hari rawat ketiga hingga empat.

TOI masih relative sama dengan bulan sebelum-sebelumnya. BTO atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode berada pada sepuluh kali sedang standardnya yaitu 40-50 kali.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN	BULAN			
	Waktu Rata-Rata	APRIL 2024	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Total Waktu Layanan	02.25.44	02.34.36	02.32.53	01.56.32
2	Waktu Tunggu Admisi	00.13.51	00.13.59	00.06.00	00.07.29
3	Waktu Layanan Admisi	00.12.01	00.13.56	00.05.56	00.07.00
4	Waktu Tunggu Poli	00.59.19	01.06.11	01.05.56	01.02.53
5	Waktu Layanan Poli	00.15.57	00.17.12	00.18.20	00.16.25
6	Waktu Tunggu Farmasi	00.20.10	00.19.15	00.16.46	00.13.41
7	Waktu Layanan Farmasi	01.00.20	01.06.17	01.00.38	00.48.20

Analisis :
 Pada bulan Juli 2024, total waktu layanan menunjukkan perkembangan positif yaitu lebih cepat pada angka 01.56.32. Dalam 4 bulan terakhir waktu pada dashboard Juli 2024 memiliki trend penurunan, terutama pada waktu layanan poli dan waktu tunggu farmasi. Fluktuatif pada indikator waktu-waktu lainnya

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke unit
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan faktor yang mempengaruhi.
Study	Data rekap lima bulan yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi ka unit 2. Monitoring evaluasi 3. Supervisi kabit

NO	JENIS	TARGET	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	36.34%	34.86%	37.2%	34.88%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	96.21%	94.57%	96.2%	94.62%

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 1 minggu 3x. Sudah ada SOP	Kendala pengembangan ini jika di ruangan crowded tidak ada yang menemani pendampingan doa
2	IRNA	Senam hamil dan hypnobirthing	Untuk senam hamil sudah berjalan tetapi untuk hynobithing belum berjalan	Hypnobirthing belum berjalan karena terkendala jumlah SDM yang kurang
3	IRNA	Foto bayi	Sudah berjalan dengan baik, respon keluarga pasien juga baik	-
4	IRJA	Poli Eksekutif	Progress 100%. DPJP sudah ada 5 dpjp yang praktek	Masih sedikit pasien yang datang
5	IGD	Pemutaran Edukasi Triase di IGD	Sudah diputar secara berkala	20% pasien masih ada yang belum paham mengenai system triase, hal ini dapat disebabkan karena pasien tidak focus mendengarkan edukasi tentang triase tersebut
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara.	Proses penyelesaian oleh Programmer PT.	Dalam antrian programmer.
		2. Open Recruitmen Admin Primantara.	Sudah mendapatkan admin, bergabung mulai tanggal 01 Juli 2024.	-
		3. TTD elektronik semua pasien rawat jalan, baik pasien IGD maupun rawat inap.	Follow up programmer.	Dalam antrian programmer.
		4. Fitur Iterisasi pada SIMRS.	Fitur sudah tersedia di SIMRS, SPO disosialisasikan.	Target ITER 1000/tahun. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan untuk pencapaian

				target (sosialisasi dengan DPJP). Centralisasi Master Barang berdampak kepada pasien ITER, karena ada perbaruan master sehingga disiasati dengan input di resep lain-lain.
		5. Pendistribusian obat ke ruangan.	Tetap menggunakan system UDD dengan penyiapan obat di malam hari. Obat UDD tidak terlambat terdistribusi ke ruang perawatan.	-
		6. KPO elektronik	Sudah diajukan ke Programmer PT.	Dalam antrian programmer.
		7. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid).	Dalam Proses.
		8. Asuhan BPJS nol bayar.	SPO sudah dibuatkan. Ada keterkaitan antara IGD, IRNA, KASIR, Pendaftaran IGD dan CSO.	Tidak ada kendala. Pasien diedukasi pengurusan kepulangan dan mengambil obat ketika obat sudah siap. Waktu penyiapan obat non racikan maksimal 30 menit, obat racikan maksimal 60 menit. Setiap obat selesai petugas

				TTK langsung konfirmasi ruangan tanpa dirapel.
2	Gudang Farmasi	1. Repack sediaan farmasi sharing dose.	Repack sudah berjalan, tarif repack sudah ada.	- Tidak ada lemari asam, sehingga repack formalin ditiadakan. - Alcohol repack terlalu kecil tidak sesuai dengan kebutuhan. Stardine repack fastmoving.
		2. Labeling Buffer	Menggunakan papanisasi.	-
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses memasukan form kedalam aplikasi SIMRS.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis.
		2. Serah terima DRM menggunakan system digital.	Serah terima menggunakan spreadsheet (sudah berjalan).	Monitoring dan Evaluasi.
		3. Permintaan form menggunakan system digital.	Permintaan form dari unit menggunakan google form, sudah berjalan mulai Bulan Juni 2024.	Monitoring dan Evaluasi.
4	Radiologi	Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil radiograf dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium.	Dalam antrian programmer

			2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	
		2. Pengadaan BDRS	1. Proposal dan surat permintaan pelatihan sudah dibuatkan. 2. Sudah ada daftar kebutuhan pengadaan BDRS dan sudah diajukan. 3. Penyekatan ruangan BDRS sudah dilakukan. 4. Legalitas dibantu pengurusan oleh Legal PT. 5. Review tarif disesuaikan dengan PHS.	Dalam Proses.
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan	Kolaborasi dengan Humas & Marketing.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan
		2. MCU Gizi	Rencana diajukan review tarif ke Keuangan PT	Dalam Proses
		3. <i>Prima Healthy Meal</i>	Sudah pengajuan TOR ke PT	Menunggu ACC
7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitator (steam plasma)	Belum terealisasi	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaiki serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.

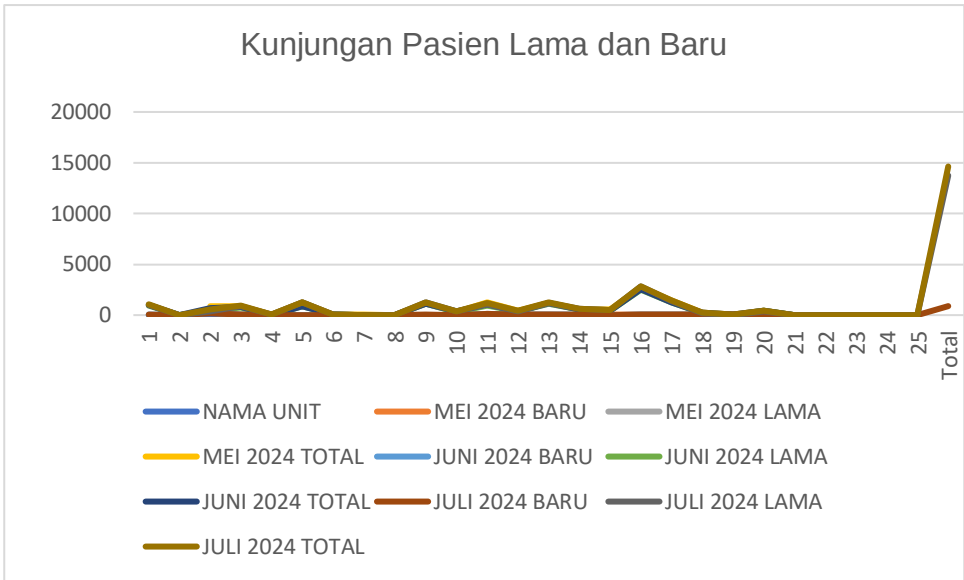
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. Belum terealisasi.	Dalam proses.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP.	Dalam Proses.

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	MEI 2024			JUNI 2024			JULI 2024		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	92	1214	1306	46	961	1007	80	995	1075
2	Anak sakura				0	1	1	0	1	1
2	IGD	246	645	891	236	435	671	199	372	571
3	Klinik Bedah	54	823	877	54	735	792	55	869	924
4	Klinik Bedah Plastik	4	31	35	0	19	19	3	33	37
5	Klinik Fisioterapi	3	1273	1276	5	848	853	1	1255	1256
6	Klinik Gigi Periodonti	8	39	47	0	42	42	6	38	44
7	Klinik Gigi Spesialis	7	22	29	0	12	12	0	0	0
8	Klinik Ibu dan Anak	0	14	14	0	9	9	0	13	13
9	Klinik Jantung	22	1145	1167	13	1106	1119	27	1242	1269
10	Klinik Jiwa	10	310	320	10	337	347	8	362	370
11	Klinik Kandungan	146	1091	1237	108	928	1036	127	1081	1208
12	Klinik Kulit dan Kelamin	56	382	438	24	341	365	53	399	452
13	Klinik Mata	82	1132	1214	55	1116	1171	67	1189	1256
14	Klinik Orthopedi	16	541	557	34	528	562	34	599	633
15	Klinik Paru	23	504	527	6	442	428	14	482	496
16	Klinik Penyakit Dalam	58	2663	2721	53	2498	2551	50	2796	2846
17	Klinik Syaraf	38	1409	1447	29	1229	1258	37	1387	1424
18	Klinik THT	51	183	234	39	178	217	55	204	259
19	Klinik Umum	25	12	37	46	10	56	29	21	50
20	Klinik Urologi	35	381	416	13	405	418	33	376	409
21	Klinik gigi anak	1	0	1	2	6	8	3	4	7
22	Gizi	0	0	0	2	3	5	1	17	18
23	Bedah Saraf	0	8	8	0	5	5	0	7	7
24	Obgyn Sakura							2	2	4
25	Penyakit dalam sakura							0	1	1
Total		977	13822	14799	777	12180	12957	884	13745	14650



Analisis :

- 1. Kunjungan 3 bulan terakhir masih naik turun terlebih lagi pada bulan Juli 2024 ini mengalami kenaikan 11,4% sebanyak 1673 pasien karena bulan Juli bulanya panjang sampai tanggal 31 dan hanya ada 5 tanggal merah serta dokter yang cuti sedikit
- 2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2846 pasien. Kunjungan tersebut kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 295 pasien, karena semua praktek sesuai dengan jadwal dan tidak ada yang izin cuti
- 3. Kunjungan terendah adalah klinik gigi spesialis tidak ada pasien dan poli sakura yang baru kunjungan bulan juli masih sedikit

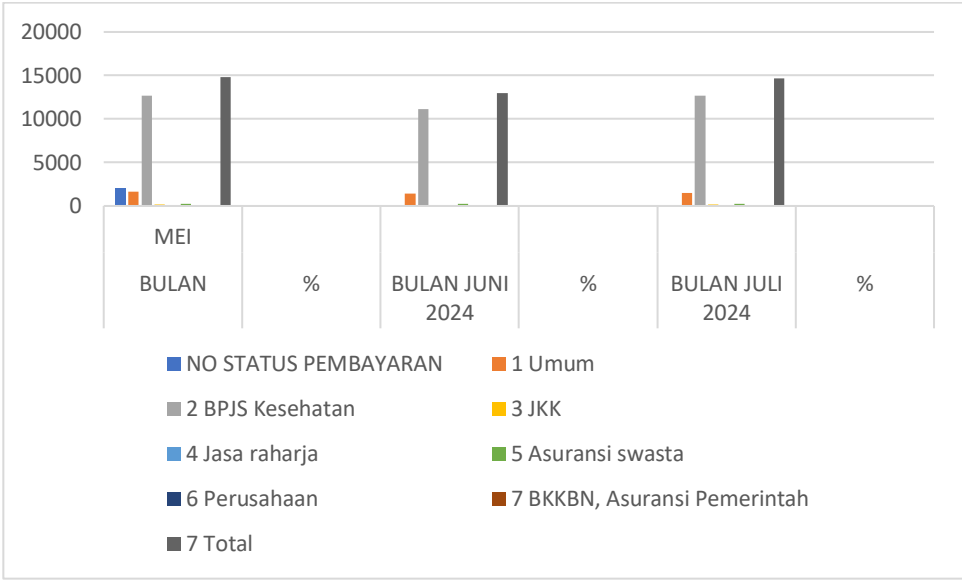
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Untuk bulan depannya membuat harga promo sehingga semua bisa menikmati pelayanan poli sakura
- 2. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
- 3. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi perusahaan
- 4. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 5. Koordinasi dengan humas marketing untuk menampilkan promo di media
- 6. Koordinasi dengan perawat yang ada di ruangan penjangkaran pasien umum dan asuransi

3.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN MEI 2024	%	BULAN JUNI 2024	%	BULAN JULI 2024	%
1	Umum	1640	11,08%	1435	11,07%	1499	10,23%
2	BPJS Kesehatan	12689	85,73%	11121	85,82%	12709	86,75%
3	JKK	147	0,99%	128	0,99%	150	1,02
4	Jasa raharja	10	0,07%	22	0,17%	6	0,04%
5	Asuransi swasta	264	1,78%	226	0,03%	231	1,58%
6	Perusahaan	49	0,33%	22	0,17%	39	0,27%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	2	0,01%	0	0%	16	0,11
	Total	14799	100%	12957	100%	14650	100%

3.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien selama 3 bulan terakhir berdasarkan cara bayar masih naik turun dan belum stabil terlebih untuk bulan juli 2024 untuk pasien jasa raharja sangat menurun di bandingkan 2 bulan sebelumnya

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak

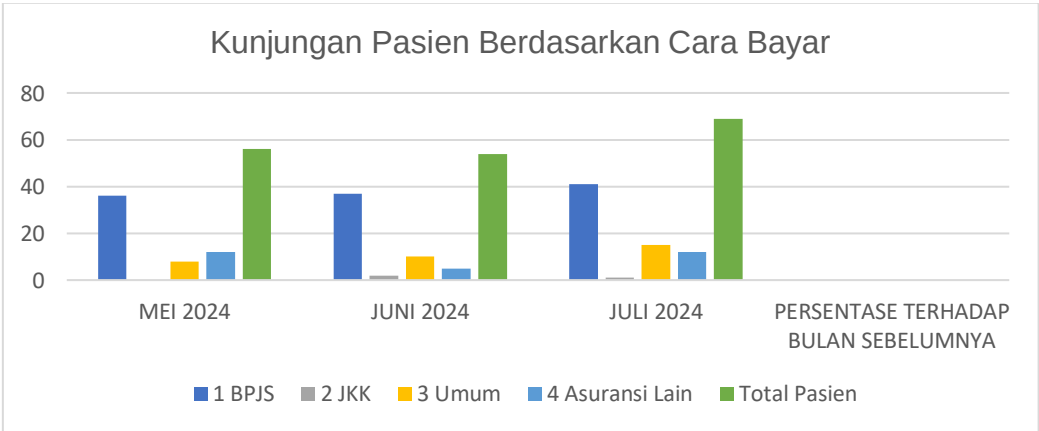
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei –Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	36	37	41	10,8%↑
2	JKK	0	2	1	50%↓
3	Umum	8	10	15	33,3%↑
4	Asuransi Lain	12	5	12	58,3↑
Total Pasien		56	54	69	21,7↑

3.3.2.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

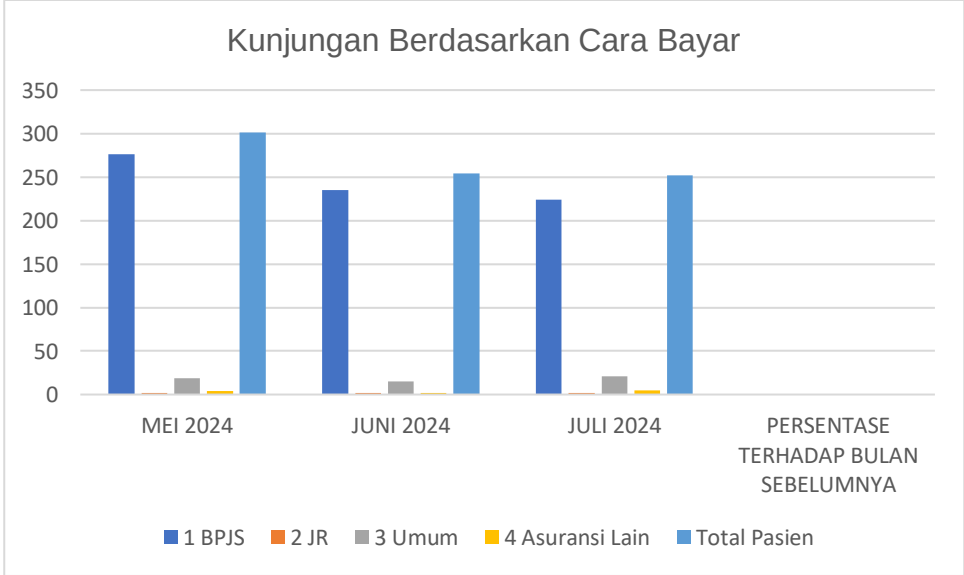
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	JULI 2024	41	15	1	12	69
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir selalu mengalami kenaikan 10,8%	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir selalu mengalami kenaikan 33,3%	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami naik turun untuk bulan juli ini mengalami 50% dari bulan juni	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil dan masih naik turun untuk bulan juli 2024 mengalami kenaikan 58,3% dari bulan sebelumnya	Total pasien bulan Juli mengalami kenaikan dari bulan juni sebesar 21,7%
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap,serta bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru				

3.3.2.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.3.2.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	276	235	224	↓5%
2	JR	2	2	2	0%
3	Umum	19	15	21	↑28,5%
4	Asuransi Lain	4	2	5	↑60%
Total Pasien		301	254	252	↓0,8%

3.3.2.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

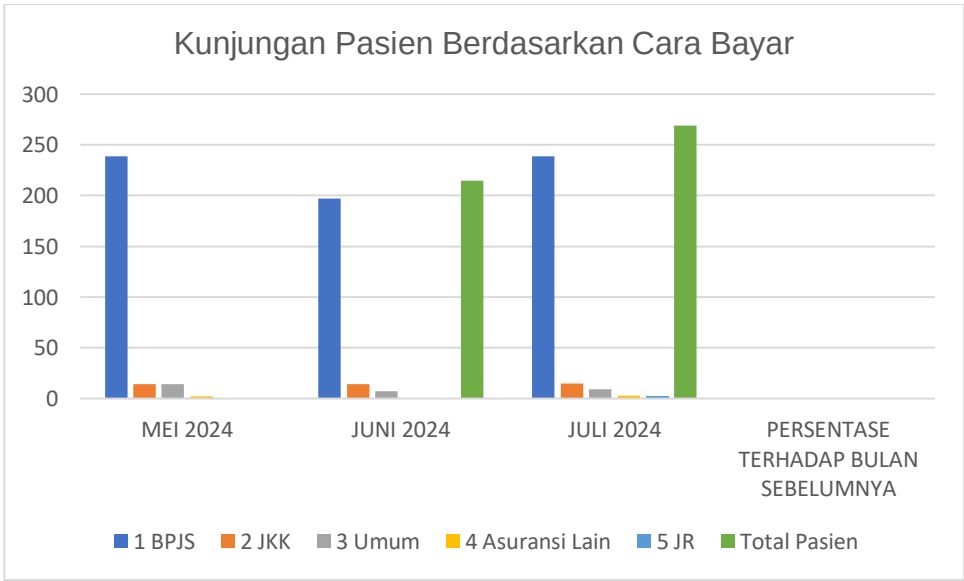
NO.	BULAN JULI 2024	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURAN SI	
1	Analisis	Pasien BPJS mengalami penurunan 5 % di bulan juli,dikarenakan DPJP sudah mulai memahami knkb dan pasien kunjungan dari igd terutama pasien anak juga menurun	Pasien Umum di bulan juli ini meningkat 28,5%	Untuk pasien JKK tetap dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan juli 2024 sebanyak 5 pasien	Total keseluruhan bulan juli mengalami penurunan dari 3 bulan terakhir
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya Evaluasi antrian operasi elektif, Mempercepat waktu antrian operasi,				

3.3.2.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.3.2.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	239	197	239	↑17,5%
2	JKK	14	14	15	↑6,6%
3	Umum	14	7	9	↑13,3%
4	Asuransi Lain	2	0	3	↑100%
5	JR	0	0	3	↑100%
Total Pasien		269	215	269	↑20%

3.3.2.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.2.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURA NSI	
1	Analisis capaian Juli 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami	Pasien Umum dalam 3 bulan	Pasien JKK 3 bulan terakhir pasien jkk mengalami	Pasien Asuransi dalam 3 bulan	Total pasien di lantai 2,3,4

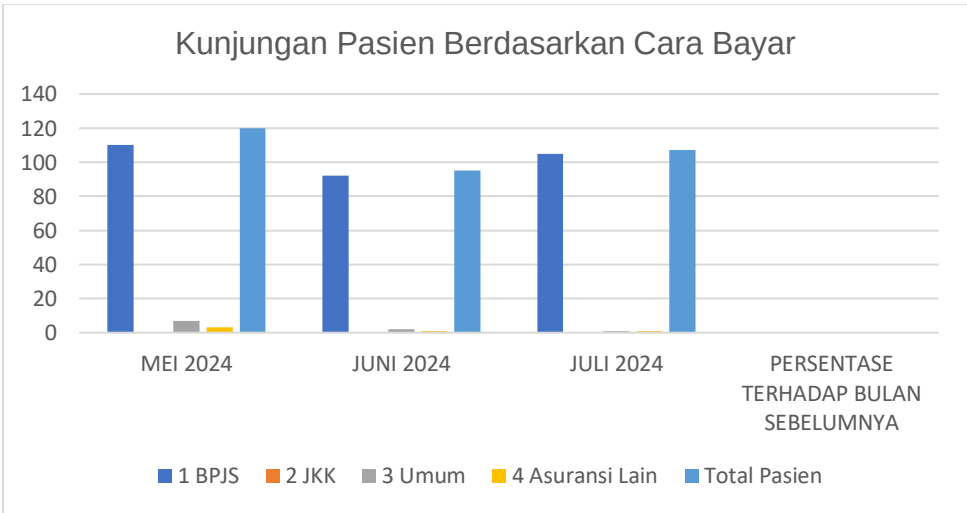
		peningkatan dan penurunan untuk bulan juli mengalami peningkatan 17,5%	terakhir terus meningkat meskipun 2 pasien	peningkatan	terakhir mengalami peningkatan 100%	mengalami peningkatan 20%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya, Selalu berkoordinasi dengan pihak managmen terlebih marketing untuk menjaring pasien baik dari pasien KLL maupun asuransi perusahaan				

3.3.2.4 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.3.2.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	110	92	105	↑ 12,3%
2	JKK	0	0	0	0
3	Umum	7	2	1	↓ 50%
4	Asuransi Lain	3	1	1	0%
Total Pasien		120	95	107	↑ 11,2%

3.3.2.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.2.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

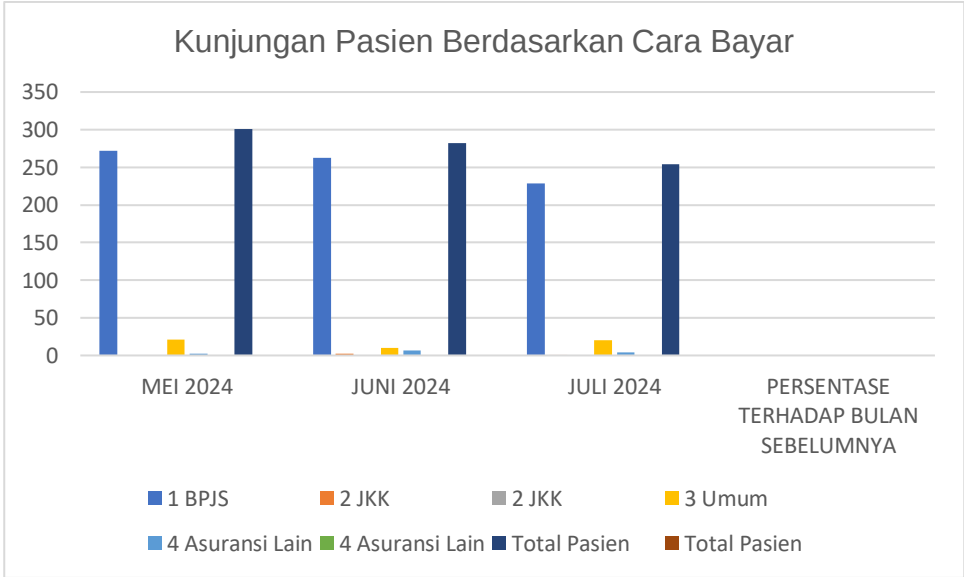
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir ini masih naik turun untuk bulan juli mengalami peningkatan 12,3%	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami naik turun untuk bulan juli mengalami penurunan 50%	Dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien JKK	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juli masih tetap dari bulan juni	Pada bulan juli jumlah pasien mengalami peningkatan 11,2 %
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan bagian manajemen terutama marketing untuk pasien asuransi dan pasien KLL yang ada di wilayah utara				

3.3.2.5 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.3.2.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	272	263	229	↓12,9%
2	JKK	0	2	1	↓ 50%
3	Umum	21	10	20	↑100%
4	Asuransi Lain	2	7	4	↓42%
Total Pasien		301	282	254	↓9,9%

3.3.2.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.2.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan sebanyak 12,9% dari bulan juni	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir masih naik turun untuk bulan juli 2024 mengalami peningkatan sebanyak 100%	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan 50% dari bulan juni	Pasien Asuransi / JR mengalami dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan juli mengalami penurunan sebanyak 42%	Total semua pasien mengalami penurunan di banding bulan juni 2024 sebanyak 9,9%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya, mengurangi jumlah komplain terkait pelayanan maupun keramahan perawat yang kurang bagus dalam melakukan etika				

3.3.2.6 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.3.2.6.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	170	146	145	↓ 0,68%
2	Umum	3	5	6	↑16,66%
3	JKK	0	0	0	0%
4	Asuransi	0	0	0	0%
Total Pasien		173	151	151	0%

3.3.2.6.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.2.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

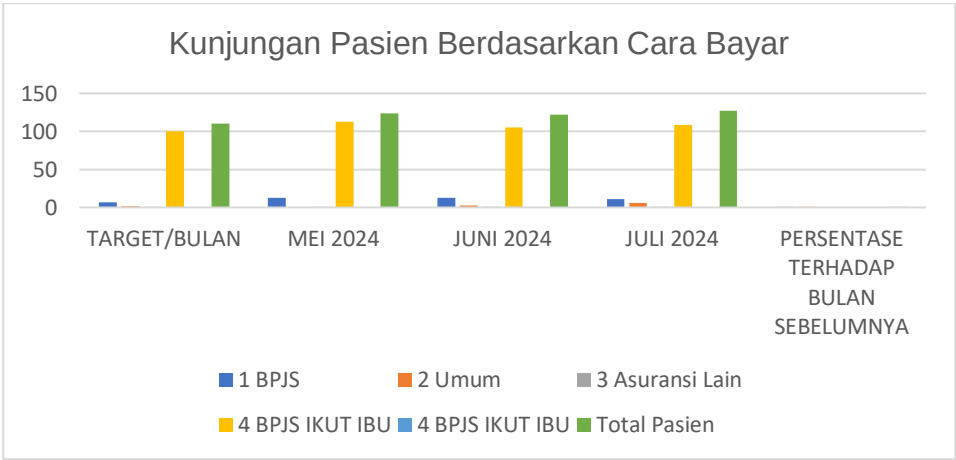
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Mei-Juli 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan secara terus-menerus untuk bulan juli mengalami penurunan 0,68%	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir selalu mengalami peningkatan secara terus-menerus untuk bulan juli mengalami peningkatan 16,6%	Tidak ada pasien JKK Mei	Tidak ada pasien asuransi di bulan Mei	Total pasien bulan juli tidak ada peningkatan dari bulan juni
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.3.2.7 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei- Juli 2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	13	13	11	↓15%
2	Umum	2	0	3	6	↑100%
3	Asuransi Lain	1	1	1	1	0%
4	BPJS IKUT IBU	100	113	105	109	↑3,6%
Total Pasien		110	124	122	127	↑4%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei- Juli 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

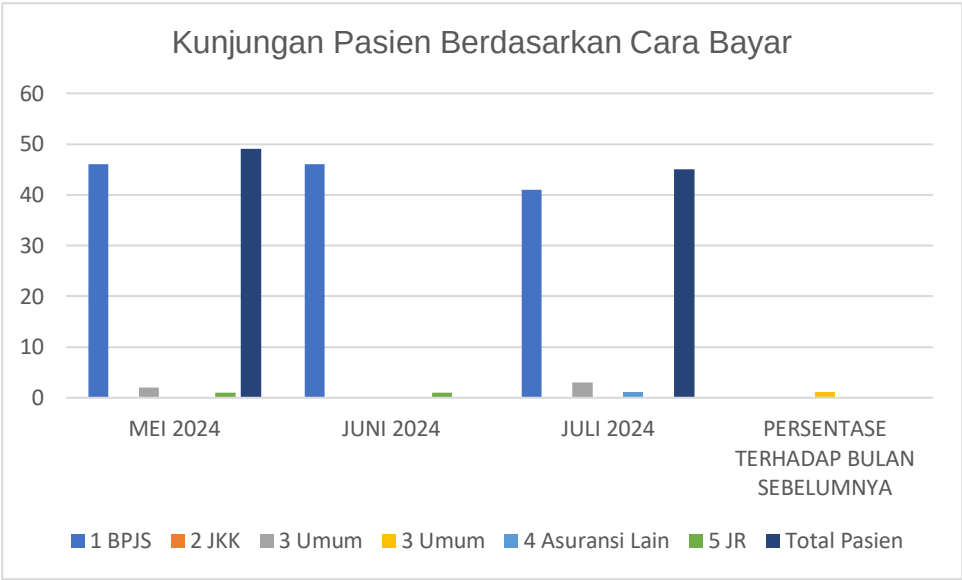
NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Juli 2024	11	6	1	109	127
	Analisa	Pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 15,4%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan bulan sebelumnya sebanyak 100%	Dalam 3 bulan terakhir kenaikan pasien tidak signifikan dan masih tetap seperti bulan sebelumnya	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 4%	Dalam 3 bulan terakhir pasien masih belum stabil masih naik turun
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	46	46	41	↓10,80%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	2	0	3	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	1	↑0%
5	JR	1	1	0	↓100%
Total Pasien		49	46(karena pasien jr+bpjs)	45	↓2,1%

3.3.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

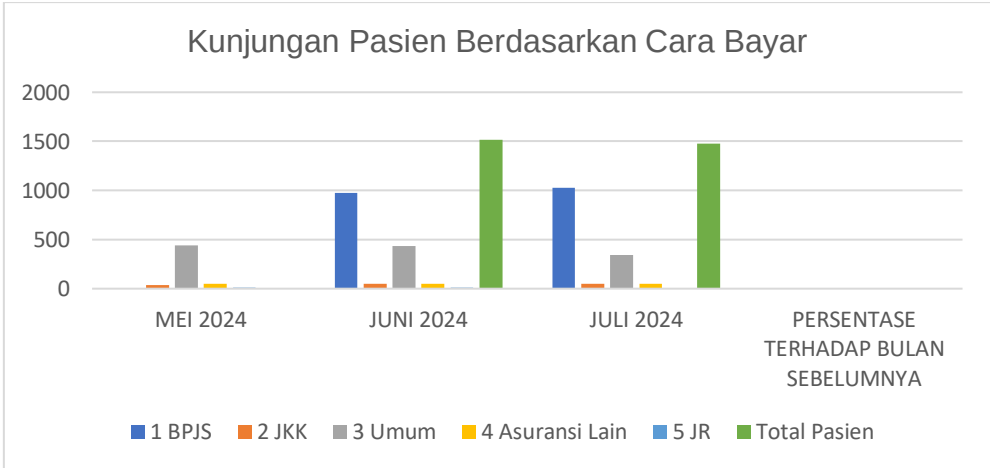
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juli mengalami 10,80%	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan juli 100%	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir tidak ada perubahan tetap 1 pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di ICU mengalami penurunan terus
2	RTL	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.3.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1.301	976	1025	↑4,7%
2	JKK	35	49	52	↑5,76%
3	Umum	440	432	343	↓25%
4	Asuransi Lain	51	49	51	↑3,92%
5	JR	9	10	6	↓66%
Total Pasien		1.861	1516	1477	↓2,6%

3.3.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2024)



3.3.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

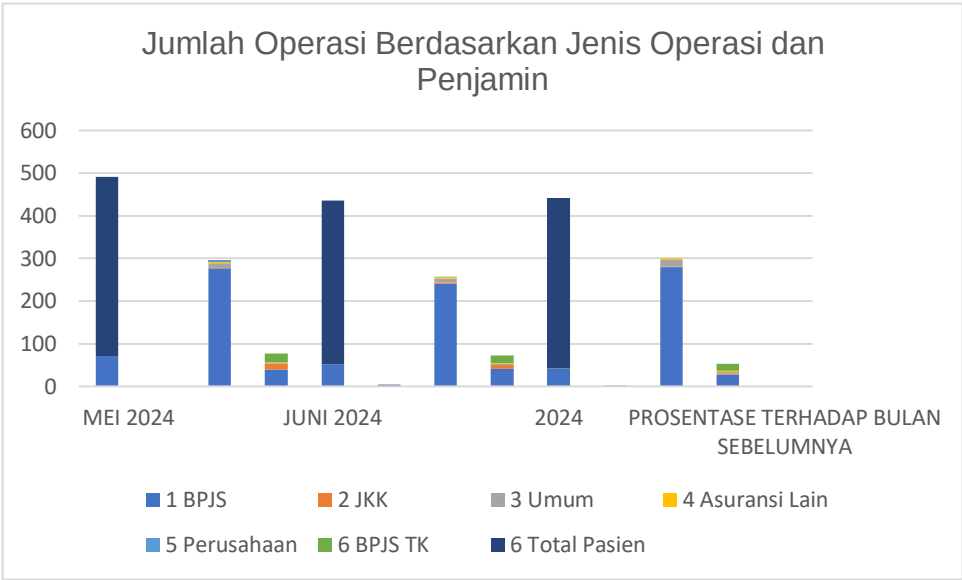
NO.	BULAN JULI	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan juli naik 4,7%	Kunjungan pasien UMUM 3 bulan terakhir turun untuk bulan juli turun 25%	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir selalu naik untuk bulan juli 5,76%	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih naik turun untuk bulan juli menurun 66%	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan mengalami penurunan di bulan juli 2024 mengalami penurunan 2,6%
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.3.5.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Mei -Juli 2024)

NO	HAL	MEI 2024				JUNI 2024				2024				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	71	0	27	40	5	3	24	41	42	2	280	28	
2	JKK	0	0	1	13	0	0	3	9	0	0	1	3	
3	Umum	0	0	12	1	0	1	9	3	0	0	17	2	
4	Asuransi Lain	0	0	3	2	0	0	3	2	1	0	3	4	
5	Perusahaan	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	0	21	0	0	1	18	0	0	0	16	
	Total Pasien	420				384				399				↑3,7%

3.1.1.1 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Mei -Juli 2024)



3.1.1.2 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami naik turun untuk bulan juli 2024 mengalami peningkatan dari bulan juni 2024 sebnyak 4,8%	Pasien BPJS TK mengalami penurunan dari bulan juni sebanyak 15,7%	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan selalu meningkat untuk bulan juli peningkatan 31,5%	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan juli mengalami penurunan 66,6%	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan juli 37,5%	Total pasien untuk bulan juli 2024 mengalami peningkatan sebanyak 3,7%
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada					

3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Mei- Juli 2024

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH SEDIAAN					
		MEI 2024		JUNI 2024		JULI 2024	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	996.346	2.798.211.553	819.115	2.593.871.439	836.069	3.131.198.853
	Sistem	996.419	2.797.062.885	827.882	2.613.227.305	0	0
	Selisih	73	+1.148.668	8.767	-11.866	836.069	+3.131.198.853
DEPO FARMASI	Fisik	161.916	588.267.127	136.177	513.147.816	141.263	656.152.980
	Sistem	162.503	561.320.647	129.153	493.659.843	0	0
	Selisih	541	26.946.480	7.024	+19.487.974	141.267	+656.152.980
IKO	Fisik	2.398	91.503.256	1.733	77.805.982	1.781	95.721.037
	Sistem	2.602	88.033.712	2.017	85.864.060	0	0
	Selisih	200	3.469.544	284	-8.058.077	1.781	+95.721.037
GUDANG RETUR	Fisik	102	87.437	0	0	0	0
	Sistem	471	543.360	257	243.021	0	0
	Selisih	369	-455.923	257	-243.021	0	0
Total Selisih		1.183	+31.108.769	16.332	+11.175.010	+979.117	+3.883.072.870

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Mei- Juli 2024



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +3.131.198.853, hal ini disebabkan karena :		
1.	Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian rak kertas kerja dengan rak pada SIMRS karena data yang diupload progamer belum sesuai data yang sudah di validasi oleh Kepala Instalasi Farmasi.	1. Koordinasi dengan Keuangan PT untuk update Rak di SIMRS.
2.	Masih ditemukan adanya barang peruntukan RS PHS yang tercantum pada kertas kerja RS PHM, master barang tidak ada, rak SIMRS tidak ada. Sebelum SO Kains Farmasi sudah menyetorkan data ke Grup Tim SO lembar kerja yang sesuai dengan fisik, dimana hasil validasi ditemukan master barang yang raknya tidak sesuai, master	1. Koordinasi dengan Pengadaan PT untuk non aktif master PHS, pembuatan master yang tidak ada, dan koordinasi dengan keuangan PT untuk update rak di SIMRS.

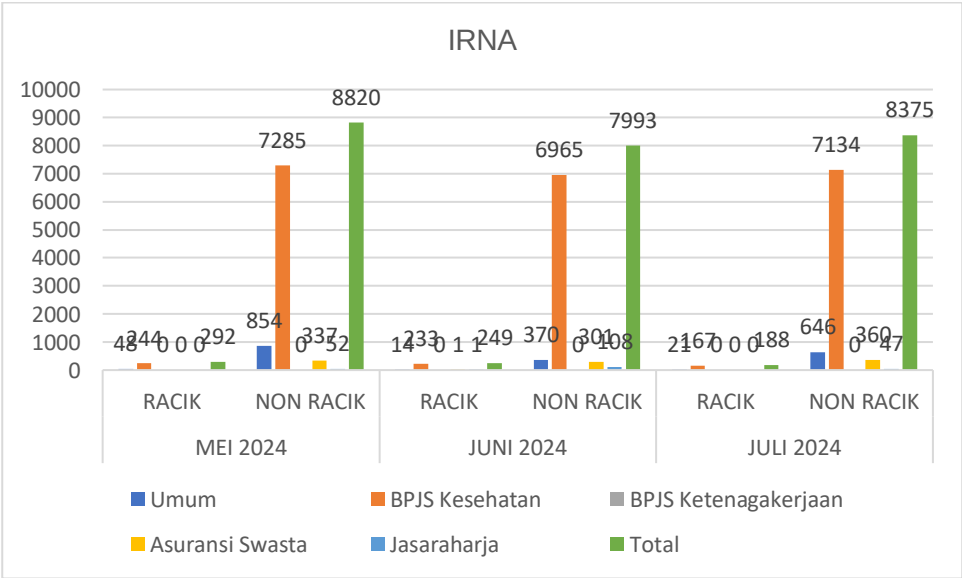
	barang double, master barang yang tidak ada.	
3.	Terdapat kesalahan dalam penginputan Acyclovir Tab 400 MG HJ dengan persediaan di Gudang Farmasi, selisih nilai persediaan 24 M.	1. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Nararya). 2. Progamer melakukan penyesuaian stok.
4.	Masih ditemukan petugas terlewat tidak input SO padahal sudah dilakukan perhitungan SO.	1. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Gadis, Adel). 2. Lakukan crosscheck data inputan stok opname oleh TTK lainnya. Lakukan validasi data oleh kepala instalasi setelah TTK input data stok opname.
5.	Masih ditemukan petugas salah input ED saat input SO padahal di lembar kerja tertulis masih ED jauh.	1. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Gadis, Adel, Nararya). 2. Lakukan crosscheck data inputan stok opname oleh TTK lainnya. 3. Lakukan validasi data oleh Kepala Instalasi setelah TTK input data stok opname.
Depo Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +656.152.980, hal ini disebabkan karena :		
1.	Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian rak kertas kerja dengan rak pada SIMRS karena data yang diupload progamer belum sesuai data yang sudah di validasi oleh Kepala Instalasi Farmasi.	Koordinasi dengan keuangan PT untuk update Rak di SIMRS.
2.	Masih ditemukan adanya barang peruntukan RS PHS yang tercantum pada kertas kerja RS PHM, master barang tidak ada, rak SIMRS tidak ada. Sebelum SO Kains sudah menyetorkan data ke Grup Tim SO lembar kerja yang sesuai dengan fisik, dimana hasil validasi ditemukan master barang yang raknya tidak sesuai, master barang double, master barang yang tidak ada.	Koordinasi dengan Pengadaan PT untuk non aktif master PHS, pembuatan master yang tidak ada, dan kains koordinasi dengan keuangan PT untuk update rak di SIMRS.
3.	Kartu stok pada rak obat tetes mata tidak berjalan.	Menegur petugas untuk rutin menuliskan kartu stok (teguran tertulis).
4.	Terdapat 1 flash asering 500 ML dengan kondisi barang rusak.	Dilakukan penyesuaian stok karena cairan sudah berkurang dari awal dos dibuka/ Barang substandar.
5.	Masih ditemukan petugas terlewat tidak input SO padahal sudah dilakukan perhitungan SO.	1. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Achmad, Sherlina, Susanti, Defi, Dessy, Aris, Niken, Lolita, Guspa, Septi, Aulia, Faiq, Muva, Fika, Maulana, Poppy, Shafa, Anjani, Fadiyah). 2. Lakukan crosscheck data inputan stok opname oleh TTK lainnya. 3. Lakukan validasi data oleh kepala instalasi setelah TTK input data stok opname.
6.	Masih ditemukan petugas salah input ED saat input SO padahal di lembar kerja tertulis masih ED jauh.	1. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Ferra A., Maulana, Poppy, Shafa, Anjani, Fadiyah, Sherlina). 2. Lakukan croscek data inputan stok opname oleh TTK lainnya. Lakukan validasi data oleh kepala instalasi setelah TTK input data stok opname.
Instalasi Kamar Operasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +95.721.037, hal ini disebabkan karena :		
1.	Masih ditemukan petugas terlewat tidak input SO padahal sudah dilakukan perhitungan SO.	1. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Ferra A.). 2. Lakukan croscheck data inputan stok opname oleh TTK lainnya.

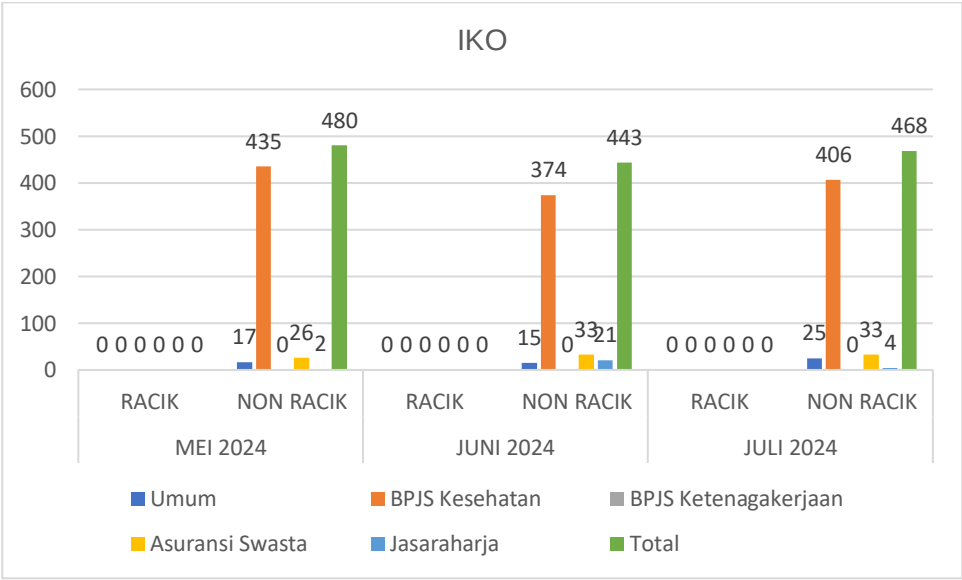
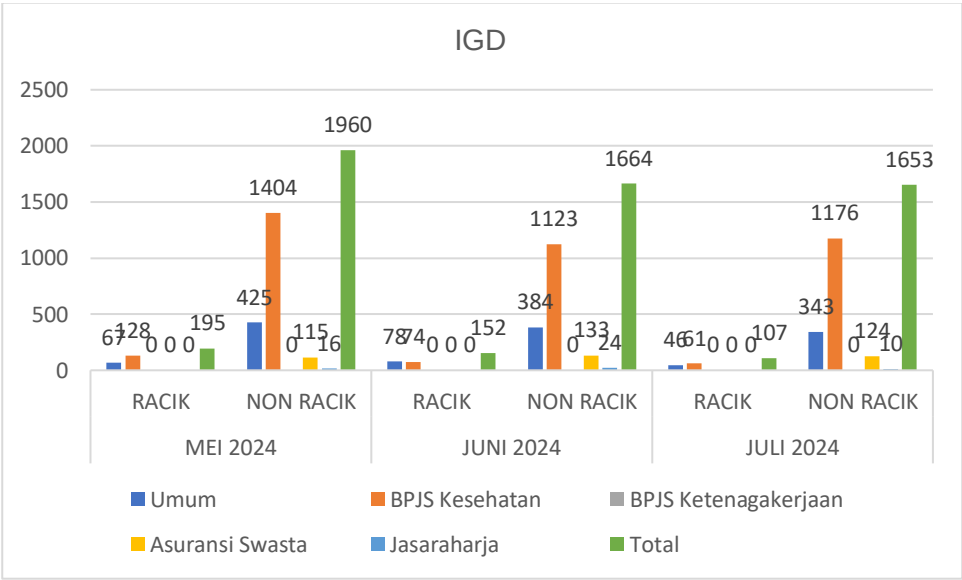
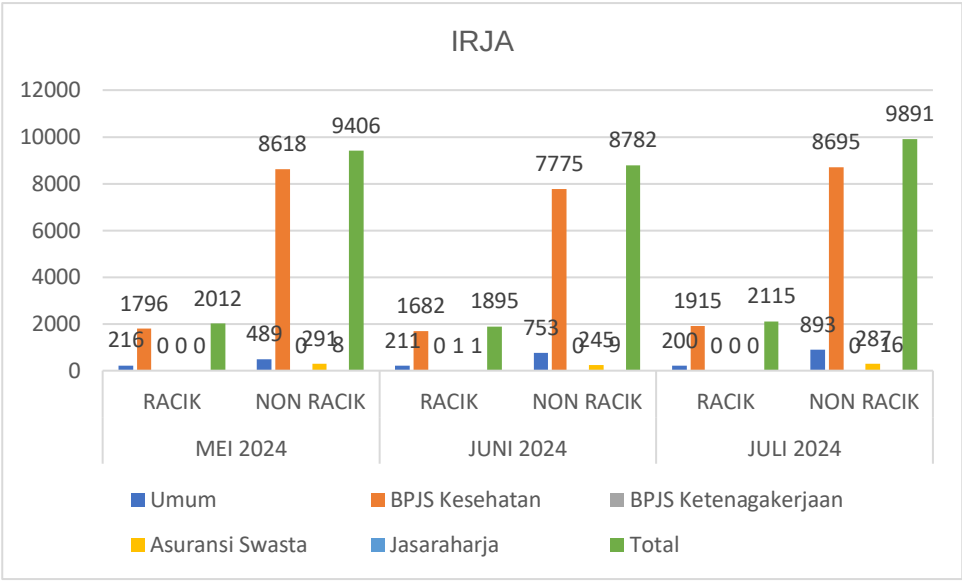
		3. Lakukan validasi data oleh kepala instalasi setelah TTK input data stok opname.
2.	Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian rak kertas kerja dengan rak pada SIMRS karena data yang diupload progamer belum sesuai data yang sudah di validasi oleh Kepala Instalasi Farmasi.	1. Koordinasi dengan Keuangan PT untuk update Rak di SIMRS.
Gudang Retur Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah mencapai target, namun masih ada kendala saat stok opname yaitu :		
1.	Tidak terdapat rak gudang retur.	Penyesuaian centralisasi master barang.

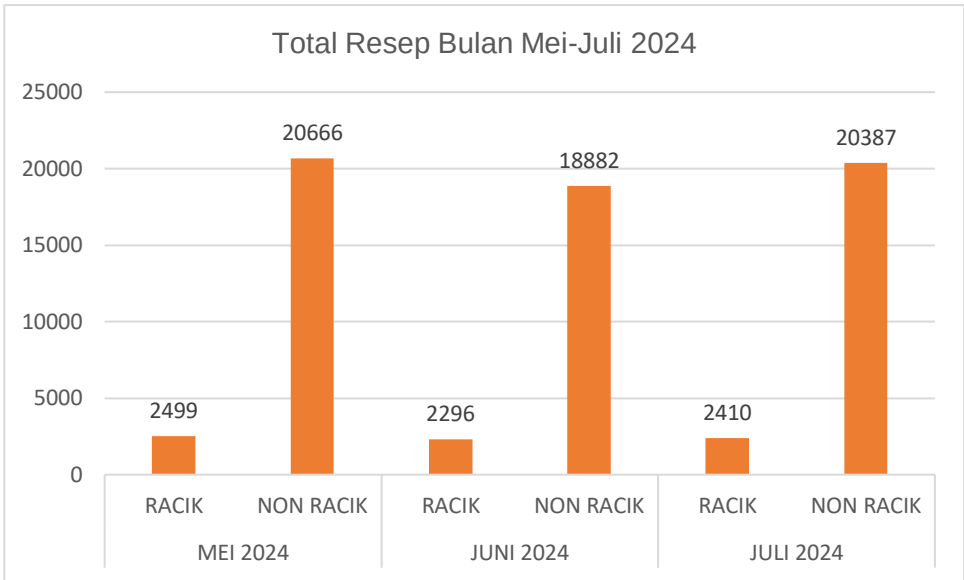
3.2.1.4 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Mei- Juli 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN/JENIS RESEP					
			MEI 2024		JUNI 2024		JULI 2024	
			RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1.	IRNA	Umum	48	854	14	370	21	646
		BPJS Kesehatan	244	7285	233	6965	167	7134
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	337	1	301	0	360
		Jasaraharja	0	52	1	108	0	47
Total			292	8820	249	7993	188	8375
2.	IRJA	Umum	216	489	211	753	200	893
		BPJS Kesehatan	1796	8618	1682	7775	1915	8695
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	291	1	245	0	287
		Jasaraharja	0	8	1	9	0	16
Total			2012	9406	1895	8782	2115	9891
3.	IGD	Umum	67	425	78	384	46	343
		BPJS Kesehatan	128	1404	74	1123	61	1176
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	115	0	133	0	124
		Jasaraharja	0	16	0	24	0	10
Total			195	1960	152	1664	107	1653
4.	IKO	Umum	0	17	0	15	0	25
		BPJS Kesehatan	0	435	0	374	0	406
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	26	0	33	0	33
		Jasaraharja	0	2	0	21	0	4
Total			0	480	0	443	0	468
Total Resep			2499	20666	2296	18882	2410	20387

3.1.1.1 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Mei-Juli 2024







Analisis :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah resep racik dan non racik di Bulan Juli 2024. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien di Rawat Jalan dan Rawat Inap. Kunjungan pasien umum pada Bulan Juli 2024 meningkat jika dibandingkan Bulan Juni 2024.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di social media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.

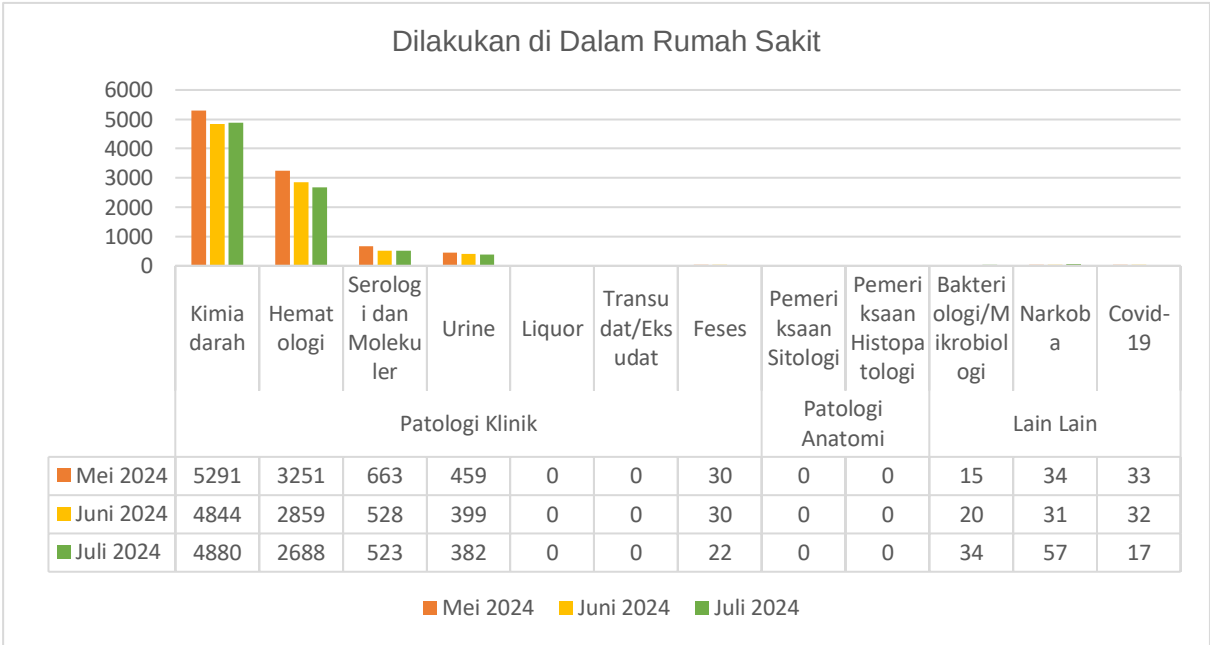
3.1.2 Laboratorium

3.1.2.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Mei - Juli 2024

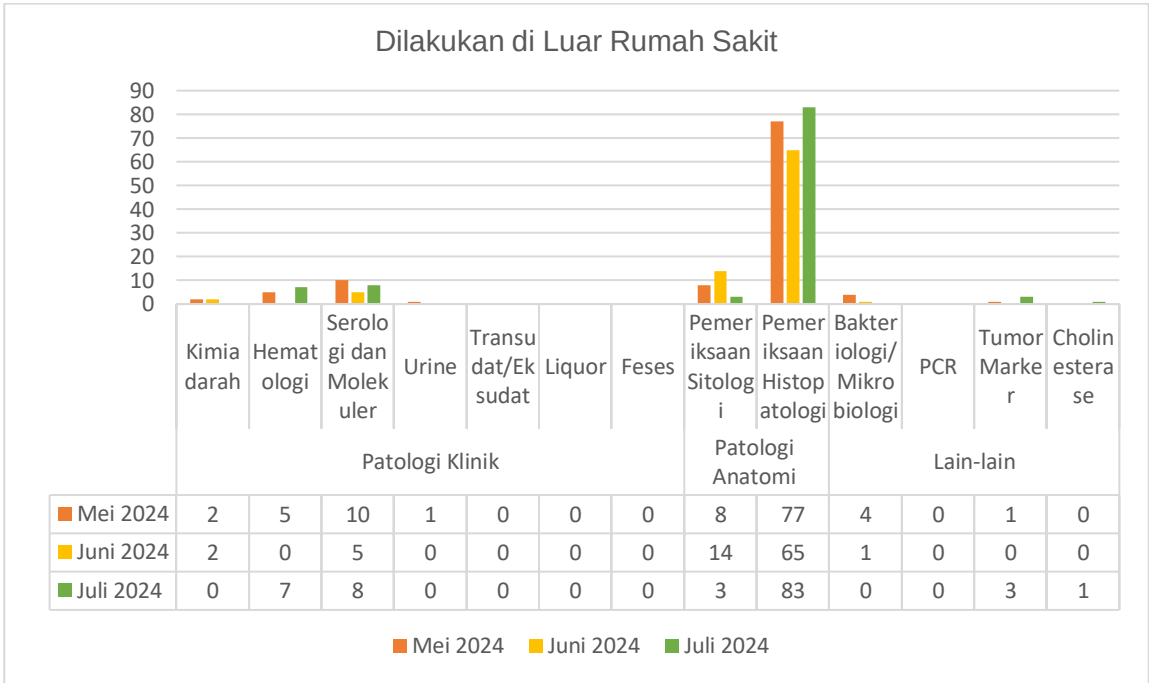
NO	JENIS PEMERIKSAAN	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
Dilakukan di RS				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	5291	4844	4880
	Hematologi	3251	2859	2688
	Serologi dan Molekuler	663	528	523
	Urine	459	399	382
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	30	30	22
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	15	20	34
4.	Narkoba	34	31	57
5.	Covid-19	33	32	17
Dirujuk				
1.				
	Kimia darah	2	2	0
	Hematologi	5	0	7
	Serologi dan Molekuler	10	5	8
	Urine	1	0	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	0	0	0

2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	8	14	3
	Pemeriksaan Histopatologi	77	65	83
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	4	1	0
4.	PCR	0	0	0
5.	Tumor Marker	1	0	3

3.1.2.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit



3.1.2.3 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit



Analisis :

- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, rincian Bulan Juli 2024 yaitu :
 - Patologi Anatomi : 86 sampel
 - Patalogi Klinik : 15 sampel
 - Tumor Marker : 3 sampel
 - Cholinesterase : 1 sampel

- e) Bakteri/Mikrobiologi : 0 sampel
2. Terjadi peningkatan pemeriksaan narkoba di Bulan Juli 2024, hal ini disebabkan sudah ada reagen pemeriksaan narkoba dengan 7 parameter.

Rencana Tindak Lanjut

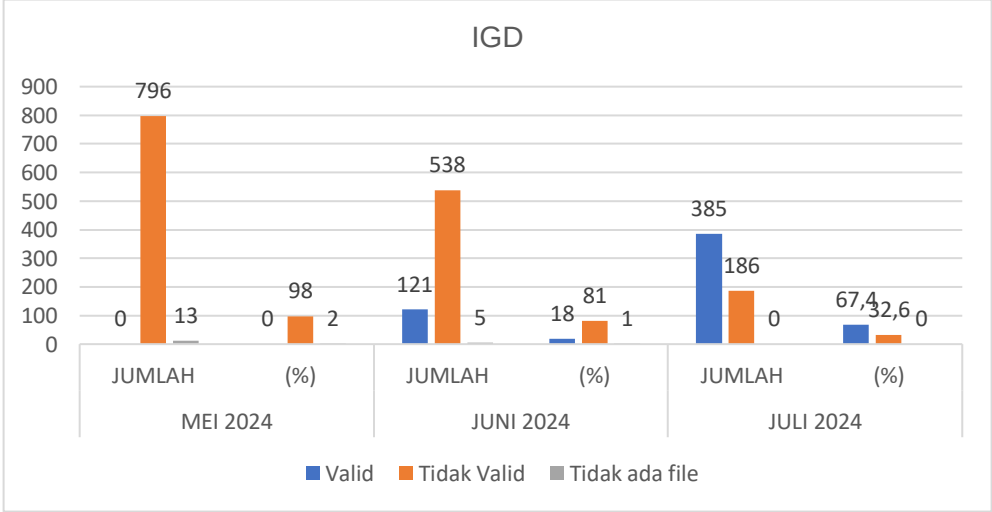
1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang, untuk mengurangi jumlah rujukan dan meningkatkan pendapatan.
2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
3. Perbaiki serah terima hasil laboratorium menggunakan sistem digital.

3.1.3 Rekam Medis – Pendaftaran

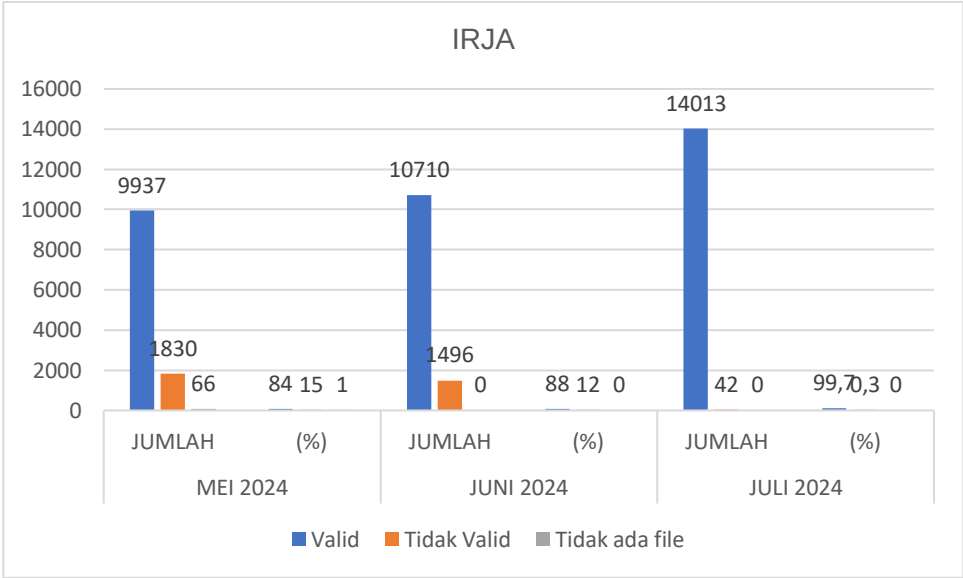
3.1.3.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Mei - Juli 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			MEI 2024		JUNI 2024		JULI 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	0	0	121	18	385	67,4
		Tidak Valid	796	98	538	81	186	32,6
		Tidak ada file	13	2	5	1	0	0
Total			809		664		571	
2.	IRJA/POLI	Valid	9937	84	10710	88	14013	99,7
		Tidak Valid	1830	15	1496	12	42	0,3
		Tidak ada file	66	1	0	0	0	0
Total			11833		12206		14055	

3.1.3.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Mei - Juli 2024



3.1.3.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Mei - Juli 2024



Analisis :

- 1. Terjadi kenaikan signifikan pada data valid di IGD sebanyak 385 Data E-RM dari 571 Data E-RM atau sebesar 67.4%, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyetoran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD.
- 2. Masih ditemukan 32.6% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis, setelah ditelusur sudah pengkajian awal IGS sudah diisi lengkap tetapi tidak terbaca, system bermasalah.
- 3. Terjadi penurunan data tidak valid di IRJA, hal ini juga disebabkan adanya perubahan alur penyetoran casemix/data kunjungan pasien per hari, data valid sudah mencapai 99.7%.

Masalah :

- 1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
- 2. Ada beberapa tanda tangan pasien belum muncul.
- 3. Pada fitur “keadaan umum” di lembar triage pengkajian awal medis igd muncul di Billing rekam medis, tetapi di Billing IGD tidak muncul.
- 4. Berikut link permasalahan yang ditemui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

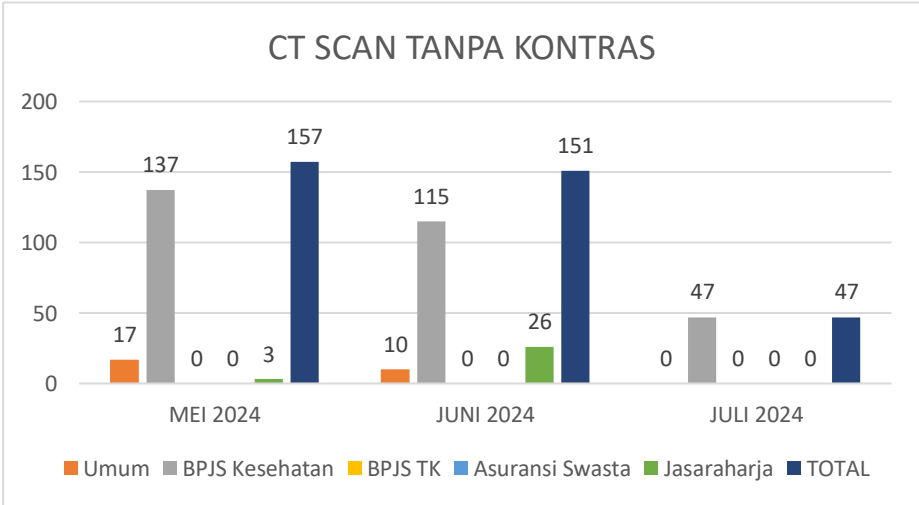
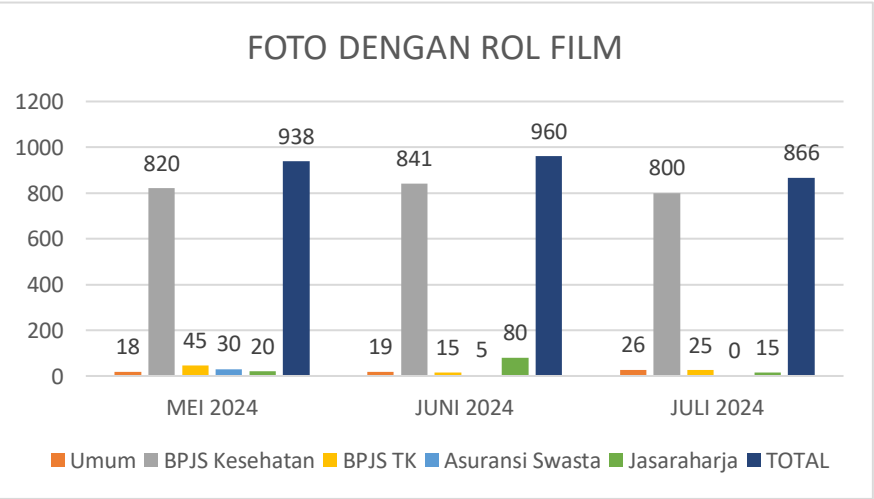
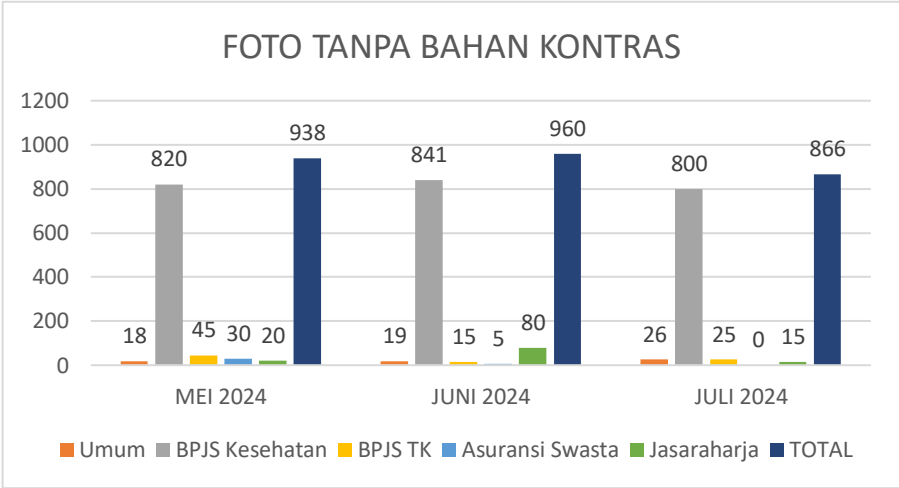
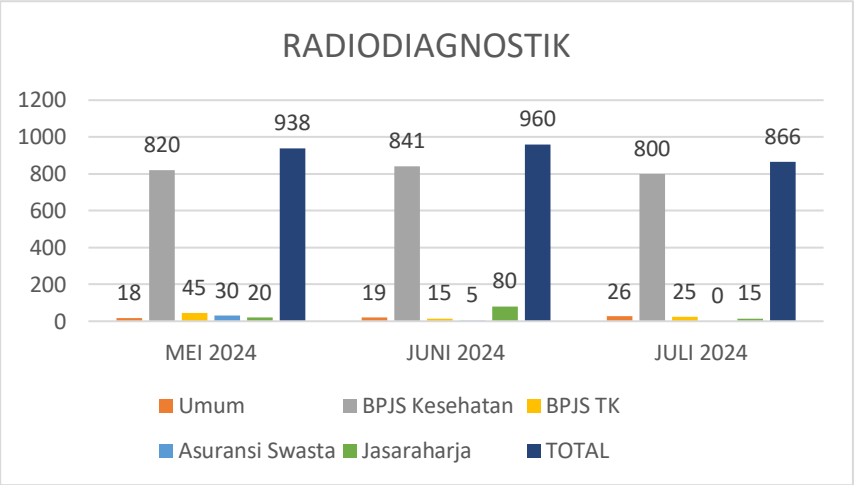
- 1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
- 2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- 3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

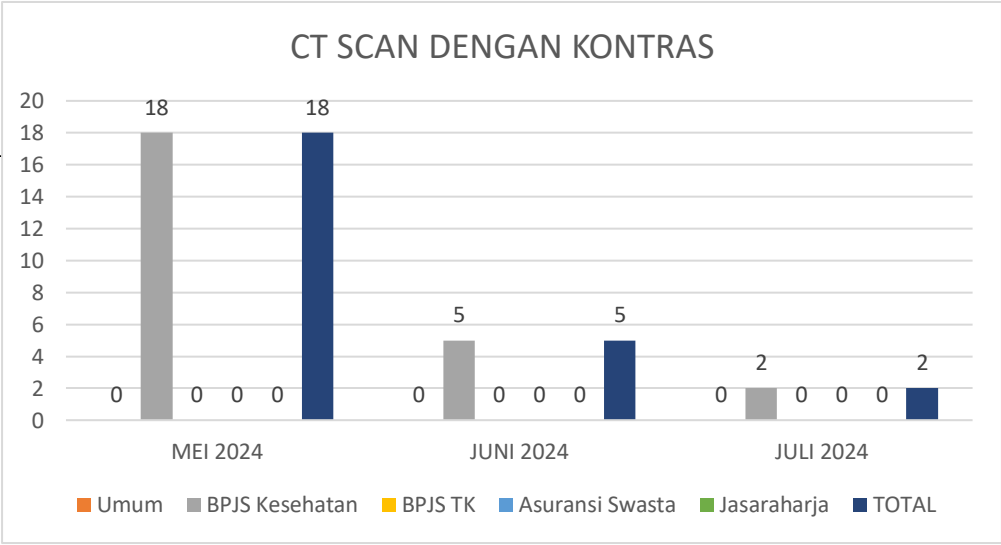
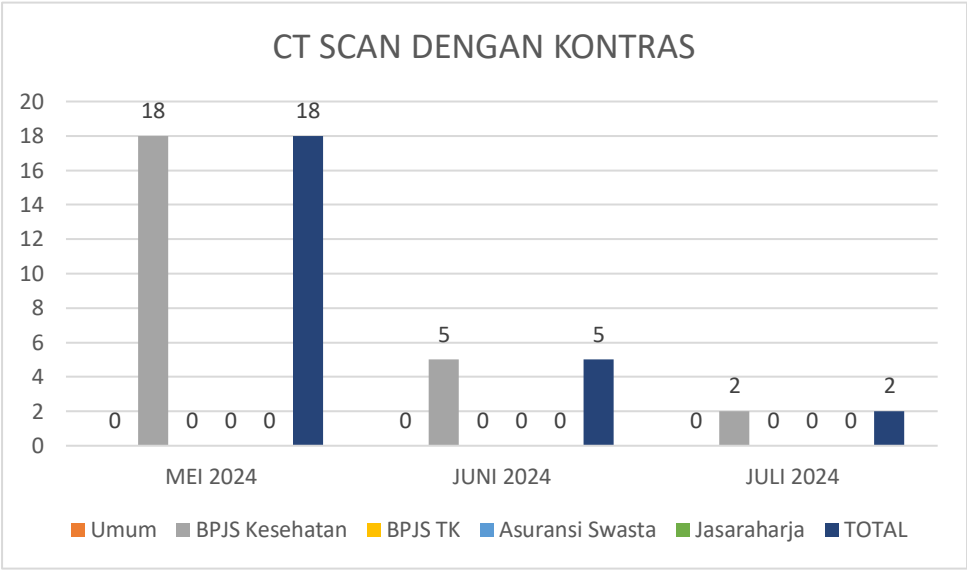
3.1.4 Radiologi

3.1.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Mei - Juli 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Radiodiagnostik	Umum	18	19	26
		BPJS Kesehatan	820	841	800
		BPJS TK	45	15	25
		Asuransi Swasta	30	5	0
		Jasaraharja	20	80	15
	TOTAL				938
2	Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	18	19	26
		BPJS Kesehatan	820	841	800
		BPJS TK	45	15	25
		Asuransi Swasta	30	5	0
		Jasaraharja	20	80	15
	TOTAL				938
3	Foto Dengan Rol Film	Umum	18	19	26
		BPJS Kesehatan	820	841	800
		BPJS TK	45	15	25
		Asuransi Swasta	30	5	0
		Jasaraharja	20	80	15
	TOTAL				938
4	CT Scan Tanpa Kontras	Umum	17	10	0
		BPJS Kesehatan	137	115	47
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	3	26	0
	TOTAL				157
5	CT Scan Dengan Kontras	Umum	0	0	0
		BPJS Kesehatan	18	5	2
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	0	0	0
	TOTAL				18
6	USG Tanpa Kontras	Umum	24	38	24
		BPJS Kesehatan	217	160	250
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	10
		Jasaraharja	0	0	0
	TOTAL		241	198	241

3.1.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Mei - Juli 2024





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - a. Radiodiagnostik : 866
 - b. USG Tanpa Kontras : 284
 - c. CT Scan Tanpa Kontras : 47
2. Pada Bulan Juli 2024 pemeriksaan CT Scan mengalami penurunan secara signifikan, hal ini disebabkan karena alat CT Scan rusak.
3. Jumlah pemeriksaan CT Scan yang dirujuk sebagai berikut :
 - a. RSUD Lawang : 28 pasien
 - b. RSPH Sukorejo : 16 pasien
4. Pasien yang membutuhkan pemeriksaan CT Scan di Poli Spesialis dijadwalkan menunggu kondisi CT Scan PHM bisa digunakan, kecuali kondisi pasien cito.

Rencana Tindak Lanjut :

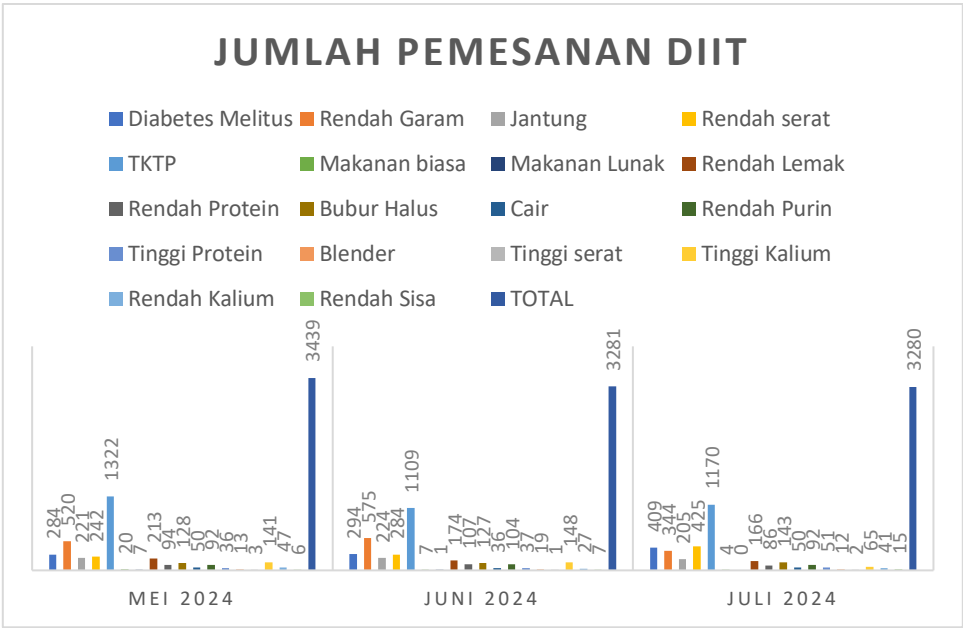
- 1. Koordinasi dengan ATEM PT untuk pengajuan hardware baru demi menunjang pelayanan yang komprehensif.
- 2. Koordinasi dengan IPSRS untuk melakukan pemeliharaan alat secara berkala.
- 3. Koordinasi dengan Humas&Marketing untuk melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan, jika CT Scan sudah bisa digunakan.

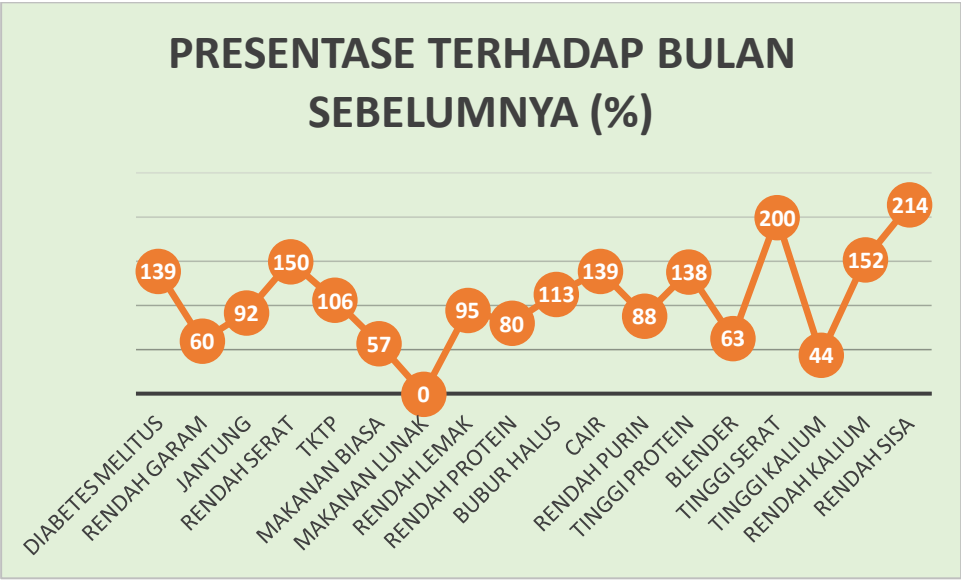
3.4.5 Gizi

3.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Mei - Juli 2024

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIIT			PRESENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024	
1	Diabetes Melitus	284	294	409	139
2	Rendah Garam	520	575	344	60
3	Jantung	221	224	205	92
4	Rendah serat	242	284	425	150
5	TKTP	1322	1109	1170	106
6	Makanan biasa	20	7	4	57
7	Makanan Lunak	7	1	0	0
8	Rendah Lemak	213	174	166	95
9	Rendah Protein	94	107	86	80
10	Bubur Halus	128	127	143	113
11	Cair	50	36	50	139
12	Rendah Purin	92	104	92	88
13	Tinggi Protein	36	37	51	138
14	Blender	13	19	12	63
15	Tinggi serat	3	1	2	200
16	Tinggi Kalium	141	148	65	44
17	Rendah Kalium	47	27	41	152
18	Rendah Sisa	6	7	15	214
TOTAL		3439	3281	3280	100

3.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Mei - Juli 2024





Analisis :

Dari grafik jumlah pemesanan diit diatas, jumlah pemesanan stabil dalam 2 bulan terakhir. Jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP dan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien rawat inap yang tidak signifikan.

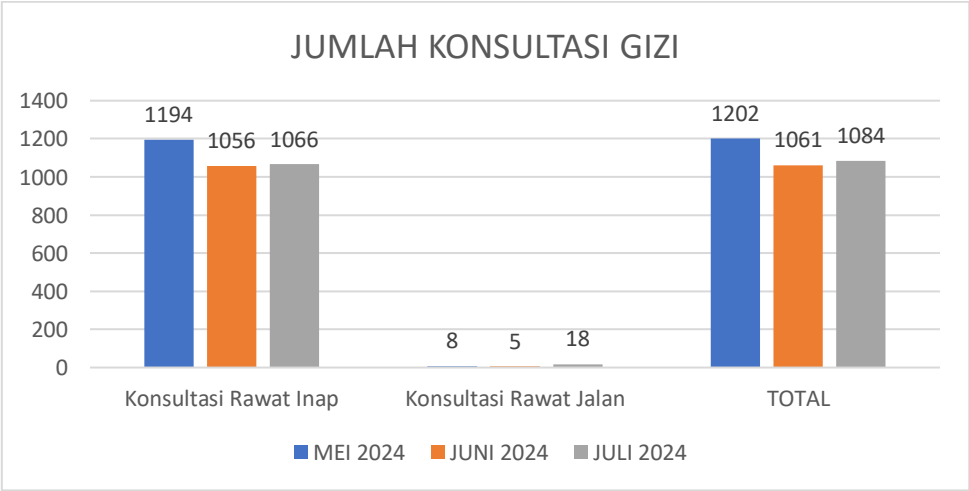
Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan, hanya saja ada 2 pasien complain pada menu rawon yang tidak ditemukan protein hewani.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
 3. Mengajukan protein hewani pada menu rawon ke PT.

3.4.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi Mei - Juli 2024

NO	INDIKASI	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Konsultasi Rawat Inap	1194	1056	1066
2	Konsultasi Rawat Jalan	8	5	18
Total		1202	1061	1084

3.4.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi Mei - Juli 2024



Analisis :

- 1. Data jumlah konsultasi gizi pada pasien rawat inap stabil, konsultasi rawat inap tidak kurang dari 1000.
- 2. Data jumlah konsultasi gizi pada rawat jalan mengalami peningkatan, yaitu 18 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU Gizi.
- 3. Menjalankan Prima Health Meals.

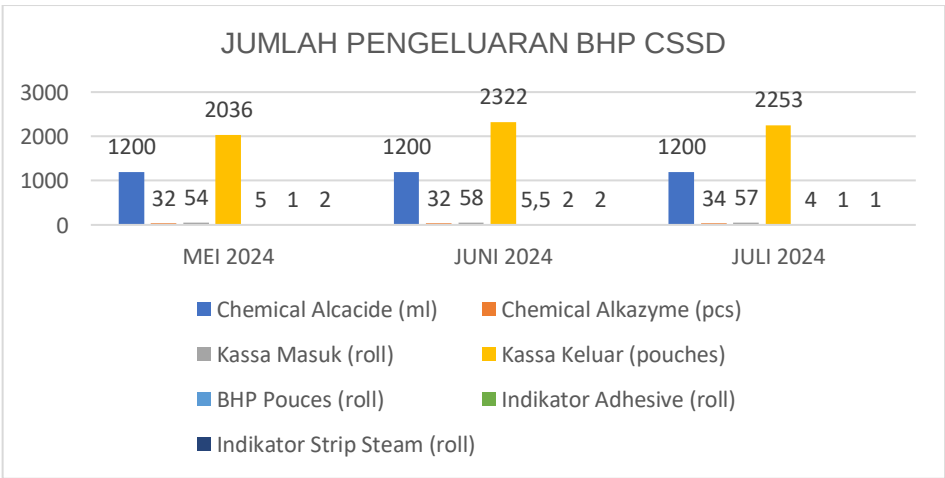
3.4.6 CSSD – Laundry

3.4.6.1 CSSD

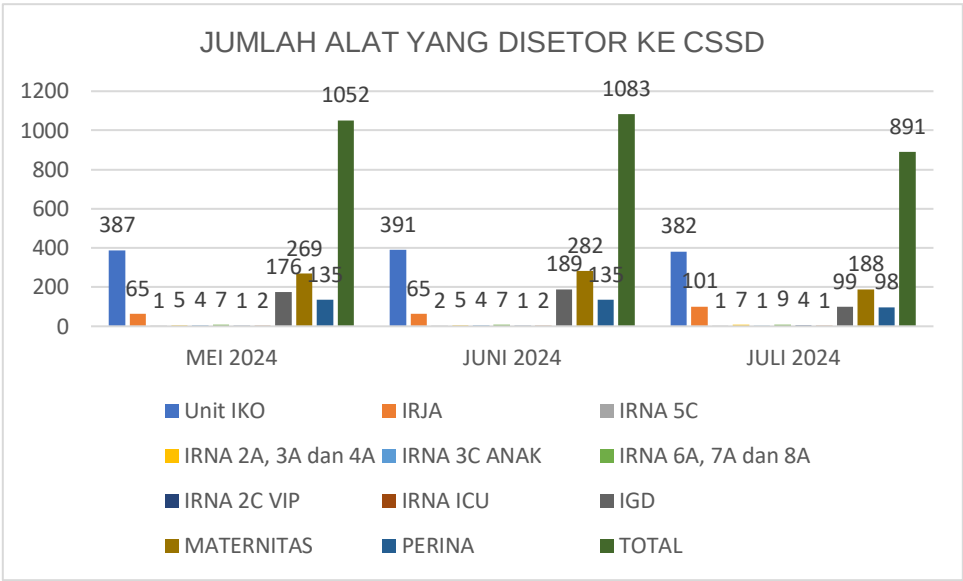
3.4.6.1.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan Mei - Juli 2024

NO	HAL	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
BHP				
1	Chemical Alcalide (ml)	1200	1200	1200
2	Chemical Alkazyme (pcs)	32	32	34
3	Kassa Masuk (roll)	54	58	57
4	Kassa Keluar (pouches)	2036	2322	2253
5	BHP Pouces (roll)	5	5.5	4
6	Indikator Adhesive (roll)	1	2	1
7	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	1
Alat yang disetor (set)				
8	Unit IKO	387	391	382
9	IRJA	65	65	101
10	IRNA 5C	1	2	1
11	IRNA 2A, 3A dan 4A	5	5	7
12	IRNA 3C ANAK	4	4	1
13	IRNA 6A, 7A dan 8A	7	7	9
14	IRNA 2C VIP	1	1	4
15	IRNA ICU	2	2	1
16	IGD	176	189	99
17	MATERNITAS	269	282	188
18	PERINA	135	135	98
Jumlah		1052	1083	891

3.4.6.1.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan Mei - Juli 2024



3.4.6.1.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan Mei – Juli 2024



Analisis :

- 1. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terkahir yaitu sejumlah 1.160 set, diikuti dari Unit Maternitas 739 set dan IGD 464 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
- 2. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.

Rencana Tindak Lanjut :

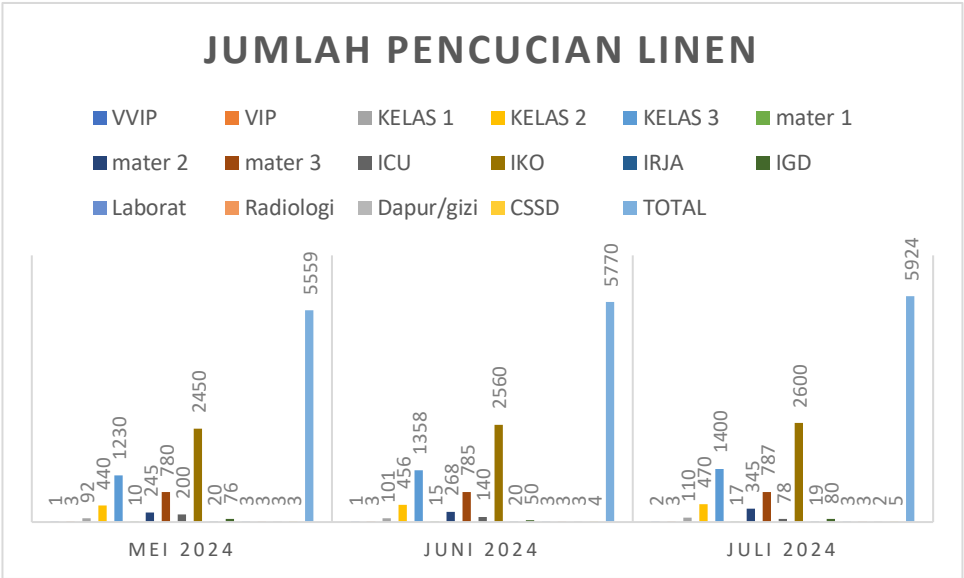
- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
- 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
- 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.

3.4.6.2 Laundry

3.4.6.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Mei - Juli 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN (KG)		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	VVIP	1	1	2
2	VIP	3	3	3
3	KELAS 1	92	101	110
4	KELAS 2	440	456	470
5	KELAS 3	1230	1358	1400
6	mater 1	10	15	17
7	mater 2	245	268	345
8	mater 3	780	785	787
9	ICU	200	140	78
10	IKO	2450	2560	2600
11	IRJA	20	20	19
12	IGD	76	50	80
13	Laborat	3	3	3
14	Radiologi	3	3	3
15	Dapur/gizi	3	3	2
16	CSSD	3	4	5
TOTAL		5559	5770	5924

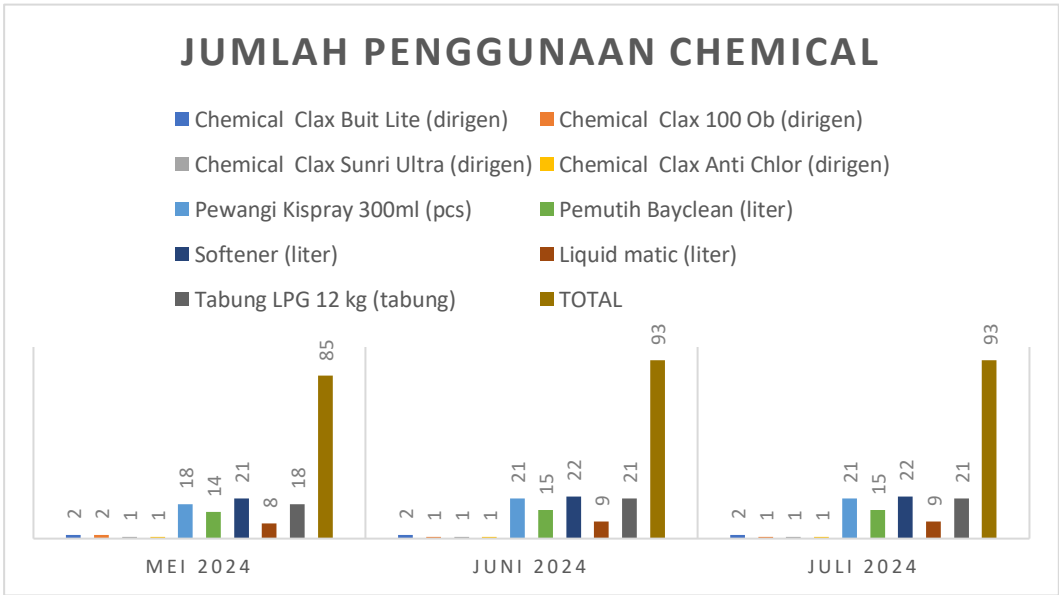
3.4.6.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Mei - Juli 2024



3.4.6.2.3 Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan Mei - Juli 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	2	2
2	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	2	1	1
3	Chemical Clax Sunri Ultra (dirigen)	1	1	1
4	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1
5	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	18	21	21
6	Pemutih Bayclean (liter)	14	15	15
7	Softener (liter)	21	22	22
8	Liquid matic (liter)	8	9	9
9	Tabung LPG 12 kg (tabung)	18	21	21
TOTAL		85	93	93

3.4.6.2.4 Grafik Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan Mei – Juli 2024



Analisa :

- 1. Terdapat peningkatan jumlah pencucian linen dari bulan sebelumnya sebanyak 154kg berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien rawat inap, tidak sebanding dengan penggunaan chemical yang tidak mengalami peningkatan.
- 2. Dalam 3 bulan terakhir jumlah pencucian linen terbanyak dari Unit IKO mencapai rata-rata angka 2500kg setiap bulannya, hal ini disebabkan jumlah operasi per hari bisa mencapai diatas 5 operasi dengan operator yang berbeda dan diikuti dari ruang perawatan kelas 3, yaitu mencapai rata-rata angka 1400kg setiap bulannya.
- 3. Pencatatan penimbangan linen menggunakan timbangan beras masih manual, resiko angka tidak terbaca dengan baik, sehingga jumlah yang dihasilkan tidak valid.

Rencan Tindak Lanjut :

- 1. Rencana akan dilakukan permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan.
- 2. Rencana akan dilakukan pencatatan menggunakan google spreadsheet per hari nya.

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan

3.5.5 SDM

3.5.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	6	1	5	1
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	SMK	42	5	0	5	0
		D3 Farmasi		20	4	16	0
		S1 Apoteker		12	0	12	0
		S1 Farmasi		3	0	3	0
		S1 Analisis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		S1 Ekonomi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	SMA	11	1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		D3 Kesehatan		3	0	3	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 RMIK		5	0	5	0
10	CSSD	SMK	5	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	3	2	1	0
		D3 Kesehatan		0	0	0	1
		S1 Terapi Wicara		1	0	1	0
12	Gizi	SMP	17	2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0

		D3 Gizi		2	2	0	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
13	Humas & Marketing	S1 Kesehatan Masyarakat	2	1	0	1	0
		Profesi Ners		1	0	0	0
14	ICU dan HCU	D3 Keperawatan	12	5	1	4	0
		Profesi Ners		6	4	2	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
15	IGD	D3 Kebidanan	27	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		5	0	5	0
		D3 Keperawatan		9	0	9	0
		D4 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		7	1	6	0
16	IKO	D3 Kebidanan	12	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		3	1	2	0
		Profesi Ners		8	3	5	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRs	D3 TEM	6	1	0	1	0
		SKM		1	0	1	0
		S1 Teknik		1	0	1	0
		SMA		3	1	2	0
19	IRJA	D3 Kebidanan	27	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	4	4	0
20	IRNA 2C	D3 Keperawatan	7	2	0	2	0
		Profesi Ners		5	1	4	0
21	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	24	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		8	0	8	0
22	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
23	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	19	14	0	14	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
24	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	5	0	5	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
25	Maternitas	D3 Kebidanan	11	7	7	1	1
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		Profesi Bidan		2	0	2	0
26	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
27	Keuangan dan Akuntansi	SMA	10	4	1	3	0
		S1		5	3	2	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
28	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
29	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
30	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	3	6	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
32	Pendaftaran	SMA	15	6	1	5	0
		D3 RMIK		4	2	2	0

		D3 Kesehatan		2	0	2	0
		S1 Sosial		1	0	1	0
		D4 Manajemen		2	0	2	0
33	PIPP	Ners	6	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
38	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	3	3	0	3	0
39	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMP	44	3	1	2	0
		SMA		41	5	36	0
41	Security	SMA	12	12	6	6	0
42	Driver	SMA	5	5	1	4	0
43	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Syaraf		4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Paru		3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		3	3	0	3	0
48	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Bedah		4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
51	Dokter Spesialis Bedah Syaraf		1	1	0	1	0
52	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3	0	3	0
52	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
53	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
54	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
55	Dokter Spesialis Mata		3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Obstetry Ginekology		4	3	0	3	1
59	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0

60	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis THT		2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Radiologi		2	2	0	2	0
TOTAL			449				

Keterangan :
 Pada bulan Juli 2024 terdapat pengurangan jumlah staff, antara lain satu Dokter IGD, satu Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan satu staff Unit Rehab Medik (Fisioterapi). Selain itu terdapat penambahan jumlah satu staff di unit Gizi (Penyaji) dan satu staff pengganti Fisioterapis.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGA N	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Terapi Wicara	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis wicara	Menghubungi sosial media komunitas terapis wicara, menghubungi kampus dengan jurusan terapis wicara
3	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1		Share informasi di media social dan grup alumni
4	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1		Share informasi di media social dan grup alumni
5	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1		Share informasi di media social dan grup alumni

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	01 Juli 2024	Orientasi Khusus	Yanti	SMK	Penyaji	01 Juli 2024	-

3.5.1.4 Diklat

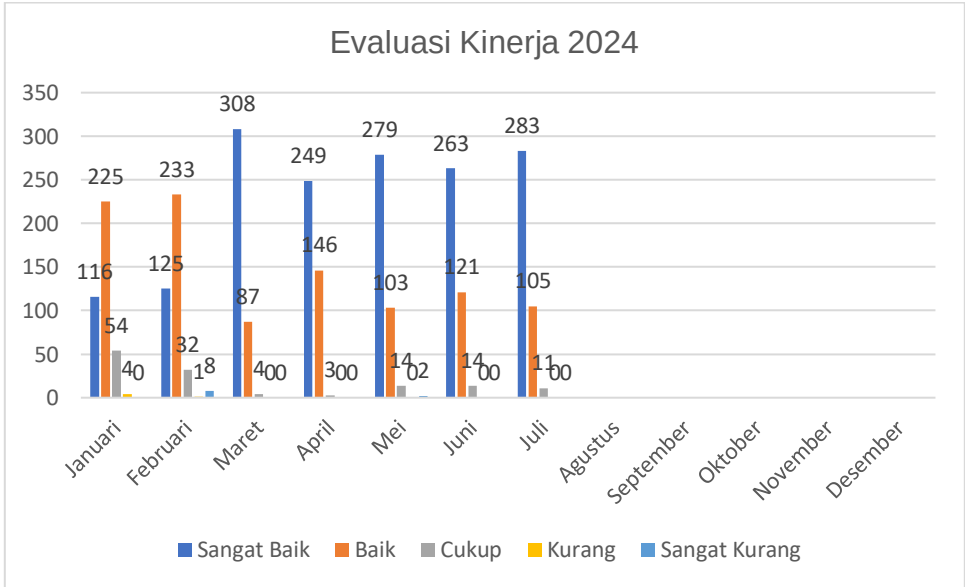
NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	02 s/d 05 Juli 2024	Internal	Bantuan Hidup Dasar	Seluruh karyawan	Diklat dilaksanakan dengan langsung praktik di tempat	Umandok kurang sertifikat diklat
2	23 Juli 2024	Internal	Drill Emergency	Seluruh	Diklat	Lengkapi

			Maternal & Neonatal	bidan dan perawat Maternitas dan Neonatologi	dilaksanakan dengan cara praktik berkelompok dan dinilai oleh evaluator	umandok
3	29 s/d 30 Juli 2024	Internal	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	Seluruh karyawan	Diklat dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 gelombang	Lengkapi umandok

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	KATEGORI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Sangat Baik	116	125	308	249	279	263	283
2	Baik	225	233	87	146	103	121	105
3	Cukup	54	32	4	3	14	14	11
4	Kurang	4	1	0	0	0	0	0
5	Sangat Kurang	0	8	0	0	2	0	0

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :

Naik turun ini mayoritas adalah karena tingkat keterlambatan karyawan meningkat.Terdapat tren yang karyawan kategori “baik” menjadi “baik”.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024

NO	JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Konseling	0	13	11	12	5	2	8

Analisis :

8 konseling adalah tentang kontrak N-ED, yaitu 2 pada IRNA 2c, 3 pada IRNA 3c Anak, 2 pada IRNA 3A & 4A serta 1 pada IRNA 5C.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

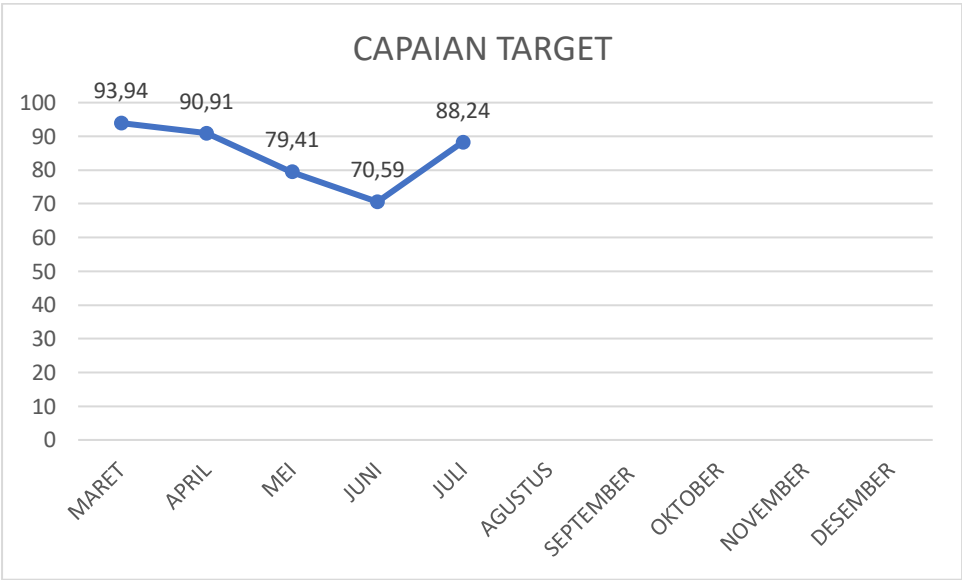
3.5.2 MFK dan K3RS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

NO	KET	TARGET	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Capaian Maintenance	90%	93,94	90,91	79.41	70.59	88.24



Analisis :

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan dental unit ke Klinik Mutiara Sehat PTP

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Follow up ke Karu/Ka unit untuk memberikan info ketika alat medis yang belum di maintenance tidak dalam kondisi dipakai.
- 2. Koordinasi dengan PT untuk wewenang alat medis klinik

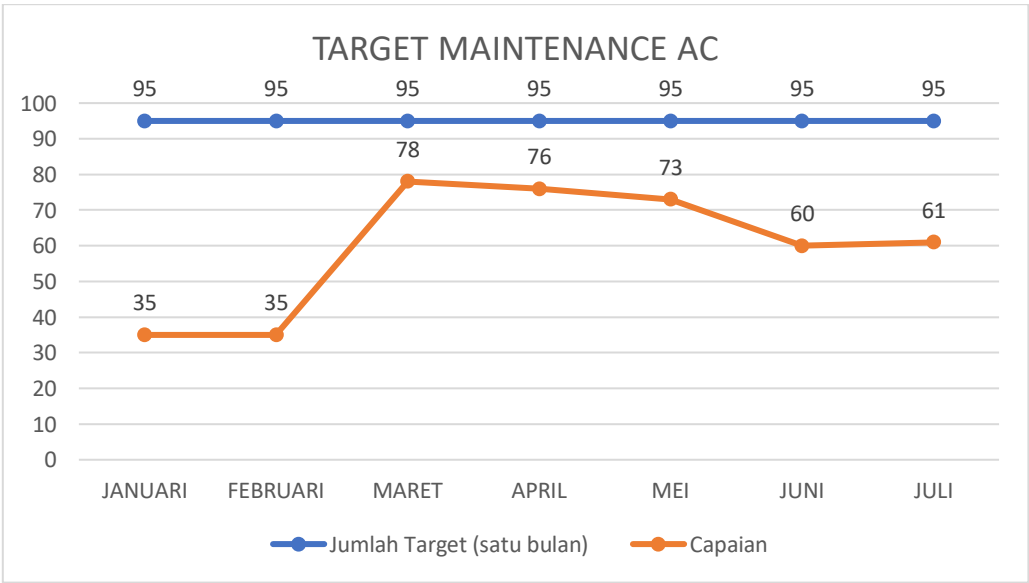
3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

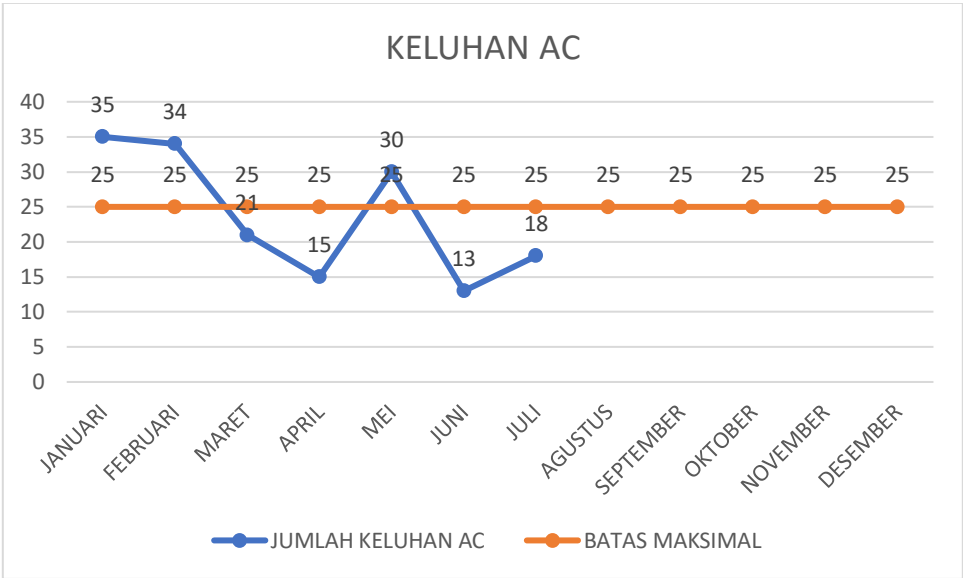
3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	JANUARI	95	54	57%	BELUM MENCAPAI TARGET
2	FEBRUARI	95	69	73%	BELUM MENCAPAI TARGET
3	MARET	95	94	99%	BELUM MENCAPAI TARGET
4	APRIL	95	61	64%	BELUM MENCAPAI TARGET
5	MEI	95	94	99%	BELUM MENCAPAI TARGET
6	JUNI	95	89	94%	BELUM MENCAPAI TARGET
7	JULI	95	60	63%	BELUM MENCAPAI TARGET

3.5.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintanance AC



3.5.2.2.1.3 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



Analisis :
Sudah terdapat progress perbaikan yang baik terhadap pemeliharaan AC baik secara fisik maupun pelaporan ini berdampak pada keluhan staf di unit terhadap AC mulai berkurang. Pada bulan ini berada pada angka 18 laporan keluhan, masih dibawah batas maksimal yaitu 25 keluhan, sehingga progress bulan ini sudah baik namun perlu perhatian pada bulan agustus agar grafik tidak meningkat.
Beberapa penyebab yang mengakibatkan target maintenance masih tidak tercapai :

1. Adanya tugas insidental diluar jadwal IPSRS RS Prima Husada Malang
2. AC ruangan masih terdapat pasien / dalam pemakaian

Rencana Tindak Lanjut :

1. Monitoring dan evaluasi terutama terkait sistem pencatatan dan target perbulan.
2. Pembuatan aplikasi 45ocal IPSRS sebagai reminder

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	5x/bulan	5x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	5x/bulan	5x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	5x/bulan	5x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	5x/bulan	5x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	5x/bulan	5x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	5x/bulan	3x/bulan	60%	Tidak mencapai target
7	Juli	5x/bulan	4x/bulan	80%	Tidak mencapai target

Analisis :
Pada bulan Juli pemeliharaan genset dilakukan sebanyak 4x. Sudah ada perbaikan dari bulan Juni.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	3x/bulan	2x/bulan	67%	Sudah mencapai target
4	April	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 3x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervisi, petugas sudah berkeliling dan melakukan pencatatan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

TANGGAL	STOK LIQUID	SEBELUM PENGISIAN	PENGUNAAN	SATUAN	KETERANGAN	PENGIRIMAN	
01/07/2024	2288	2110	178	MMHG			
02/07/2024	2110	1910	200	MMHG			
03/07/2024	1910	1726	184	MMHG			
04/07/2024	1726	1394	332	MMHG			
05/07/2024	1394	1212	182	MMHG			
06/07/2024	1212	1168	44	MMHG	Sebelum pengisian		
06/07/2024	1168	2940		MMHG	Sesudah pengisian	1772	
07/07/2024	2940	2782	158	MMHG			
08/07/2024	2782	2587	195	MMHG			
09/07/2024	2587	2439	148	MMHG			
10/07/2024	2439	2214	225	MMHG			
11/07/2024	2214	1955	259	MMHG			
12/07/2024	1955	1756	199	MMHG			
13/07/2024	1756	1567	189	MMHG			
14/07/2024	1567	1350	217	MMHG			
15/07/2024	1350	1080	270	MMHG	Sebelum pengisian		
15/07/2024	1080	2952		MMHG	Sesudah pengisian	1872	
16/07/2024	2952	2825	127	MMHG			
17/07/2024	2825	2632	193	MMHG			
18/07/2024	2632	2348	284	MMHG			
19/07/2024	2348	1989	359	MMHG			
20/07/2024	1989	1810	179	MMHG			
21/07/2024	1810	1667	143	MMHG			

22/07/2024	1667	1457	210	MMHG	Sebelum pengisian		
22/07/2024	1457	3186		MMHG	Sesudah pengisian	1729	
23/07/2024	3186	3055	131	MMHG			
24/07/2024	3055	2867	188	MMHG			
25/07/2024	2867	2590	277	MMHG			
26/07/2024	2590	2250	340	MMHG			
27/07/2024	2250	2072	178	MMHG			
28/07/2024	2072	1866	206	MMHG			
29/07/2024	1866	1750	116	MMHG			
30/07/2024	1750	1555	195	MMHG			
31/07/2024	1555	1261	294	MMHG	Sebelum pengisian		
31/07/2024	1261	3335		MMHG	Sesudah pengisian	2074	
				MMHG			
				MMHG			
				MMHG			
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			5838	MMHG			
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						7447	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			405,1428571	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						2978,8	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan.
 Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL
1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Pemeliharaan IPAL	1x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Pemeliharaan filter air	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Pemeliharaan lift	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Pemeliharaan UPS	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

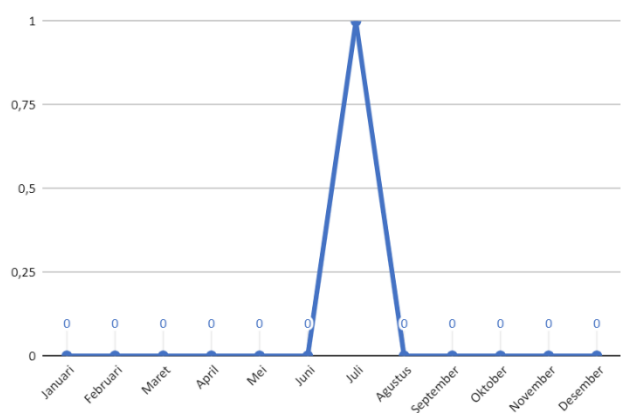
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1.	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	2	0	0	1

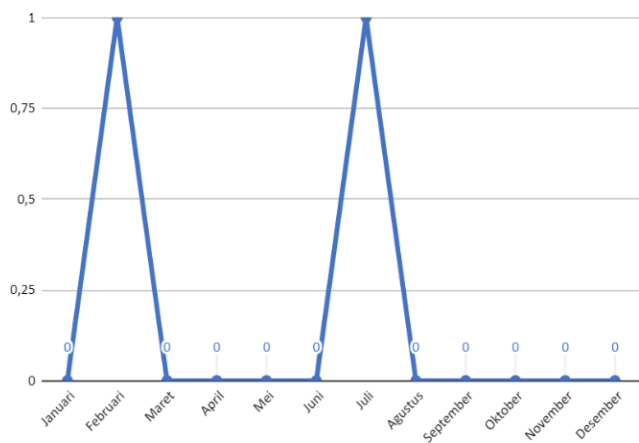
3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	2	0	3	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



Analisis :

Tanggal 30 Juli 2024 Telah ditemukan dompet pasien di area pendaftaran poli , berisi uang sejumlah 105rb & kartu atm 3 pcs (2 mandiri , 1 bca) , diamankan di pos security IGD (kotak ATK).

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

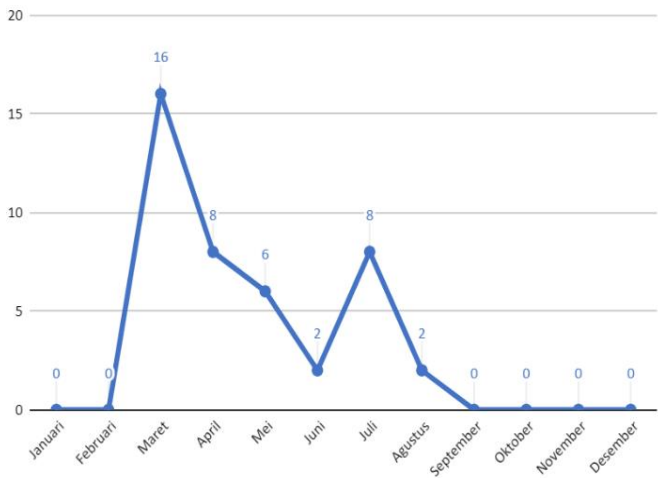


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	Tidak tercatat	Tidak tercatat	16	8	6	2	8



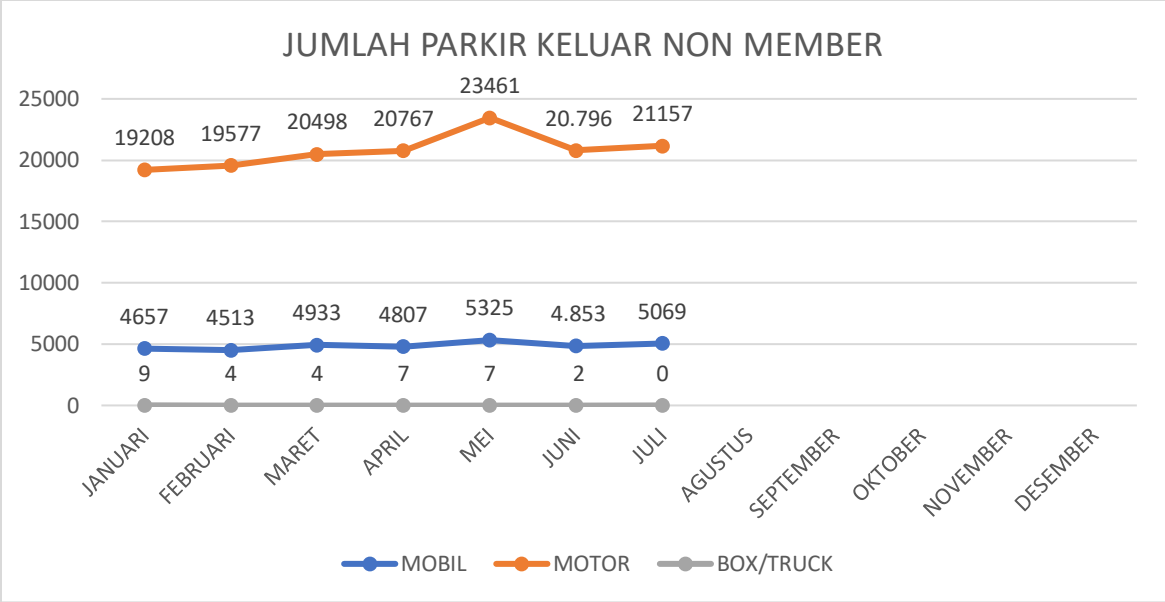
Analisis :
Angka kejadian merokok mengalami kenaikan pada bulan ini. Beberapa faktor yang mengakibatkan:

- 1. Karakter pasien berbeda-beda setiap bulannya
- 2. Tanda dilarang merokok tidak terlihat dengan baik
- 3. Ruang dibelakang Samator menjadi tempat yang tertutup untuk istirahat dan merokok

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :

Kenaikan jumlah parkir di Bulan Juli diakibatkan oleh jumlah kunjungan pasien yang juga naik di bulan ini dibanding bulan lalu.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

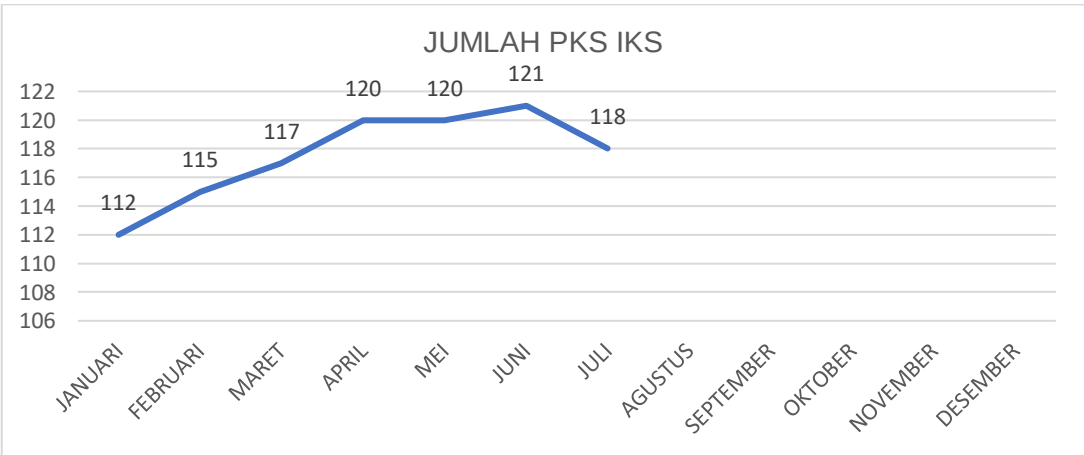
3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Jumlah PKS IKS AKTIF	112	115	117	120	120	121	118

3.5.5.1.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Bulan Juni 2024

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Pesta Pora Abadi	Review pihak kedua	-
2	PT Tentrem Sejahtera	Review pihak kedua	-
3	PT Ustegra	Review pihak kedua	-
4	PT Randi Cones Indonesia	Review pihak kedua	-
5	PT Kharisma Selaras	Review pihak kedua	-
6	PT Tonggak Ampuh	Review pihak kedua	-
7	RS Universitas Brawijaya	Revie ulang oleh RSUB	Ada beberapa notice terkait kesepakatan
8	PT Citra Karsa Dinamika	TTD Pihak kedua	-
9	PT Green Mountains Natural Foods	Review pihak kedua	-
10	PT New Minatex	Review pihak kedua	-
11	PT Uniplastindo Interbuana	TTD Pihak kedua	-
12	BPM Riza Khutmi	Review pihak kedua	-
13	BPM Indah Maharany	Review Pihak kedua	-
14	CV Barokah Plywood	Review Pihak Kedua	-
15	PT Indostar Building Material	Review Pihak kedua	-
16	PT Enak Jaya Makmur (Enak Eco)	Review Pihak kedua	-
17	PT Indonusa Algaemas Prima	Review Pihak Kedua	-
18	PT Duta Kharisma Sentosa	Review Pihak Kedua	-
19	PT Mahadaya Karya Sentosa	Review Pihak Kedua	-
20	PT Bangun Sarana Wreksa	Review Pihak Kedua	-

Analisis :

- 1. Pada bulan Juni, PKS baru dengan instansi lain masih dalam progress
- 2. MOU masih dalam tahap review oleh pihak kedua
- 3. PKS PT Teman Sejati Sejahtera Abadi diperpanjang dengan kolaborasi dengan Vendor lain yaitu PT Tenang Sejahtera (PKS PT DPM dengan PT TSSA & TS)

Rencana Tindak Lanjut :

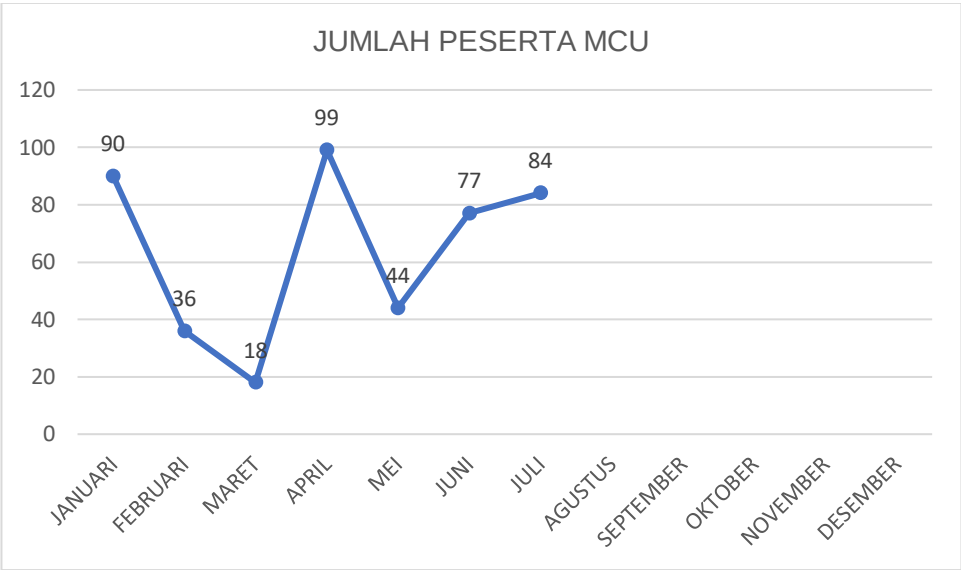
- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
- 2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	JUMLAH PESERTA MCU	90	36	18	99	37	50	84

3.5.5.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU



Analisis :
Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Review hasil kunjungan dengan PDSA :

Plan :

- 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan
- 2. Mempromosikan program MCU
- 3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan

Do :

- 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan
- 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain

Study :

- 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU.
- 2. Perusahaan dan universitas memilih harga MCU paling murah diantara vendor.
- 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan.

Action :

- 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru
- 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Jumlah Kunjungan	6	10	19	4	7	17	16

3.5.5.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal



Analisis :
Fluktuatif pada bulan juni dan juli, namun masih diatas rata-rata 10 kunjungan perbulan

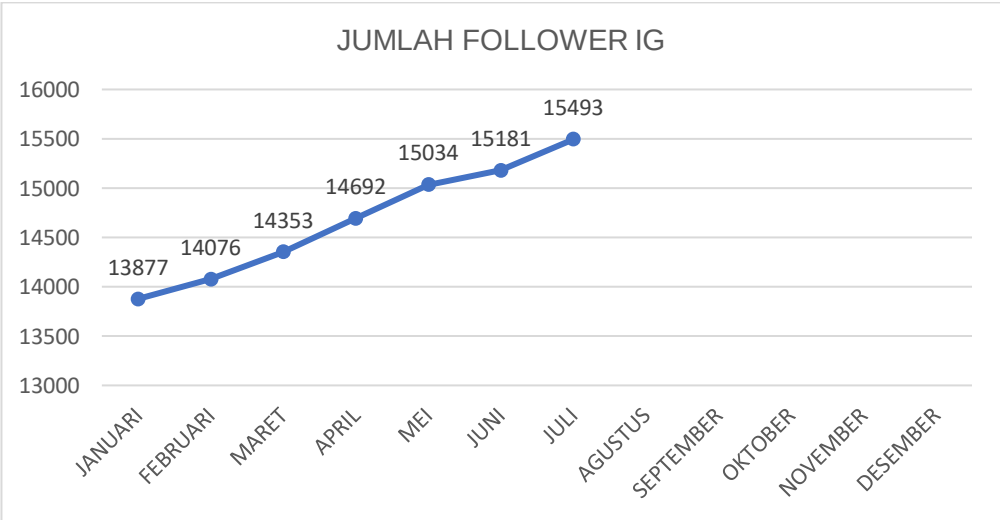
Rencana Tindak Lanjut :
Menghubungi HRD dalam list perusahaan untuk menjadwalkan kunjungan kembali bagi perusahaan yang belum.

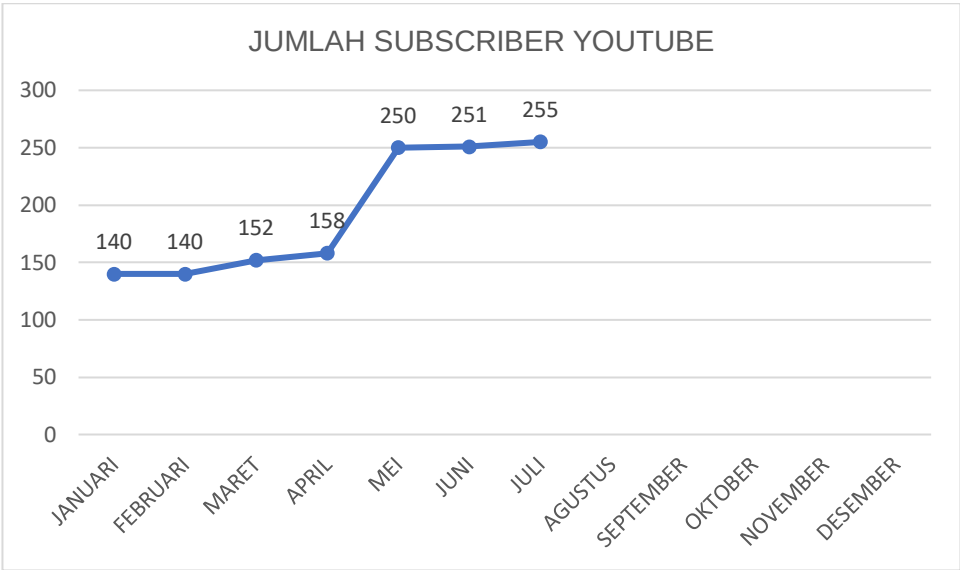
3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Tabel Follower Media Sosial yang Dikelola RS Prima Husada Malang

BULAN	FOLLOWER		UNFOLLOW	
	INSTAGRAM	YOUTUBE	INSTAGRAM	YOUTUBE
Januari	13877	140	265	0
Februari	14076	140	22	0
Maret	14353	152	22	0
April	14692	158	18	0
Mei	15034	250	29	0
Juni	15181	251	31	0
Juli	15493	255	13	0

- Analisis :
- Digital marketing untuk mengelola Youtube belum ada masih menjadi satu di PT.
 - Follower Instagram meningkat karena tim PKRS aktif melakukan upload dan promosi di media sosial.





3.5.6 Penjaminan

3.5.6.1 Piutang

3.5.6.1.2 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Juni 2024

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
							-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860		-
							-
PELAYANAN 2024							
							-
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814		-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779		-
							-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702		-
	FPK PEND REGULER FEBRUARI	373.212.100	10.06.2024	19.06.2024	373.212.100		-
	FPK PEND II FEB 2024	58.112.500	09.07.2024	17.07.2024	58.112.500		-
							-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
	FPK AMBULANCE MARET 24	5.280.000	14.06.2024	10.06.2024	5.280.000		-
	FPK ALKES MARET 24	3.465.000	14.06.2024	10.06.2024	3.465.000		-
	FPK OR MARET 24	471.764.386	15.07.2024	22.07.2024	471.764.386		-
	FPK PEND MARET 2024	383.291.100	09.07.2024	17.07.2024	309.918.000	73.373.100	-
							-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500	-
	FPK AMBULANCE APRIL 24	3.270.000	14.06.2024	10.06.2024	3.270.000		-
	FPK ALKES APRIL 24	3.630.000	14.06.2024	10.06.2024	3.630.000		-
							-
5	FPK MEI 2024	7.537.333.400	23.06.2024	01.07.2024	7.493.109.800	44.223.600	-
							-
6	FPK JUNI 2024	6.959.035.980	24.07.2024	31.07.2024	6.868.943.180	90.092.800	-
							-
7	Reguler Juli Belum FPK	7.560.129.700					7.560.129.700
							-
		62.090.918.531			54.238.066.331	292.722.500	7.560.129.700

3.5.6.1.3 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	MARET 24	RJ	11.887	11.885		2	0,0%
		RI	1.104	1.008		96	9%
2	APRIL 24	RJ	11.384	11.366	2	18	0,2%
		RI	1.082	990	-	92	9%
3	MEI 24	RJ	12.641	12.628	3	13	0,1%
		RI	1.098	1.026	-	72	7%
4	JUNI 24	RJ	11.095	11.090	-	5	0,0%
		RI	1.024	922	-	102	10%

3.5.6.1.4 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG													
PERIODE 2024													
								Y	Z	AA	AB		
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH PIUTANG
		a	b	(a-b-c= d)	e	f	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	Total
	PERIODE JULI 2024 :												
1	Asuransi	230.981.944	137.630.119	91.104.268	236.493.218	110.892.464	121.902.213	213.006.481	184.871.479	25.825.607	1.090.501	133.806	213.006.481
2	Perusahaan	122.902.857	34.309.304	88.593.553	120.620.096	13.928.416	106.691.680	195.285.233	140.488.186	-	46.244.339	-	195.285.233
3	Mandiri Inhealth	57.581.352	41.905.251	15.319.321	19.580.931	-	19.580.931	34.900.251	32.283.249	2.617.003	-	-	34.900.251
4	Jasa Raharja	271.576.225	270.965.972	610.253	80.635.226	959.137	79.676.089	80.286.343	80.286.343	-	-	-	80.286.343
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.663.075.654	703.533.010	959.385.941	510.137.698	-	510.137.698	1.469.523.639	1.468.572.639	-	352.000	-	1.469.523.639
													1.993.001.948

Keterangan :

1. Cut off piutang per tanggal 31 Juli 2024 Rp 1.993.001.948
2. Piutang Perusahaan PT Karya Bina Sentausa proses rekonsiliasi Sebagian sudah terbayar menunggu rincian dan bukti potong PPH
3. BPJS Ketenagakerjaan proses rekonsiliasi piutang seluruh RS PHM sudah mengirimkan berita acara rekonsiliasi pada tanggal 24 Juli 2024
4. Piutang Jasa Raharja sudah terbayar di bulan agustus Rp 48.427.894,-

3.5.6.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Kode I11.0 (Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure) kurang sesuai, harap menggunakan I50 (Congestive heart failure),	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
2.	Kode prosedur 64.44 (rekonstruksi penis) kurang sesuai, harap menggunakan 64.0 (circumsisi),	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
3.	Lampiran SHK pada klaim persalinan (sudah terlampir)	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending

3.5.7 PIPP – MOD – MPP

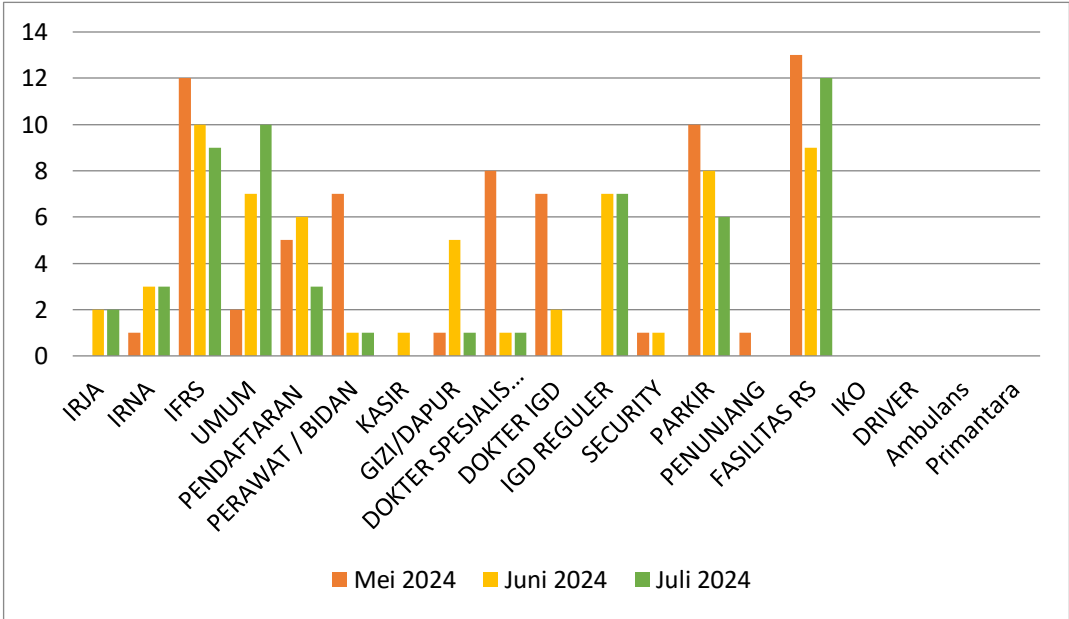
3.5.7.1 Laporan Komplain Pasien

3.5.7.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Juli 2024

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1.	IRJA	0	2	2
2.	IRNA	1	3	3

3.	IFRS	12	10	9
4.	UMUM	2	7	10
5.	PENDAFTARAN	5	6	3
6.	PERAWAT / BIDAN	7	1	1
7.	KASIR	0	1	0
8.	GIZI/DAPUR	1	5	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	8	1	1
10.	DOKTER IGD	7	2	0
11.	IGD REGULER	0	7	7
12.	SECURITY	1	1	0
13.	PARKIR	10	8	6
14.	PENUNJANG	1	0	0
15.	FASILITAS RS	13	9	12
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		68	63	54

3.5.7.1.2 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Juli 2024



Analisis :

- Jumlah pasien komplain selama Bulan Juli 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.
1. Jumlah complain Pada bulan Juli 2024 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Mei 2024 sebanyak 68 kasus complain, pada bulan juni menurun menjadi 63 kasus complain. Sedangkan pada bulan juli menurun sebanyak 53 kasus complain.
 2. Komplain terbanyak pada bulan Juli 2024 yaitu dari Fasilitas RS sebanyak 12 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
 3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 15 jenis complain dengan rincian :
 - a) Fasilitas RS sebanyak 9 kasus yang meliputi :

Ruangan lembab tidak ada akses jendela, perluas kamar, kamar terlalu mepet dan sempit, masing2 kamar mandi diberikan pemanas air, tidak ada space matahari masuk ke kamar, tidak ada gayung dan kaleng, jumlah kamar ditambah, kasur banyak yang tipis.

- b) Parkir sebanyak 6 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :Tempat parkir dalam jalan terlalu sempit, tidak ada pelindung atau penutup untuk parkir sepeda motor, tariff parkir diturunkan, adanya parkir gratis bagi rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juli 2024

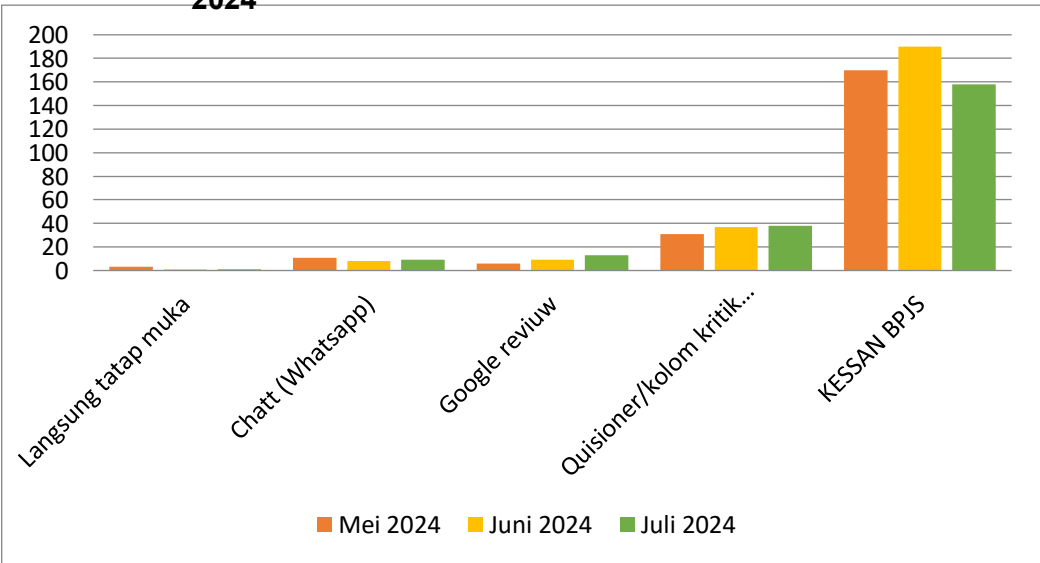
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1.	Langsung tatap muka	3	1	1
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	11	8	9
	b. Google review	6	9	13
3.	Quisioner/kolom kritik saran	31	37	38
4.	KESSAN BPJS	170	190	158

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	3	1	1	13	145

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juni 2024



Analisis :

Pada bulan Juli 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 38 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari

google reviuw sebanyak 13 kasus, chattt WA sebanyak 9 kasus dan secara tatap muka / langsung 1 kasus

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Juli 2024

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 ‘	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 ‘	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	1	0	0
					100%		
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	9	0	0
					100%		
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	13	0	2
					96%		4%
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	38	0	13
					85%		15%
5.	KESSAN	100%	0	100%	158	0	0
					100%		

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Juli 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Kuisisioner dengan capaian 85%, dari google reviuw sebanyak 96% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 15 jenis complain dengan rincian :

1. Fasilitas RS sebanyak 9 kasus yang meliputi :
Ruangan lembab tidak ada akses jendela, perluas kamar, kamar terlalu mepet dan sempit, masing2 kamar mandi diberikan pemanas air, tidak ada space matahari masuk ke kamar, tidak ada gayung dan kaleng, jumlah kamar ditambah, kasur banyak yang tipis.
2. Parkir sebanyak 6 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
Tempat parkir dalam jalan terlalu sempit, tidak ada pelindung atau penutup untuk parkir sepeda motor, tariff parkir diturunkan, adanya parkir gratis bagi rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

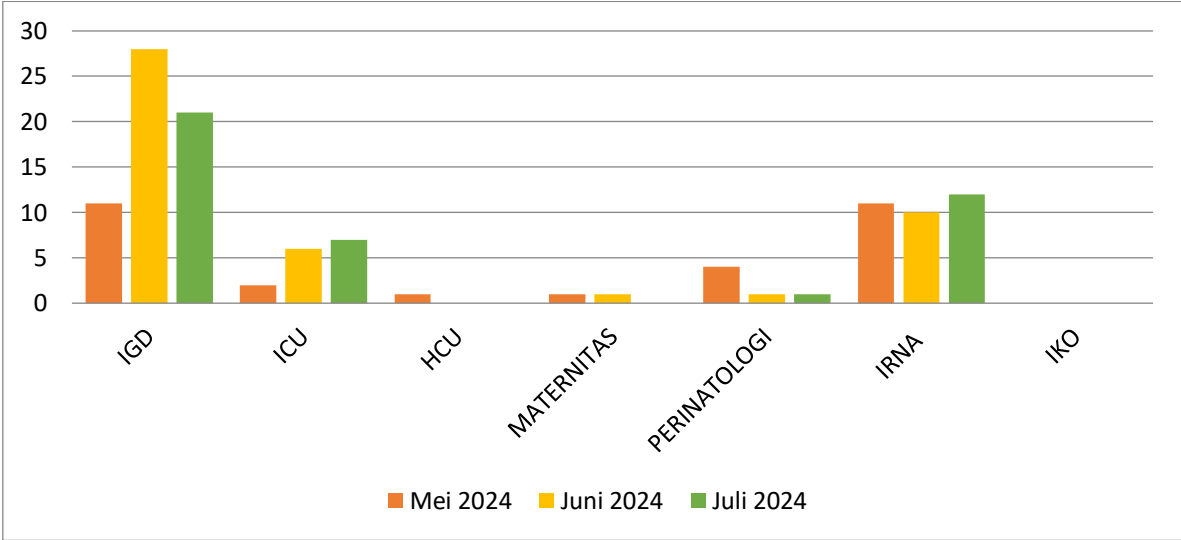
Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Juli 2024

NO	UNIT PERUJUK	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1.	IGD	11	28	21
2.	ICU	2	6	7
3.	HCU	1	0	0
4.	MATERNITAS	1	1	0
5.	PERINATOLOGI	4	1	1
6	IRNA	11	10	12
7	IKO	0	0	0
Total		30	46	41

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Juli 2024



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Tn. Supriyono	IGD	STEMI Inferior - Posterior	dr. Yoga Sp.JP	RSSA	Pro PCI	2	Tidak
2	By. Ny. Dina	NEO	pro ventilator	dr. Fiona Sp.A	RSSA	Pro Ventilator	2	Tidak
3	Ny. Lilik Hidayati	IRNA	Close Fraktur femur sinistra AP/LAT	dr. Arianto Sp.OT konsul dr. Ardhi Sp.PD konsul dr. Mira Sp.JP	RST dr. Soepraoen	Pro colum femur + Complikasi	2	Tidak
4	Nn. Nur Mustafsiroh	IGD	CF PELVIS (PUBIS) D ET S, HEMATURIA SUSP	dr. Pradana, Sp. U	RSSA	Pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak

			RUPTUR URETRA ANTERIOR					
5	Tn. Sunandar	IGD	ADHF, Edema Paru dd pneumonia Bilateral, Anemia, Azotemia dd CKD, Hiperkalemia	dr. Heri, Sp. PD	RS Karsa Husada	Pro HD	2	Tidak
6	Tn. Wiji	IGD	STEMI Infro - Posterior	dr. Mira Sp.JP	RS UMM	Pro PPCI	1	Tidak
7	Tn. Triandi Solimin	IRNA	Meningitis TB	dr. Farid Sp.S	RST dr. Soepraoen	Pro Lumbal Pungsi	4	Tidak
8	Ny. Umi Kulsum	IGD	DOC, Septic Condition	dr. Ardhi, Sp. PD	RS Karsa Husada	Pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
9	Tn. Sunarno	IGD	Syok kardiogenik , Alo kardiogenik, Stemi, CAD post PCI, Hiperqlikemia, hipokalemia	dr. Mira Sp.JP	RS Karsa Husada	Pro Pimary PCI	1	Tidak
10	Ny. Warsiati	IGD	doc ec hipoglikiemia, Anemia, Azotemia ec CKD, Hperkalemia	dr. Heri, Sp. PD	RST dr. Soepraoen	Pro HD	1	Tidak
11	Tn. Mohammad Ahwan	IGD	Anemia, sirosis hepatis, vomiting profus	dr. Heri, Sp. PD	RST dr. Soepraoen	Pro penanganan lebih lanjut	2	Tidak
12	Tn. Nur Salim	IGD	Colic renal dd nefrolitiasis sin, CKD	dr. Pradana Sp.U konsul dr. Zora Sp.PD	RS Karsa Husada	Pro HD	2	Tidak
13	Tn Darsi	IRNA	Necritizing fascitis forarm dextra, DM type 2, Edema anasarka	dr Heri, Sp.PD	RSSA	Pro penanganan lebih lanjut	5	Tarif rs : 3.821.916 Plavon : 3.611.500 Minus : 210.416
14	Tn Yudi Sutrisno	ICU	Shock cardiogenik, NSTEMI, PN High, MR, DM, Bradicardi simptomatik	dr Ira, Sp.JP	RSSA	Pro PCI	4	Tarif rs : 7.782.410 Plavon : 7.296.300 Minus : 486.100
15	Tn Wases	ICU	CVA embli 2nd attack, hipokalemi,	dr Dewi, Sp.N	RST dr. Soepraoen	Pro unit stroke	3	Tidak
16	Ny. Nur Yanti	IRNA	SAH, HT	dr. Farid Sp.S	RSSA	Pro Clipping/ coiling	2	Tidak
17	Ny. Dariyati	IGD	Susp CVA dd SOP Cerebral	dr. Syahrir Sp.S	RST dr. Soepraoen	Pro Stroke Unit	2	tidak

18	Ny. Nurchasanah	IGD	Nsteacs, Syok cardiogenic dd syok septic, bradikardia simptomatik, transaminitis, azotemia, hiperkalemia	dr. Mira Sp.JP	RST dr. Soepraoen	Pro Immediate invasive strategy + Back up HD	1	Tidak
19	An. Azril Fauzan Rashya	IRNA	Ileus Obstructive	dr. Dicky Sp.A	RS Hermina	Pro Bedah Anak	4	Tidak
20	Ny. Ngatmini	IRNA	Efusi pleura dex masif e.c CA , Susp Hamatothorax (post trauma)	dr. Zaki Sp.B	RSSA	Pro Chest tube dan tata laksana lebih lanjut	3	Tidak
21	Tn. Ngatemin	IRNA	Abdominal pain, GEA, Vomiting, PVC, Hipokalemia	dr. Heri Sp.PD konsul dr. Ira Sp.JP	RSUD Dr Soetomo Surabaya	IPD Pro Colonoscopy	2	Tidak
22	Ny. Ngatemi	ICU	DOC, Septic Condition, CVA, DM , pneumonia dd TB	dr. Ardhi, Sp. PD	RS Lavalette	Pro penanganan lebih lanjut	3	Tidak
23	Ny. Siti Aminah	IRNA	Illeus obstruktif susp. Steven Johnson Syndrome	dr. Anton, sp. B	RSUD Dr Soetomo Surabaya	Pro penanganan lebih lanjut	3	Tidak
24	Tn. Ariman	ICU	Syok cardiogenic, uremic encephalopathy	dr. ira, Sp. JP, konsul dr. Ardhi, Sp. PD	RSSA	Pro penanganan lebih lanjut	3	Tidak
25	Tn. Agus Setyawan	IRNA	Ca Paru Dextra dd Metastase, Anemia, trombositosis, Hiponatremi	dr. Andy, Sp.P k/ dr Heri, Sp.PD	RSSA	Pro penanganan lebih lanjut	4	Tidak
26	Tn. Soleh	ICU	NSTEMI, Hipokalemia, HHD	dr. Ira, Sp. JP	RS Persada Hospital	Pro PCI	2	Tidak
27	Tn. Abdul Malik	ICU	Stemi anterior, LV failure, Dislipidemia, Hiperuricemia	dr. Ira, Sp. JP	RST dr. Soepraoen	Pro PCI	2	Tidak
28	Tn. Misnan	IGD	Hernia diafragmatika	dr. Zaki Sp.B	RST dr. Soepraoen	Pro penanganan lebih lanjut	2	Tidak
29	Ny. Mulianah	IGD	CF Femur Sin	dr. Oka, Sp. OT	RSSA	Pro penanganan lebih lanjut	2	Tidak
30	Ny Wasiati	IGD	DF dd DSS, Anemia, CA Mamae	dr Heri, Sp.PD	RST dr. Soepraoen	Pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
31	Tn. Mochammad Solkan	IGD	Susp TU Cerebri	dr. Syahrir Sp.S	RST dr. Soepraoen	Pro unit stroke	2	Tidak

32	Ny. Tunik Indrawati	IGD	Pneumonia, Efusi pleura dex, trombositis, CA Mamae	dr. Andy Sp.P	RS Lavalette	Pro penanganan lebih lanjut	2	Tidak
33	Tn. Sunarto	IRNA	Afasia, CVA Infark	dr. Farid Sp.S	RST dr. Soepraoen	Pro unit stroke	3	Tidak
34	Tn. Sa'i	IGD	STEMI anterior recent onset, PVC, Haemoroid externa, retensio urine dt susp BPH	dr. Ira Sp.JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
35	Tn Wariaji	ICU	CVA ICH, IVH, HT Emergency	dr Syahrir, Sp.S	RST dr. Soepraoen	Pro konsul bedah saraf	15	Tidak
36	Tn. Supangat	IGD	CKD Stage V, Afasia dd CVA Infark	dr. Farid Sp.S	RSSA	pro HD Cito	1	Tidak
37	Tn. Tomin	IRNA	CVA Infark, DM hiperglikemia, ISK, Trombus LV, LV Failure, AF, PVC	dr. Farid Sp.S konsul dr. Ira, Sp. JP	RSUD Bangil	Pro Unit Stroke	6	Tidak
38	Ny. Juwarni	IRNA	Cholelithiasis, Susp SOP cerebri, hemiplegi Kiri, Hipokalemia	dr. heri, Sp. PD Konsul dr. Syahrir, Sp. N	RSUD Bangil	Pro ICU	3	Tidak
39	Tn. Sampun	IGD	CKD, Colic Abdomen Susp Cholelithiasis	dr. Heri, Sp. PD	RSSA	pro HD Cito	1	Tidak
40	Tn. Triwiji Prayitno	IGD	CVA ICH	dr. farid, Sp. N	RS Lavalette	Pro Unit Stroke	2	Tidak
41	Ny. Heny Setyarini	IGD	Uremic Lung, Akut on CKD, Hiperkalemia	dr. Ardhi, Sp. PD	RST dr. Soepraoen	Pro HD	1	Tidak

Analisis :

- Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam 3 bulan terakhir, pada bulan mei sebanyak 30 pasien, pada bula Juni sebanyak 46 pasien. Sedangkan pada bulan Juli 2024 sebanyak 41 pasiendengan rincian : IGD 21 pasien, IRNA 12 pasien, Neonatus 1 pasien, ICU 7 pasien, dan Neo 1 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro HD = 7 kasus
 - Pro unit stoke = 8 kasus
 - Pro PCI = 6 kasus
 - Pro Bedah digestif anak = 1
 - Membutuhkan alat khusus = 5
 - Pro ventilator = 1
 - Pro isolasi TB = 2
- Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya sebesar Rp.7.789.281 Sedangkan pada bulan Juli 2024 terdapat 2 pasien dengan jumlah total minus : Rp. 696.516

Rencana Tindak Lanjut:

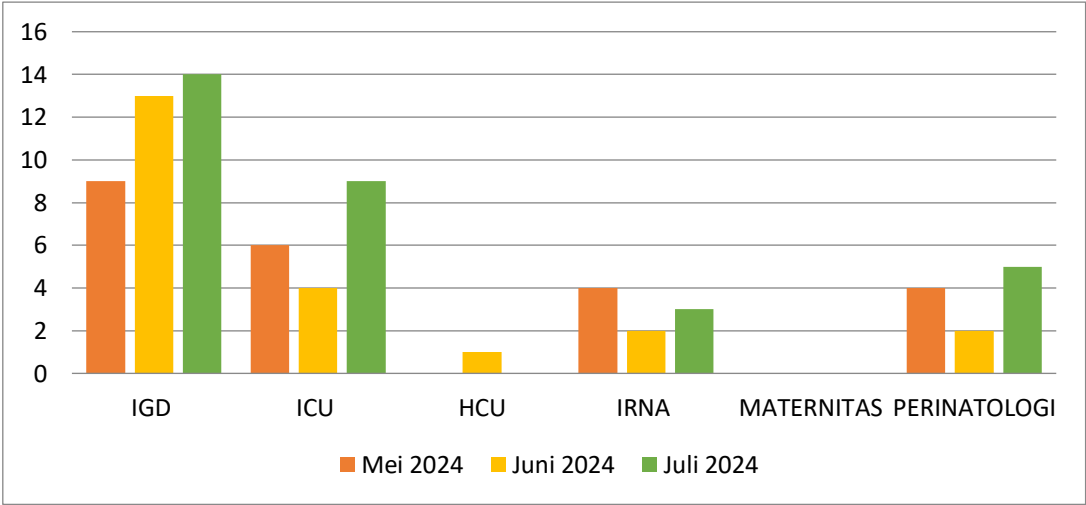
- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.6 Pengisian Form A, B, Discart Planning
3.5.7.6.1 Kelengkapan Pengisian Form A-B dan Dischard Planning Bulan Juli 2024

NO	NAMA PETUGAS	FORM MPP	DISCARD PLANING
		JUMLAH	JUMLAH
1	Wiwit Indah Yanti, S. Kep, Ns	351	123
2	Sisca Puspitasari, S. Kep, Ns	532	122

3.5.7.6.2 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Juli 2024

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1.	IGD	9	13	14
2.	ICU	6	4	9
3	HCU	0	1	0
4.	IRNA	4	2	3
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	PERINATOLOGI	4	2	5
Total		23	22	31



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Tn. Kalimin	ICU	Aspirasi pneumonia, CVA ICH	dr. Farid Sp.S raber dr. Heru Sp.An
2	By. Ny. Siti	NEO	Missed Abortion	dr. Humaira, Sp. OG
3	Ny. Ani Yeni	ICU	SOP cerebri + gagal nafas	dr. Dewi, Sp. S raber dr. heru, Sp. An.
4	Ny. Siti Rohmah	IGD	DOA	dr. Sofia

5	Tn. Fatchur Rochim	IGD	DOC, Septic Condition	dr. Dira
6	An. Maura Anindira Syifabella	ICU	DSS+ Anemia	dr. Dicky, Sp. A
7	Ny. Sriwati	IRNA	Ganggren Necrotic diabeticum pedis dex post DNN amputasi digity III, IV, V. AKI, Syok condition, DM Hiperglikemi	dr. Zaki Sp.B
8	Ny. Srianah	IRNA	Kista pankreas dd prankeatitis	dr. Ardhi Sp.PD konsul dr. Iwan Sp.B
9	Ny Sriatun	IGD	DOC EC Encephalopathy metabolic	dr Andira
10	Tn Edi Susanto	IGD	DOA	dr Andira
11	Tn Djumadi	ICU	Syok hipovolemik, Syok cardiogenik, AF	dr Yoga, Sp.JP
12	Ny Tiayah	IGD	STEMI higt lateral posterior, cardiogenik shock	dr Yoga, SP.JP
13	By Ny Asmuna Nadhiro	NEO	IUFD	dr Aida, Sp.OG
14	Ny. Enik	IGD	DOA	dr. Muchlas
15	By. Ny. Rina Rakhmawati	NEO	IUFD	dr. Aida Sp.OG
16	Ny. Kusbandrijati	ICU	UAP, Nstemi, Syok Cardiogenic	dr. Ira Sp.JP
17	Ny. Sri Surhartiwi	ICU	CVA Infark	dr. Farid Sp.S
18	Nn. Salsabila Nooranisa	ICU	DSS	dr. Heri, Sp. PD
19	Ny. Puji Rahayu	IGD	DOC dt metastase tumor dd ca mamae	dr. farid, Sp. N
20	Tn. Galih Suryo Sumarno	IGD	Cardiogenic shock, HF, Tumor Otak, Hipoglikemia, AKI	dr. Yoga, Sp. JP
21	Tn Taseman	IGD	DSS, krisis hiperglikemi, susp KAD	dr Heri, Sp.PD
22	Ny. Kasriani	IGD	DOC susp CVA emboli dd ICH, Syok, Pneumonia	dr. Farid Sp.S
23	Ny. Sukarni	IGD	Susp KAD, Edema Paru, Transaminitis, Azotemia	dr. Ardhi Sp.PD
24	Ny. Kumakiyah	IRNA	ALO Cardiogenici, non cardiogenic, CAD HHD, DM	dr. Mira Sp.JP raber dr. Heri Sp.PD
25	Tn Wachid	ICU	CVA ICH, Pneumonia aspirasi, ARDS	dr Farid, Sp.S
26	By Ny Rully	NEO	Neonatus Imatur	dr Humaira, Sp.OG
27	Ny. Raminem	IGD	doc EC Syok cardiogenik, SVT	dr. Yoga, Sp. JP
28	Tn. Sariono	IGD	STEMI	dr. Yoga, Sp. JP
29	By. Ny. Ketiana	NEO	Premature, Afiksia	dr. Dicky, Sp. A
30	Tn. Sutrisno	IGD	DOC	dr. Syahrir, Sp. N
31	Tn. Kusman	ICU	Destroyed :ung	dr. Andy, Sp. P

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Juli 2024 sebanyak 31 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD sejumlah 14 pasien, ICU sebanyak 9 pasien, IRNA 3 pasien, dan Neonatologi sebanyak 5 pasien.
3. Pada bulan Juni 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 3 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

NO	JENIS	TARGET	MEI	
			CAPAIAN	PROSENTASE
1	SEIRI / RINGKAS	30	61%	48%
2	SEITON / RAPI	40	89%	85%
3	SEISO / RESIK	330	54%	56%
4	SEIKETSU / RAWAT	40	72%	74%
5	SHITSUKE / RAJIN	60	69%	72%

SEIRI / RINGKAS	DESKRIPSI
Penempatan Alat Kebersihan di Janitor	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Janitor. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Janitor, peralatan kebersihan ditempatkan ppada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Penempatan alat kebersihan di Trolley	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Trolley. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Trolley, peralatan kebersihan ditempatkan pada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Kondisi bak pembersih / kereta peras	Kondisi bahan pembersih yang ada di bak pembersih / ketreta peras tidak kotor. Maksimal 2x penggantian. Jika sebelum 2x sudah kotor amaka harus diganti. Pel harus dalam kondisi bersih
SEITON / RAPI	
Kerapian baju petugas CS	CS menggunakan baju sesuai seragam dengan rapi dan bersih
Penggunaan ID card	CS Menggunakan id card sesuai aturan
Penanganan sampah Medis dan Non Medis	
Penempatan sampah medis dan nonmedis	tempat sampah diberi kantong plastik sesuai warna dan fungsinya. Sampah medis dan nonmedis tidak boleh tercampur.
Penempatan plastik	Tempat sampah dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh, tidak kotor, tidak ada sampah berceceran
SEISO / RESIK	
Lantai	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih, dan sudut lantai harus bebas noda.
Langit – Langit / Plafon	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kaca Luar – Dalam	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, bebas noda, dan mengkilap.
Jendela / Tralis	Jendela / tralis bersih, tidak berdebu, dan tidak bernoda.
Tirai (vertical blind, gordyn)	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan rapi.
Lampu	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Saklar & stopkontak	Tidak berdebu, tidak bernoda, dan tidak basah.
Sarana pemadam kebakaran	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan tidak digunakan untuk menyimpan barang.

Objek Berbahan Stainless	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak berminyak, dan tidak ada lawa – lawa.
Dinding	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Wastafel dan eye wash	Pembuangan mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, kering, kaca cermin bersih, bening, tidak berdebu, tidak bernoda, kran tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Kamar Mandi	Kebersihan dan bau
Ruangan	Tidak bau amis, pesing, dan anyir.
Plafon/langit-langit	Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kasa nyamuk	Bersih, tidak bernoda, tidak ada lawa – lawa, dan tidak berdebu.
Dinding Keramik	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, dan nat dinding bersih.
Closed	Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada percakan air disekelilingnya, dan tidak bau.
Kran	Tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Pintu	Bersih, tidak ada noda, dan mengkilap.
Urinoir	Bersih, tidak ada noda, tidak bau, dan tidak berkarat.
Bak Mandi	Tidak menguning karena lumut, tidak kotor, dan tidak ada jentik.
Ember dan Gayung	Bersih dan tidak berlumut.
Lantai	Bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak bau, dan sudut lantai harus bebas noda.
Keset	Tidak berdebu, tidak basah, tidak bau, dan tidak ada sampah.
Tempat Sampah	Dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh (terisi kurang dari 2/3 bagian), tidak kotor, dan tidak ada sampah berceceran
Tangga	Bersih dan bebas sawang
Railing	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan bila diusap tidak membekas.
Lantai (anak tangga & Bordes)	Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, dan tidak bau.
Dinding	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan tidak ada bercak.
Plafon	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Lift	Lantai dan dinding tidak berdebu, tidak bernoda, mengkilat, harum, dan sudut lantai harus bebas noda.
Dek Level	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa / sampah / daun kering.
Pagar	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Spoel hock/Dapur	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Pembersihan Tempat Sampah / Trolly	Pembersihan tempat sampah / trolly dilakukan secara rutin, kondisi tidak berdebu, dan ada jadwal pembersihannya juga.
SEIKETSU / RAWAT	
Poles lantai di ruangan	Sudah dilakukan dan/atau dijadwalkan poles lantai, baik basah dan atau kering maksimal 1x/bulan
Pemakaian APD	APD masker, sepatu, sarung tangan
Penandaan alat kebersihan	Hijau strip 1 (-) : kantor, Hijau strip 2 (=) : dapur, Biru (selasar), kuning (r. perawatan/pelayanan, merah : kamar mandi
Kebersihan Diri Petugas	Pakaian bersih, Badan bersih, Tidak berbau tidak sedap
SHITSUKE / RAJIN	

Kompetensi CS Memperagakan Cuci tangan dengan benar	Dapat mempraktekan lengkap sesuai SOP cuci tangan
Kompetensi CS dalam menanggapi response keluhan	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup
Kompetensi CS dalam mengikuti arahan kordinator	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

JENIS	TARGET	CAPAIAN JUNI	CAPAIAN JULI
SEIRI / RINGKAS	30	61%	48%
SEITON / RAPI	40	89%	85%
SEISO / RESIK	330	54%	56%
SEIKETSU / RAWAT	40	72%	74%
SHITSUKE / RAJIN	60	69%	72%

Analisis :
 Pada bulan Juni - Juli metode penilaian ada perubahan. Pada Bulan Juli terdapat penurunan di Aspek Seiri, Seiton namun terdapat peningkatan di Seiso dan Seiketsu.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

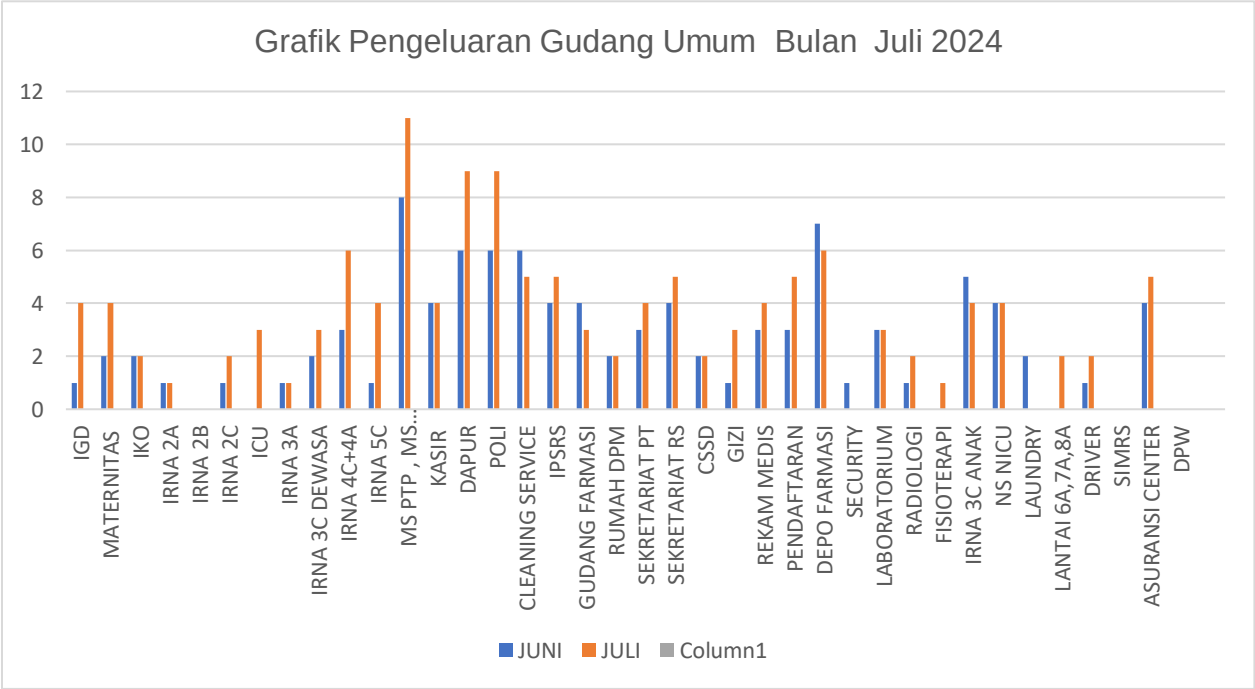
3.5.9 **Pengadaan dan Gudang Umum**

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT	MEI	JUNI	JULI
1	IGD	4	1	4
2	MATERNITAS	2	2	4
3	IKO	1	2	2
4	IRNA 2A	0	1	1
5	IRNA 2B	0	0	0
6	IRNA 2C	1	1	2
7	ICU	2	0	3
8	IRNA 3A	1	1	1
9	IRNA 3C DEWASA	1	2	3
10	IRNA 4C+4A	1	3	6
11	IRNA 5C	1	1	4
13	KASIR	4	4	11
14	DAPUR	7	6	4
15	POLI	7	6	9
16	CLEANING SERVICE	5	6	9
17	IPSRS	6	4	5
18	GUDANG FARMASI	4	4	5
19	RUMAH DPM	2	2	3

20	SEKRETARIAT PT	3	3	2
21	SEKRETARIAT RS	5	4	4
22	CSSD	3	2	5
23	GIZI	3	1	2
24	REKAM MEDIS	3	3	3
25	PENDAFTARAN	4	3	4
26	DEPO FARMASI	6	7	5
27	SECURITY	0	1	6
28	LABORATORIUM	4	3	0
29	RADIOLOGI	3	1	3
30	FISIOTERAPI	1	0	2
31	IRNA 3C ANAK	2	5	1
32	NS NICU	1	4	4
33	LAUNDRY	1	2	0
34	LANTAI 6A,7A,8A	2	0	2
35	DRIVER	2	1	2
36	SIMRS	0	0	0
37	ASURANSI CENTER	4	4	5
38	DPW	0	0	0
39	PIPP	0	0	0

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
 Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat dan dapur, poli

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

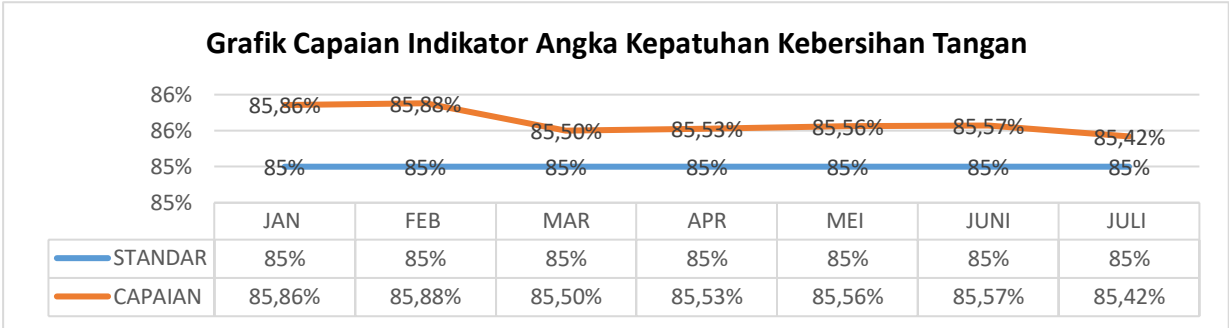
3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL									
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04%	93,15%	93,3%	93,52%	93,73%	93,8%	93,92%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%	99,95%	99,93%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergens	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2%	91,7%	95,74%	52,7%	65,2%	72,8%	80,97%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19%	79,08%	79,28%	78,06%	76,32%	78,47%	78,3%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,46%	97,5%	98,9%	99,69%	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8%	71,62%	67,56%	66,7%	100%	92,5%	100%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%	85,57%	85,42%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15%	100%	100%	100%	93,8%	93,92%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%	99,95%	99,93%

3.6.1.1.1

Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

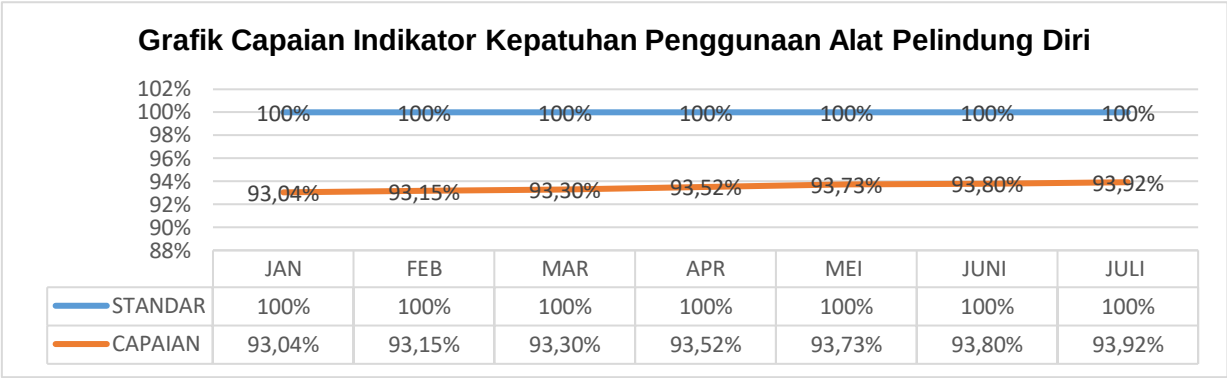
3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,42%, meskipun sedikit menurun dari bulan lalu. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatk an kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

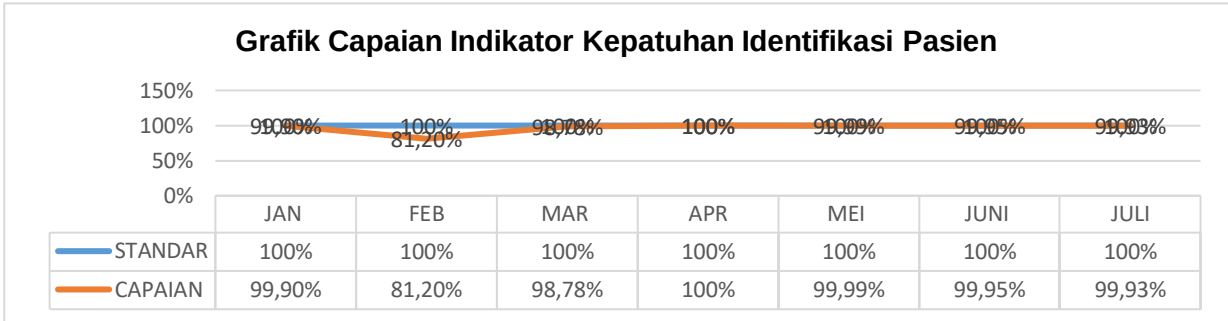
3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Juli capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

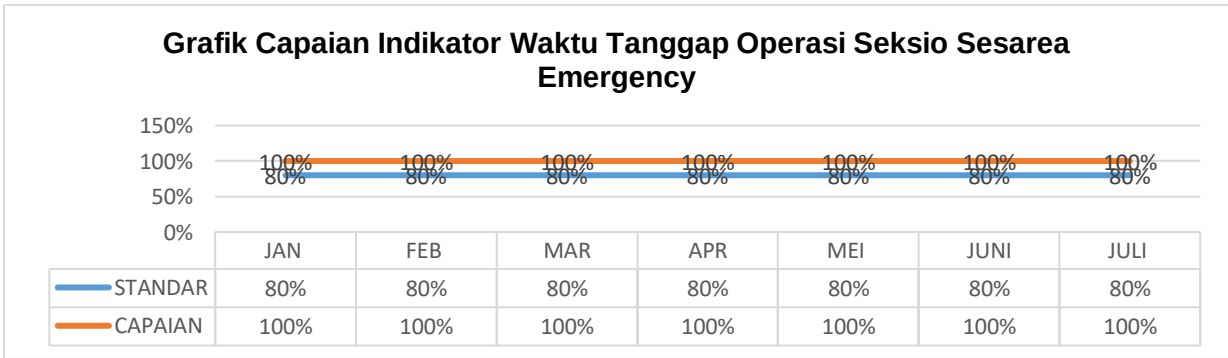
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Juli capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

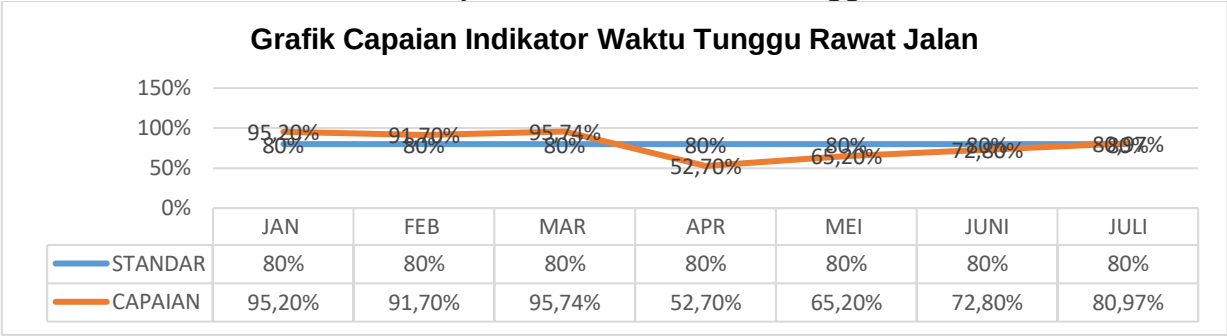
3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisa Capaian :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

3.6.1.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

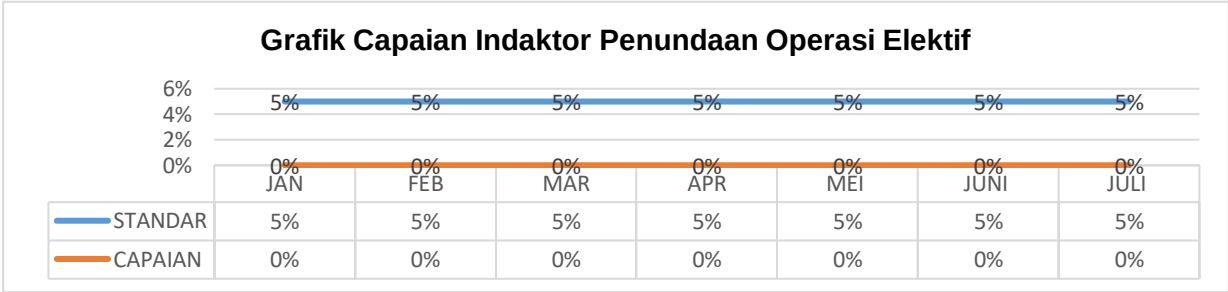
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart jika dilihat dari input mutu pada SIMRS, tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP. Pada bulan Mei tahun 2024 diketahui prosentase waktu tunggu rawat jalan 65,2%, bulan Juni 72,8% dan bulan Juli 80,97%. 1. DPJP tepat waktu : dr. Aida, Sp.OG, dr. Akhmad Syahrir, Sp.N, dr. Ardhi Bustami, Sp. PD, dr. Dewi Maharani, Sp.S, dr. Dicky, Sp.A, dr.Vita, Sp.KK, dr.Humaira, Sp.OG, dr.Ira, Sp.JP, dr.Miryanti, Sp.JP, dr.Nimim, Sp.THT.KL, dr.Pradana,Sp.U, dr.Yoga, Sp.JP, dr.Zora, Sp.PD , dr Viona Sp.A, dr.Elvi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S 2. DPJP Tidak tepat waktu : dr.Andi,Sp.B, dr.Andy,Sp.P, dr.Iwan,Sp.B, dr.Nurhadi,Sp.M, 3. DPJP dengan tindakan lama : dr. Anton, Sp.B, dr.Huda, Sp.KJ, dr.Didid, Sp.KJ, dr.Eko, Sp.KFR.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan SDM.	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.6 Penundaan Operasi Elektif

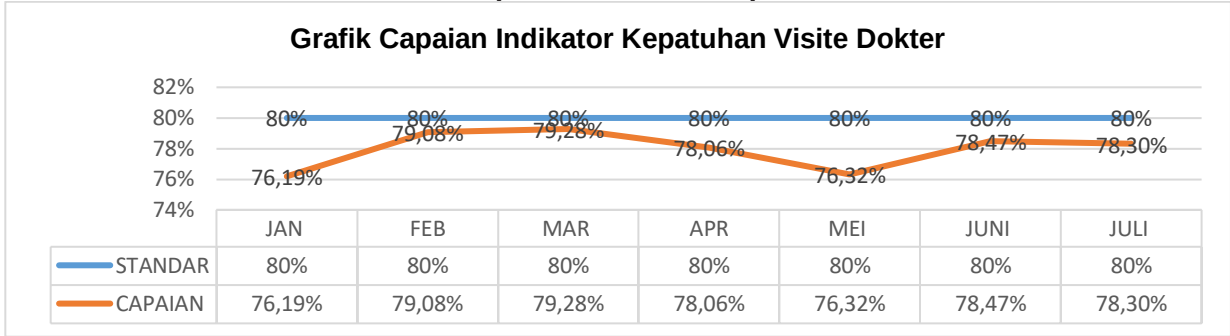
3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Analisa Capaian :

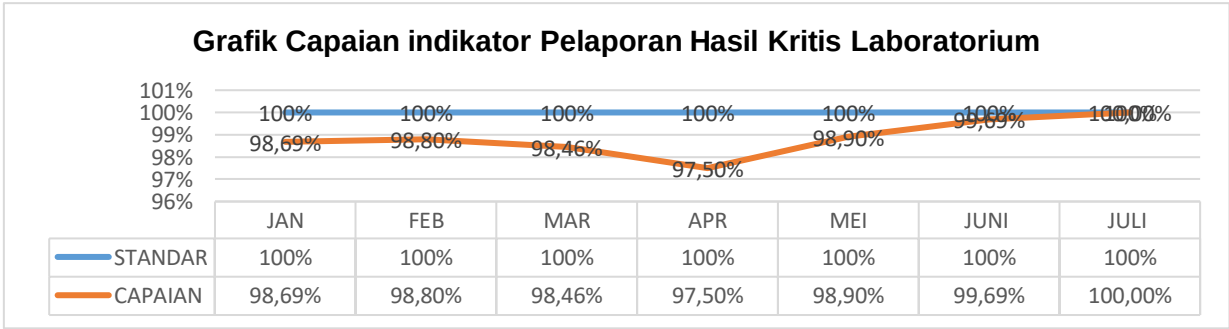
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Juli tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

3.6.1.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter
3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkannya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	Satu bulan

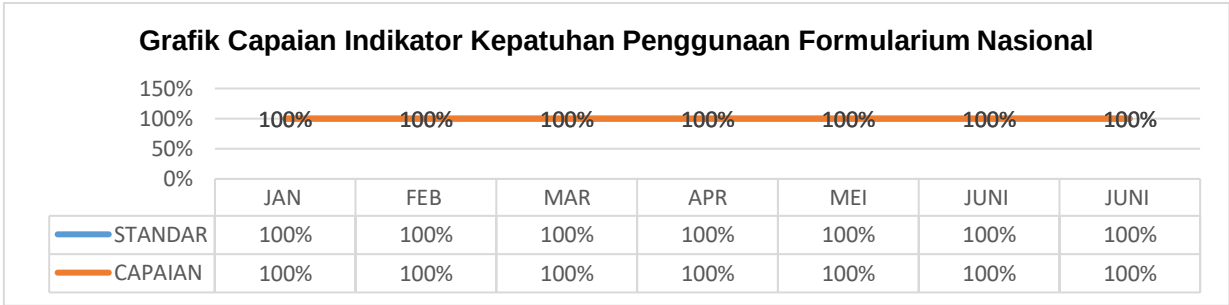
3.6.1.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 masih belum mencapai standart. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap. Capaian meningkat pada bulan Juli ini, pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Juli mencapai standart 100%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan

3.6.1.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

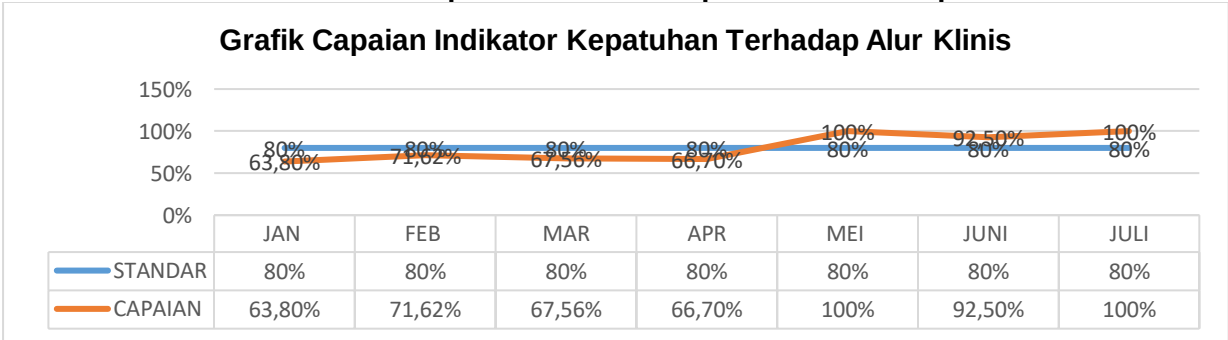
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga Juli Tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

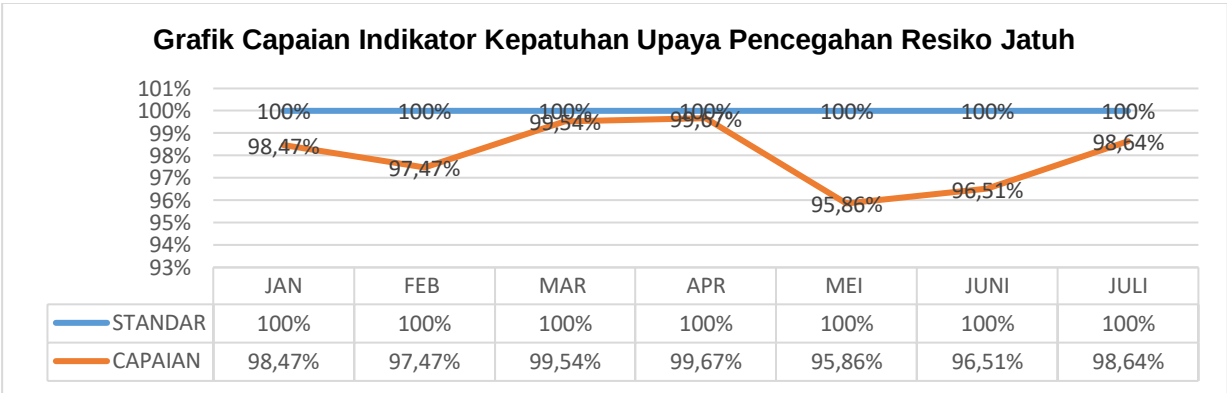
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.				
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.	Komite mutu	Satu bulan

3.6.1.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

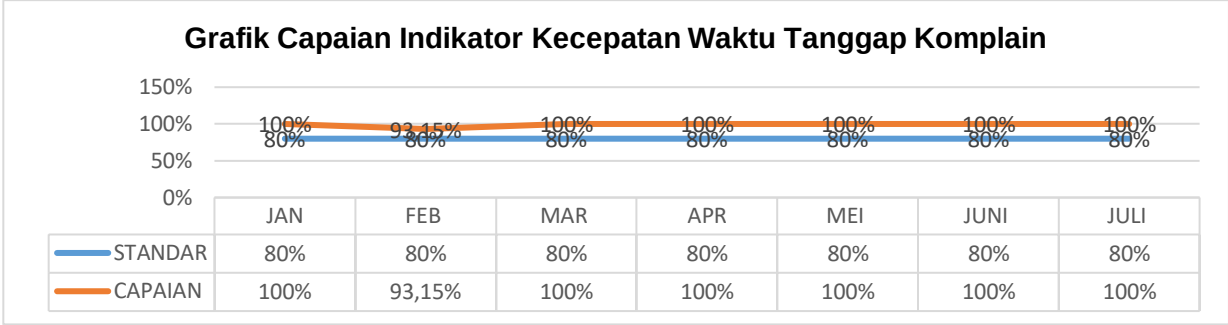
3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

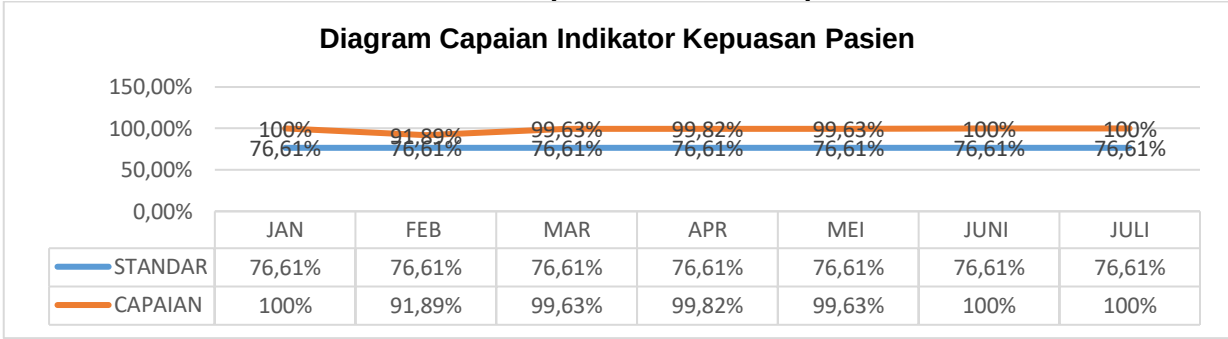


Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap komplain pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam. Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret hingga Juli capaian kembali meningkat menjadi 100%.

3.6.1.1.13 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis :

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 sudah mencapai standart

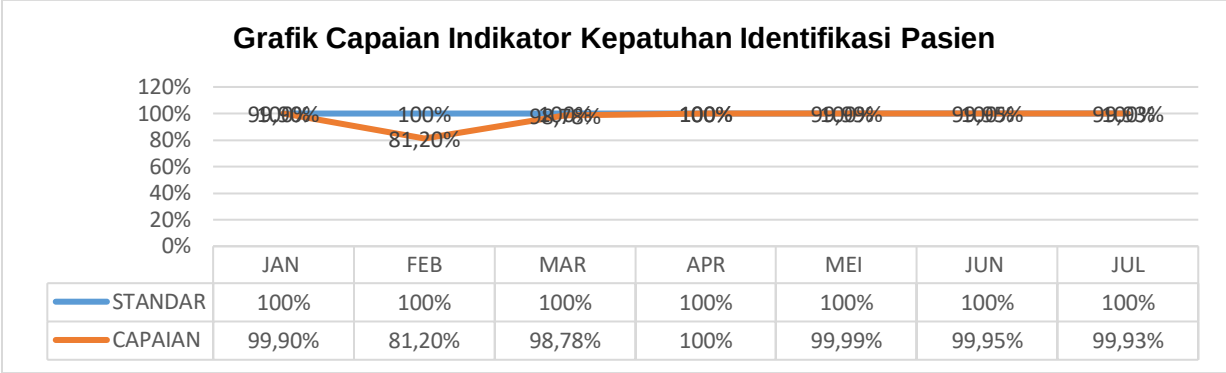
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%	99,95%	99,93%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%	95,51%	98,64%

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

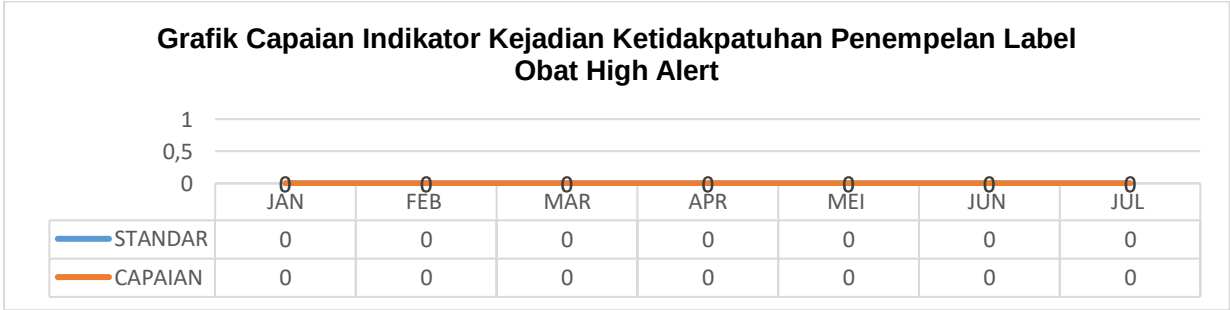
3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Juli, capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

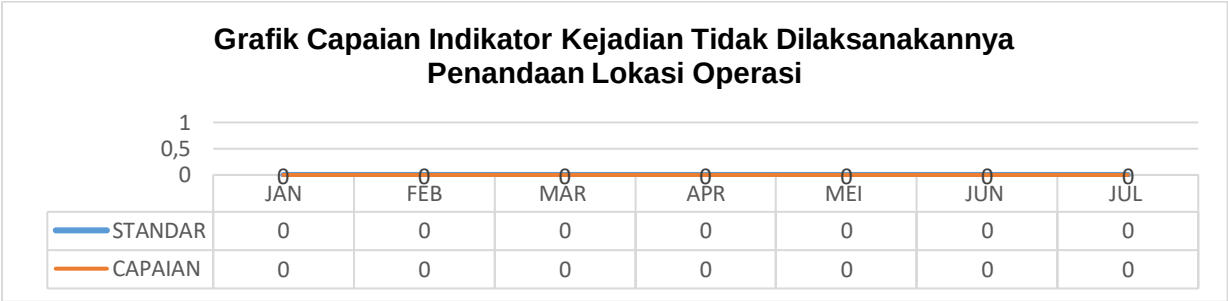


Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

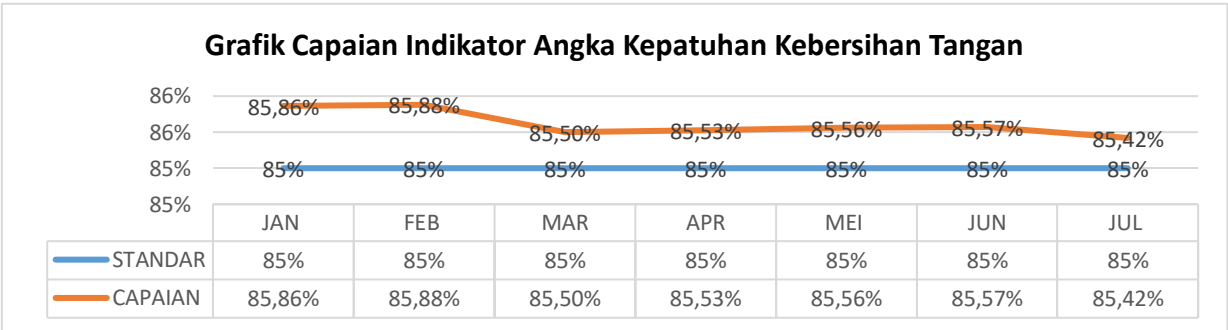


Analisis :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

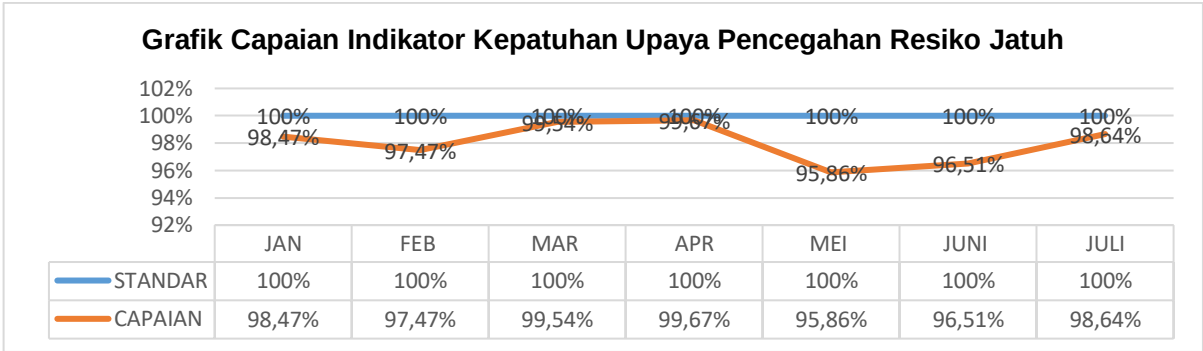


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,42%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.2.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

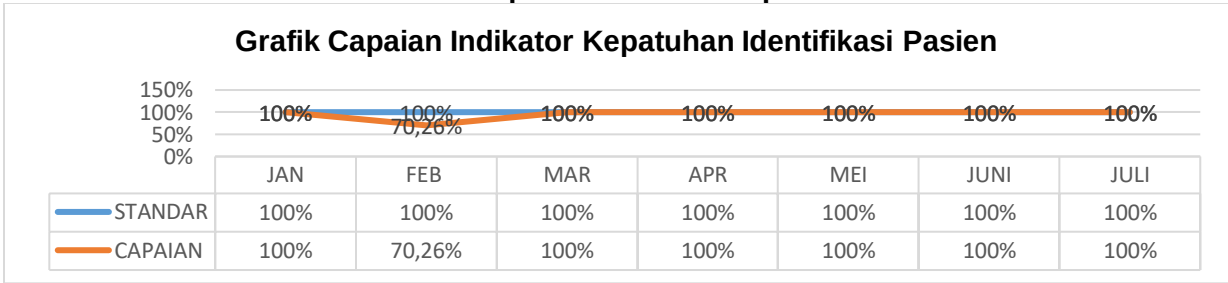
3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59 %	73,43%	79,11 %	78,13%	74,88%	71,82%

6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77 %	56,18%	61,29 %	58,52%	54,92%	50,64%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%

3.6.1.2.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

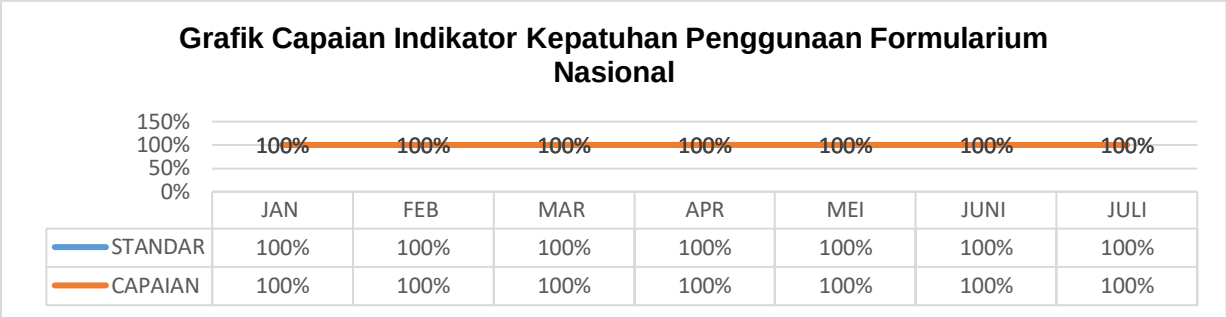
3.6.1.2.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari hingga Juli capaian telah mencapai standart 100%. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasien beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Meningkatkan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

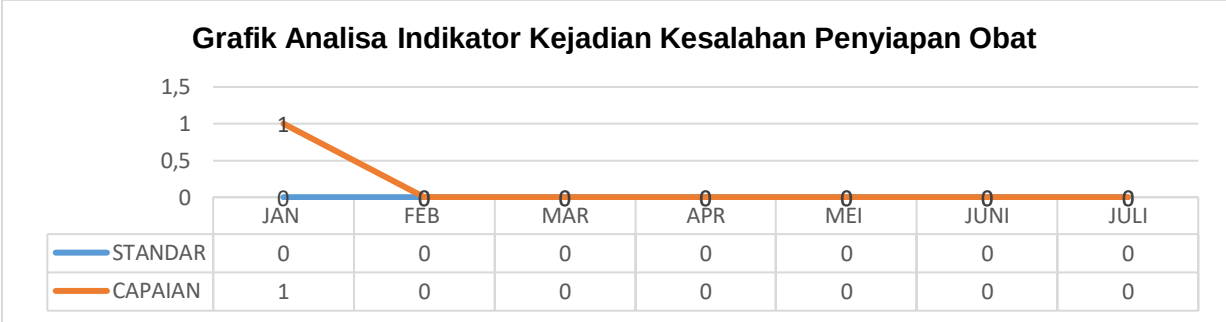
3.6.1.2.2.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.2.3 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

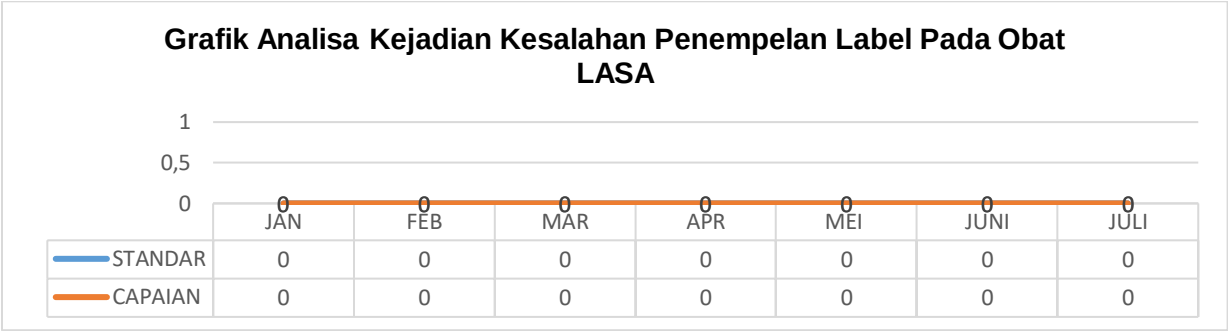
3.6.1.2.2.3.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO	6. Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 7. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 8. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga Juli tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	1. Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.4 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

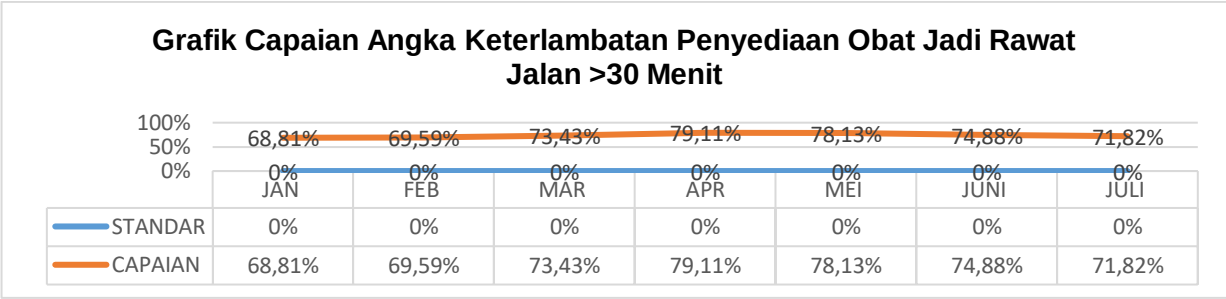
3.6.1.2.2.4.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

3.6.1.2.2.5 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

3.2.1.2.2.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

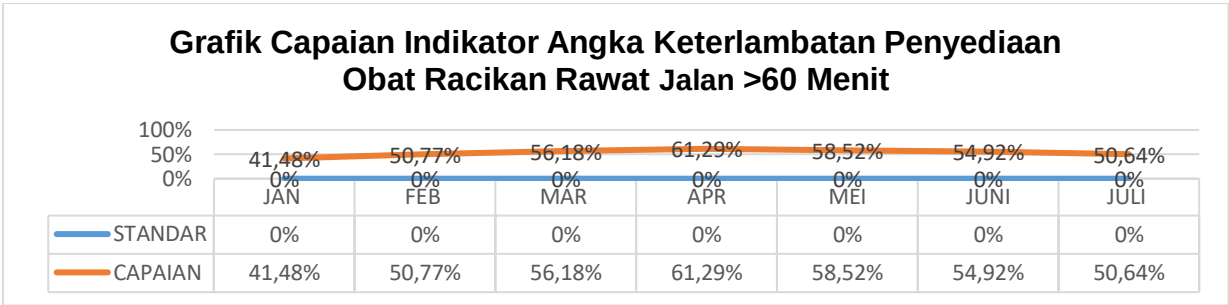


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada petugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : 1. Pasien cendereung naik beberapa hari. 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

			pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.2.2.6 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

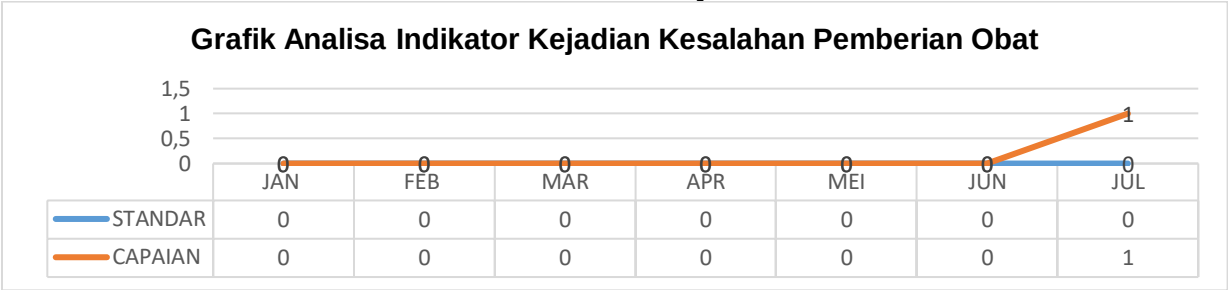
3.6.1.2.2.6.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.					
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai					
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena: 1. Pasien cendereung naik beberapa hari 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resepan, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai		Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.7 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

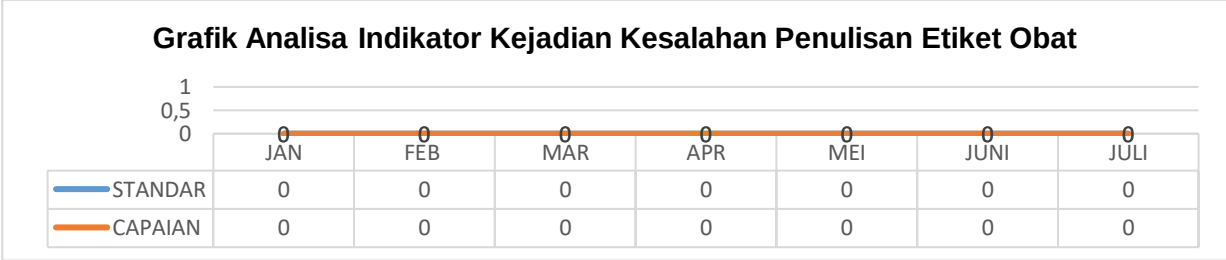
3.6.1.2.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kejadian kesalahan pemberian obat hingga mencapai standart yaitu 0 kejadian				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien yang mendapatkan resep 2. Melakukan rapat berasama kepala instalasi farmasi guna melakukan supervisi terkait kepatuhan identifikasi pasien dalam proses pemberian obat.				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Juni tahun 2024 tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat. Pada bulan Juli tahun 2024, ditemukan 1 kejadian kesalahan pemberian obat karena petugas tidak teliti muali proses penyiapan hingga pemberian obat ke pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak melakukan identifikasi dengan benar.	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.8 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

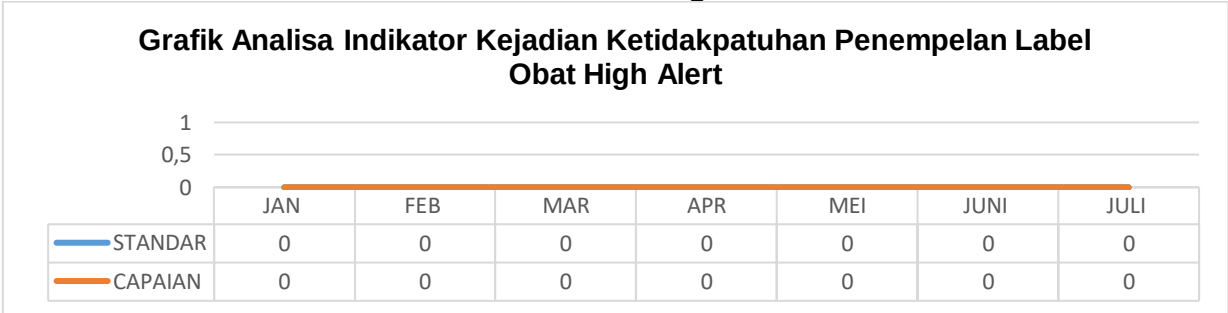
3.6.1.2.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

3.6.1.2.2.9 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

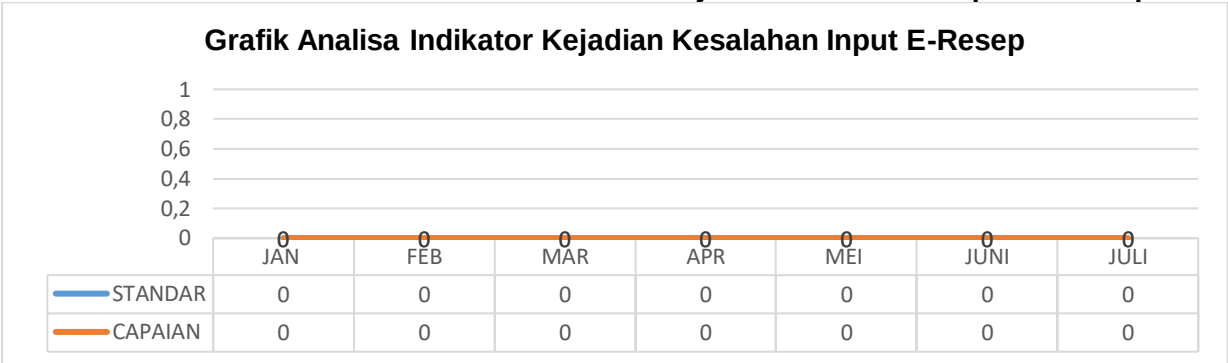
3.6.1.2.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

3.6.1.2.2.10 Kejadian Kesalahan Input E-Resep

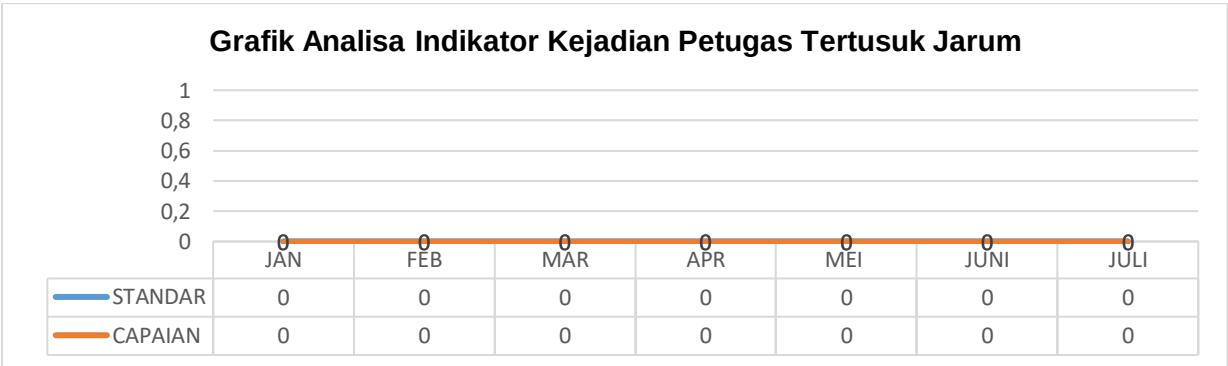
3.6.1.2.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep



Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

3.6.1.2.2.11 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

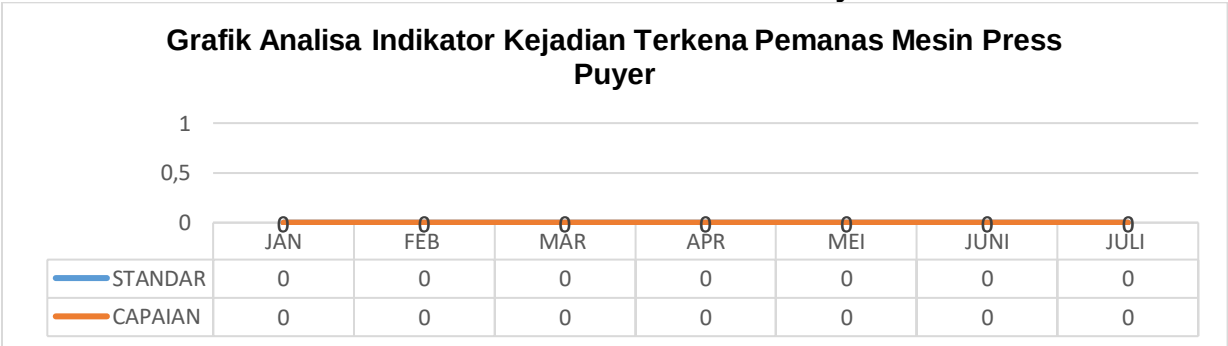
3.6.1.2.2.11.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

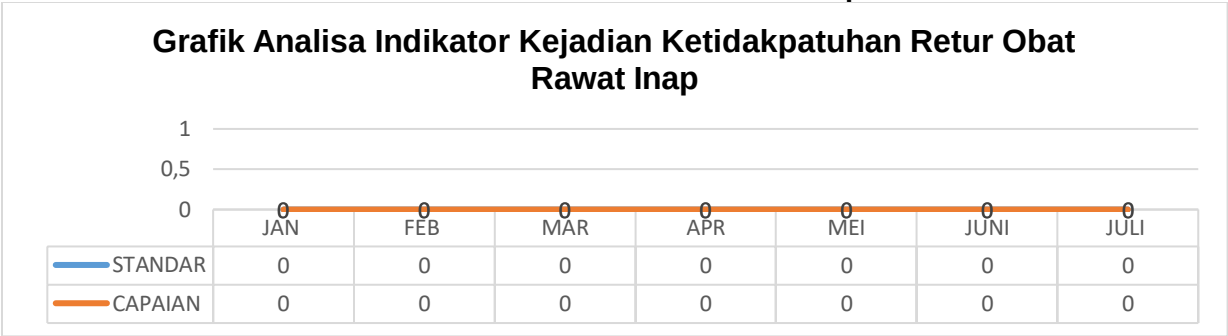
3.6.1.2.2.12 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.1.2.2.12.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



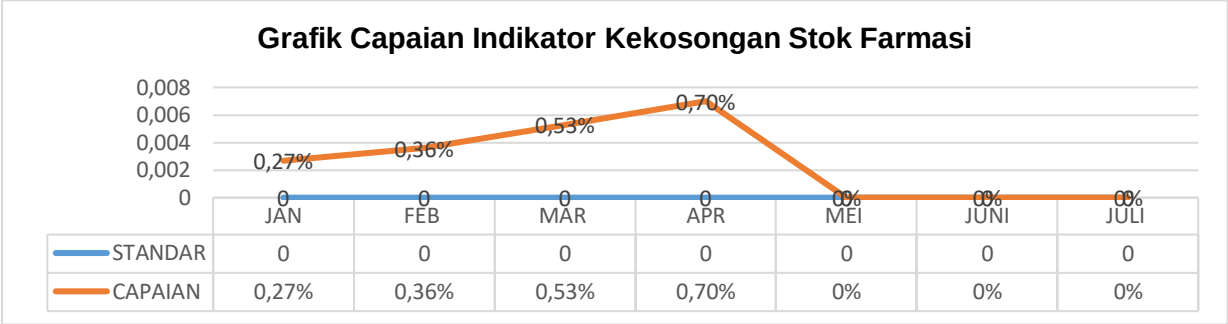
Analisis :
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

3.6.1.2.2.13 Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap
3.6.1.2.2.13.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisis Capaian :
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024.

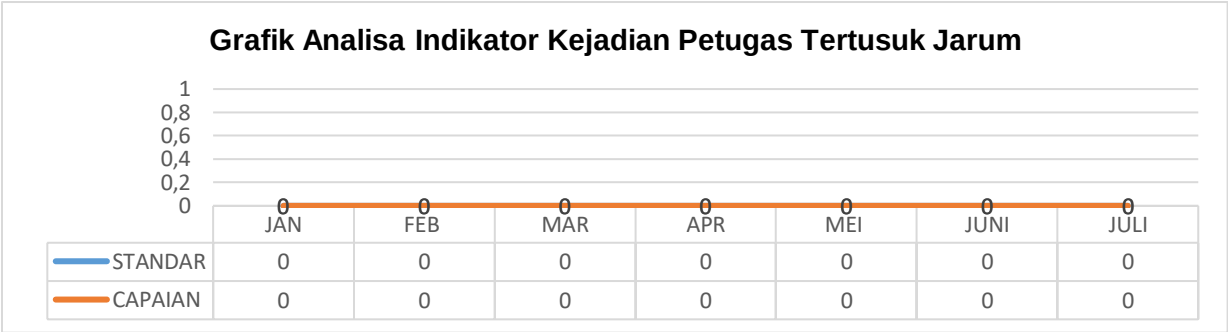
3.6.1.2.2.14 Kekosongan Stok Sediaan Farmasi
3.6.1.2.2.14.1 Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi pada bulan Januari hingga April. Pada bulan Mei hingga Juli masih ada kekosongan obat teratasi dengan adanya substitusi sehingga tidak mengganggu pelayanan. Kekosongan obat farmasi disebabkan karena : 1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yang dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf 2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada 3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan 4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali 5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf 6. Ijin edar obat tertentu belum di setuju bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	1. Kepala Instalasi farmasi 2. Pengadaan Farmasi PT	Satu bulan

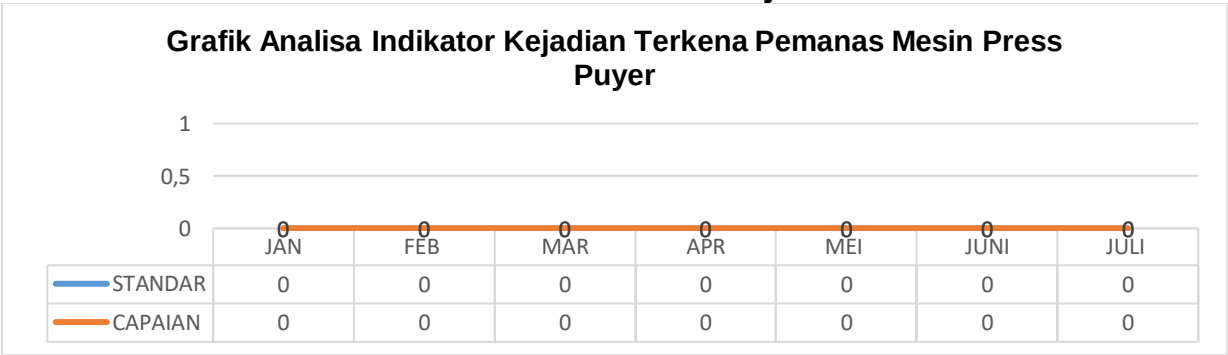
3.6.1.2.3 Manajemen Resiko									
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6.1.2.3.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
3.6.1.2.3.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.3.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer
3.6.1.2.3.2.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024.

3.6.1.3 Mutu Unit
3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25%	100%	100%	100%	100%	97,35%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17%	0%	0,28%	0,15%	0,67%	0,15%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85%	0,61%	0,73%	0,5%	2,61%	1,62%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.2.1.3.2 IRNA 2A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%					97,64%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%					45,54%	76,92%	90%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%					-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%					100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%					0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%

3.2.1.3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41%	100%	97,22%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53%	74,84%	73,57%	73,23%	62,6%	62,6%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-	0%	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93%	100%	93,75%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,03%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%	97,14%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	86,36%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18%	89,4%	91,28%	80,29%	87,79%	91,45%	86,99%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,61%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96%	87,65%	82,43%	83,94%	89,17%	91,45%	93,15%

3.2.1.3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84%	78,23%	86,54%	86,84%	89,19 %	95%	95%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,75%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	97,4%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%	0%	0,39%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07%	66,86%	64,86%	55,35%	67,48%	67,48%	66,67%

3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13%	97,75%	93,02%	96,38%	95,58%	95,58%	94,59%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.7 IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11%	79,63%	84,92%	83,21%	82,79%	76.47%	71,01%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	3,57%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.8 IRNA 7A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	MAR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,22%	76,67%	75%	84,56%	76,74%	63,78%	72,73%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,67%	100%	100%	100%	97,12%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	0%	0,9%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	86,52%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,09%	100%

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	92,21%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39%	78,49%	81,45%	84,56%	71,76%	75,93%	82,14%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15%	100%	100%	96,72%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	98,91%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.10 ICU									
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7%	100%	100%	94,4%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%							
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8%	92,53%	86%	90,4%	100%	100%	80%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%	90,7%	95,4%	94,4%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%

3.2.1.3.2.11 HCU									
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	96,3%	100%	100%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.12 IRJA									
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75%	100%	95,71%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74%	52,7%	63.8%	72,8%	80,97%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	84,42%	82,35%	84,04%	84,04%	70.04%	81,72%	81,72%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%	37,03%	0%	0%

3.2.1.3.2.13 Maternitas									
NO.	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,63%	100%
6	Angka keterlambatan operasi sectio caesaria	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

	(SC) > 30 menit								
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0	0	0	4
10	Kejadian partus lama	0	1	2	0	0	0	3	4
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0	0	0	0
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.14 NICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92%	90,63%	84,72%	90,8%	84,82%	82,35%	88,79%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kematian Bayi	0	0%	0%	0%	0%	3,7%	1,28%	4,55%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.15 IKO

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10	10	10	82,35%	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0	0	0%	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	1,28%	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama	0	0	0	0	0	0	0	0

	anestesi								
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	100%	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	-	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	100%	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0	0	100%	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	-	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0	100%	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08%	0%	0%	82,35%	20,96%

3.2.1.3.2.16 Laboratorium

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48%	97,5%	98,9%	99,68%	100%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2	2	12	15
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.17 Radiologi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,54%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%	3,81%	3,81%	1,63%	0%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.18 Gizi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.19 Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0

4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%	78,13%	75,45%	71,82%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%	58,52%	54,92%	50,64%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.21 PPI

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APRIL '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %	0,24 %	0 %	0,25 %
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%	0,15%	0,15%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53 %	85,62%	85,62%	85,42%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%	93,73%	93,73%	93,92%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%	92,19%	92,18%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.22 PIPP

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%	99,63%	99,63%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94%	75,31%	57,76%	52,92%	55,36%	55,36%	43,54%

3.2.1.3.2.23 SDM

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0	1	2	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99%	98,97%	99,14%	98,76%	95,9%	98,93%	98,96%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%	4,12%	5,09%	3,88%

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65%	93,04%	94,08%	93,81%	93,56%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06%	9,44%	7,88%	5,68%	4,56%

3.2.1.3.2.25 Keuangan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim lebih dari 90 hari	0%	7,7%	6%	3,86%	10,98%	1,57%	0,78%	0,81%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.26 K3RS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04%	0,78%	0,97%	-	0,62%	0,89%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04%	2,17%	1,66%	2,25%	1,66%	1,31%
3	Angka kelengkapan berkas klaim	100%	9,73%	0,57%	0,44%	0,42%	0,55	0,46%	0,55%

	di SIMRS (Indikator baru 2024)								
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1	0	0	0

3.2.1.2.28 IPSRS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%	89,47%	91,67%	91,67%	91,84%

3.2.1.3.2.29 UMUM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3	6	6	2
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2	4	5	9

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service

NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	1,39%	1,67%	29,17%	28,95%	3,13%	3,45%	8,7%

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21%	0%	20,69%	78,38%	48,72%	26,67%	36,59%
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5%	71,83%	56,25%	41,67%	0%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71%	86,21%	22,73%	17,86%	0%

3.2.1.3.2.31 Laundry

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95%	4,19%	1,35%	1,48%	0,96%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0%	0%	0%	0	0

3.2.1.3.2.33 CSSD

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1	1	1	2

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN'24	JUL '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17%	90,88%	100%	100%	100%	98,65%	99,64%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82%	92,82%	91,73%	87,44%	94,21%

3.2.1.3.2.35 IT

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

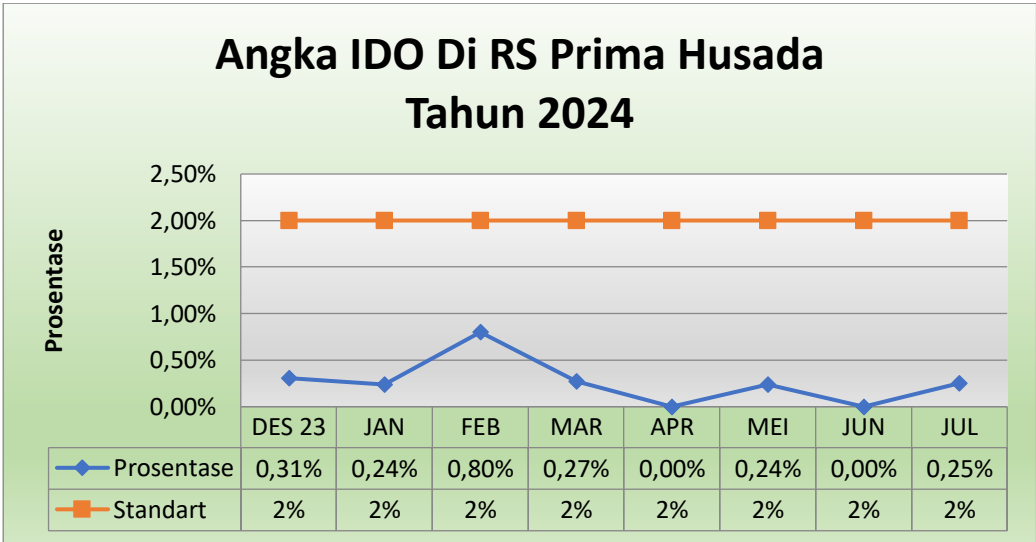
NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.2.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

3.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):

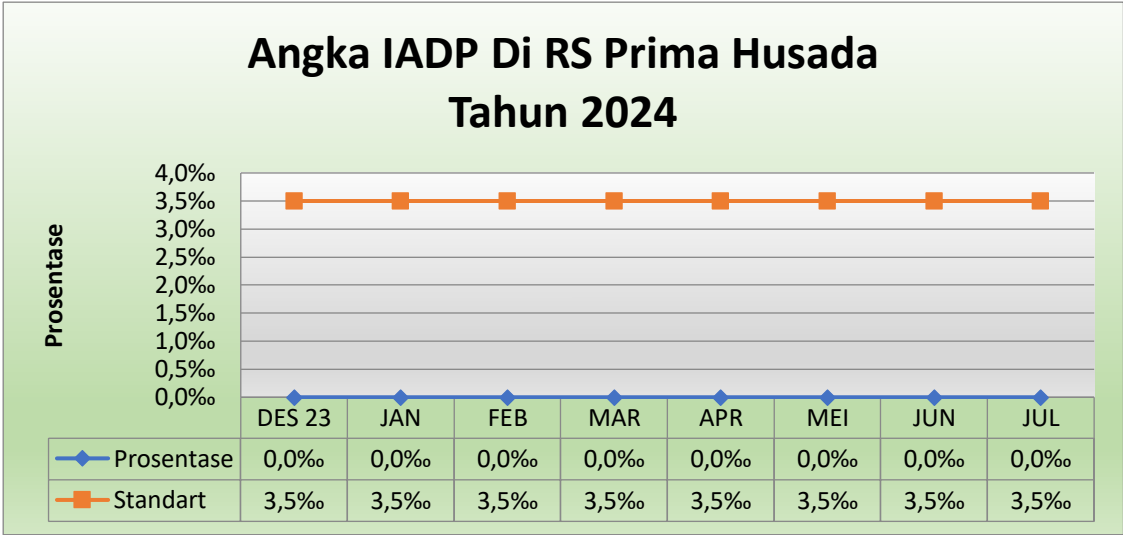


PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka IDO seminimal mungkin. (0%)
DO	1. Melakukan koordinasi dengan DPJP obgyn terkait Teknik aseptik pada saat melakukan perawatan luka maupun prosedur operasi. 2. Melakukan koordinasi dengan tim Kamar operasi terkait penggunaan kamar operasi dan pembersihannya saat ada operasi estafet (memakai kamar operasi yang berbeda, jika kamar operasi lainnya kosong). 3. Melakukan koordinasi dengan petugas unit perawatan untuk tetap menjaga Teknik aseptik saat melakukan proses perawatan luka pasien. 4. Berkoordinasi dengan ahli gizi dan perawat unit untuk pemantapan proses edukasi pasien terutama diit pasien pada saat pasien dirawat atau akan KRS. 5. Monitoring pembersihan alat dan kebersihan ruang kamar operasi tetap dilakukan secara rutin. 6. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai SPO.
STUDY	Ditemukan satu kasus IDO pada bulan ini pada pasien post SC. Pasien tidak memiliki Riwayat penyakit lain ataupun infeksi lainnya. Diit pasien juga normal. Operasi dilakukan estafet dengan sebelumnya sudah dilakukan 5 operasi estafet dengan memakai 2 kamar operasi dengan selisih waktu 30 menit antar pasien operasi (termasuk proses pembersihan ruangnya). Keadaan luka sedikit terbuka dan mengeluarkan darah.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan bundle IDO.	Pertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IDO.	Kepatuhan audit bundle IDO meningkat 3% pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian handscon steril saat rawat luka. 3. Monitoring kepatuhan mandi dengan air sabun sebelum operasi. 4. Monitoring kepatuhan penggunaan alat cukur satu kali pakai dan pembersihan wadah alat cukur yang dipakai berulang. 5. Monitoring kepatuhan petugas dalam menjaga aseptik saat melakukan rawat luka/tindakan bedah.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
Evaluasi proses pembersihan kamar operasi	Meminimalisir risiko terjadinya infeksi daerah operasi.	Penurunan kasus IDO pada operasi estafet.	1. Koordinasi dengan Karu IKO terkait penjadwalan pasien operasi estafet. 2. Mendahulukan pasien operasi bersih (non infeksi) jika kamar operasi dipakai estafet. 3. Mengevaluasi proses pembersihan kamar operasi saat dilakukan operasi estafet.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN 5. CS	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

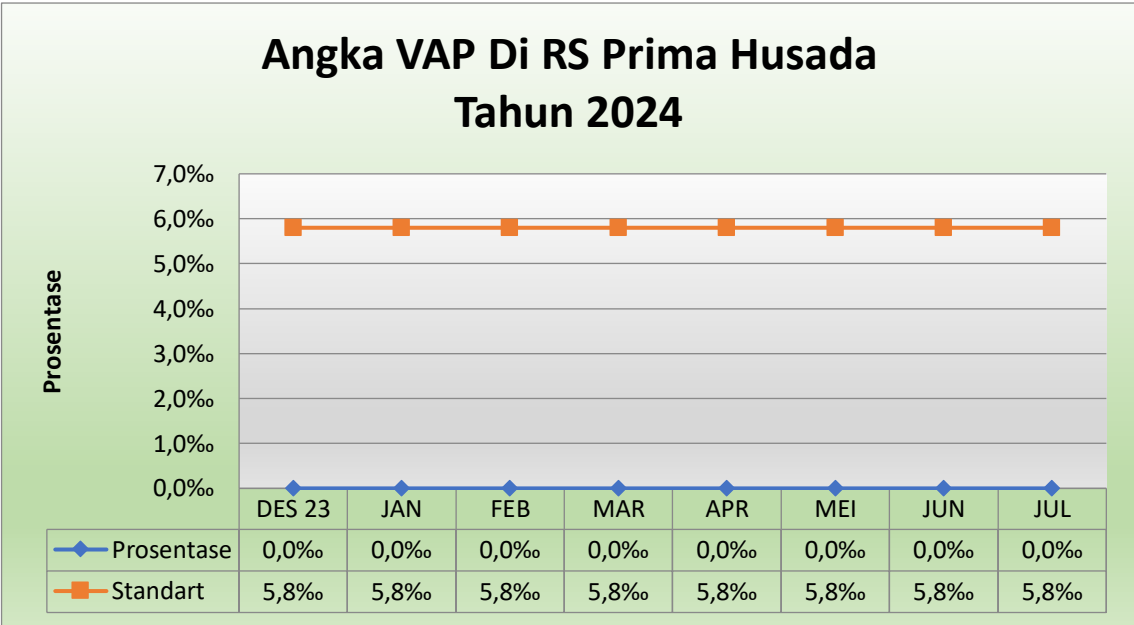
3.6.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka IADP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle IADP sesuai standart.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak dilakukan pemasangan CVC pada pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Kepatuhan bundle IADP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

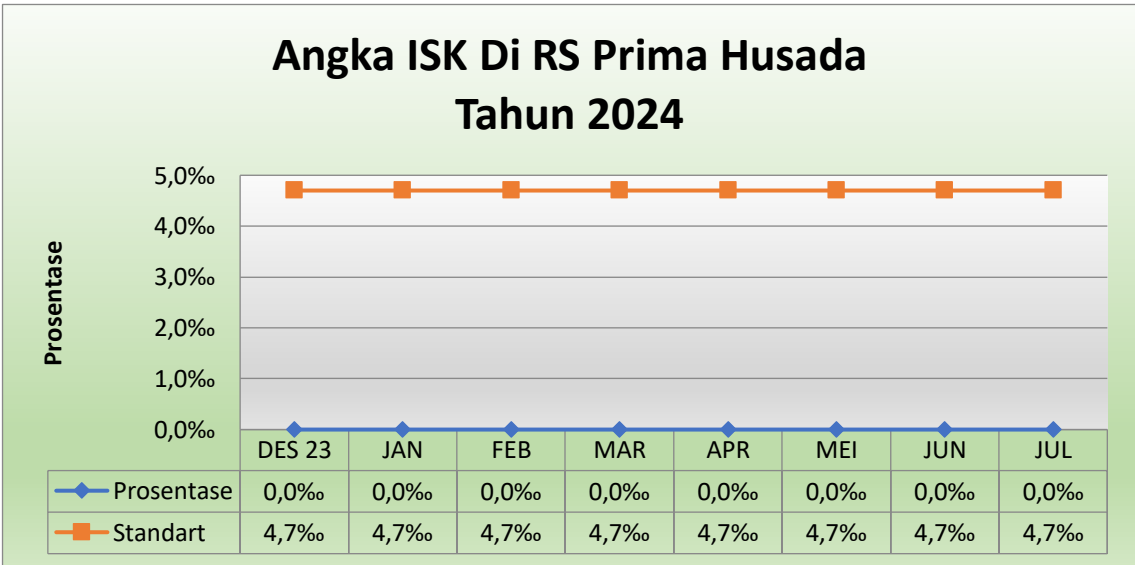
3.6.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka VAP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle VAP sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 40 hari lama pemasangan ventilator.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.	Kepatuhan bundle VAP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral <i>hygiene</i> .	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.4 ISK

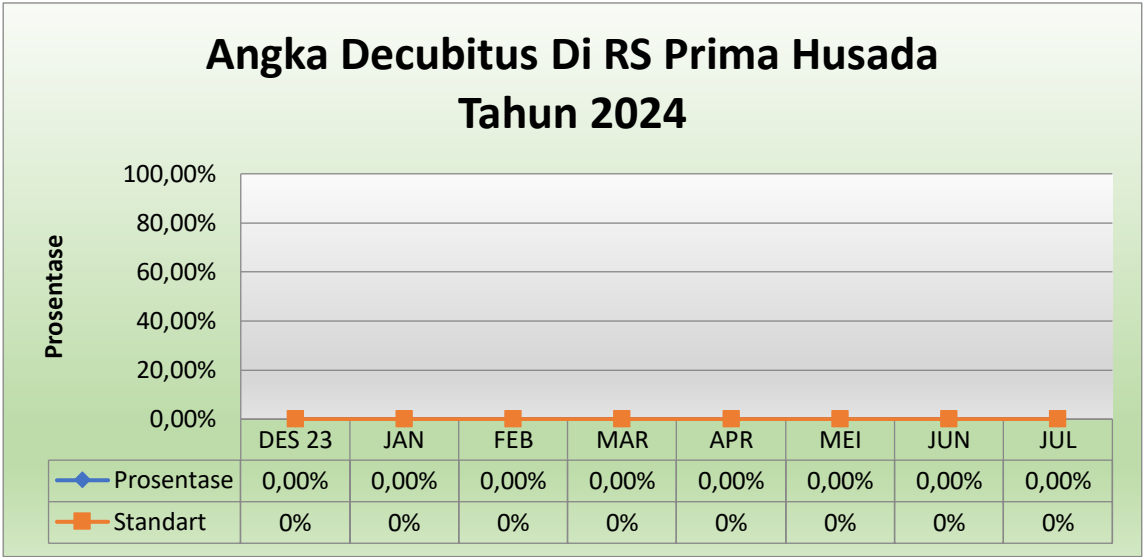
3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka ISK sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle ISK sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 942 hari lama pemakaian kateter pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

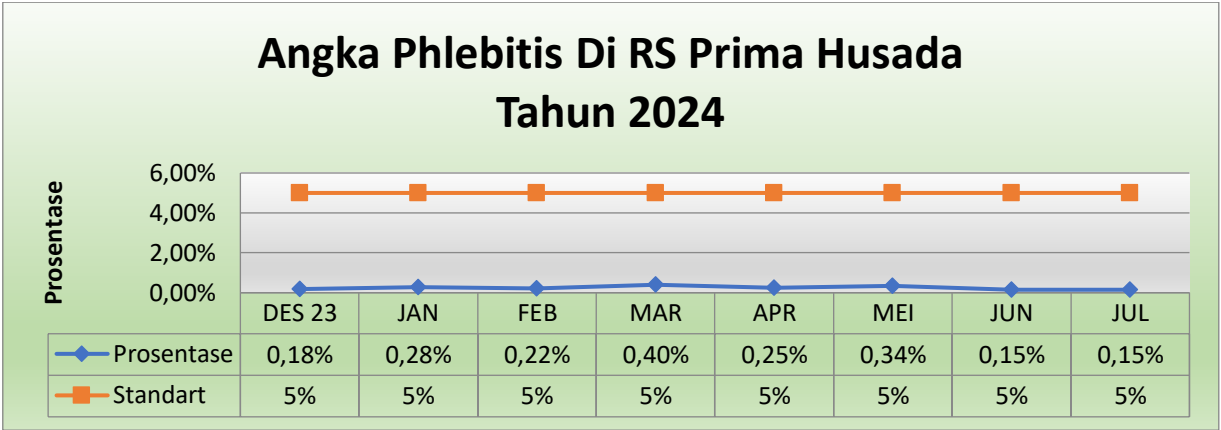
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka decubitus sesuai standart seminimal mungkin. (0%)				
DO	Monitoring pelaksanaan pencegahan decubitus pada perawatan pasien dengan tirah baring lama.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 10 pasien tirah baring lama (>3x24 jam).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Kepatuhan pencegahan dekubitus tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus. 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

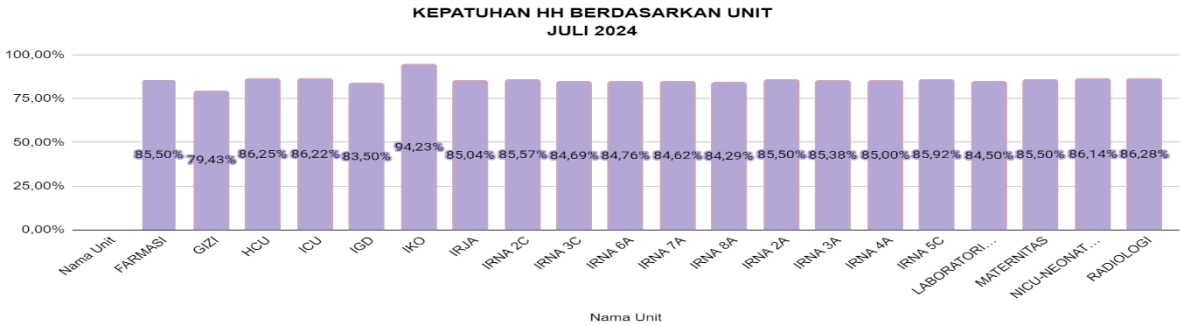
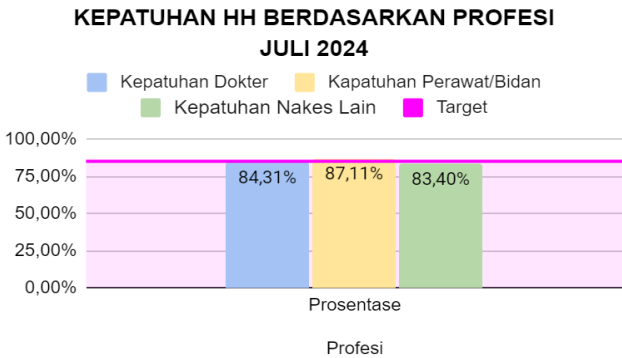
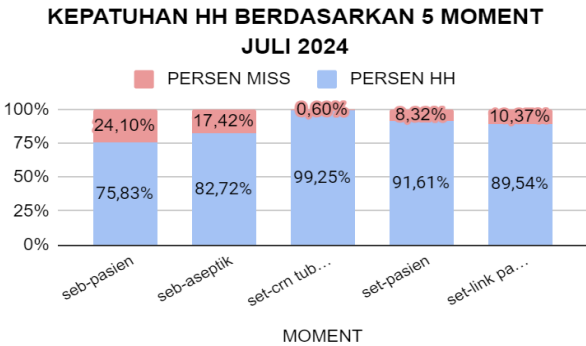
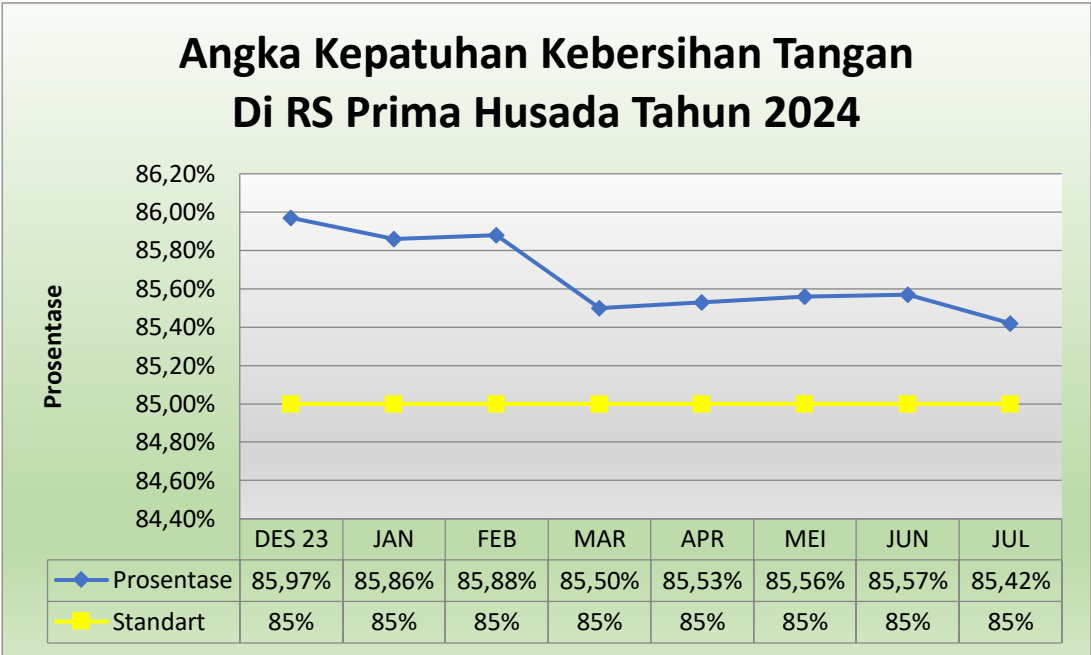
3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka phlebitis seminimal mungkin. (0%)				
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit bundle phlebitis sesuai SPO. 2. Melakukan sosialisasi kepada perawat tentang handhygiene dan pemakaian APD yang benar. 3. Berkolaborasi dengan komite keperawatan untuk melakukan supervisi berkala terkait prosedur pemasangan infus dan perawatan luka infus. 4. Monitoring pelaksanaan penyuntikan yang aman dan Teknik aseptic saat penyuntikan.				
STUDY	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2748 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,15%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 2 dari 4 pasien yang mengalami phlebitis merupakan pasien yang mendapat cairan/obat yang konsentrasinya lebih pekat (KCL dan D40%). 3 pasien yang mengalami phlebitis merupakan pasien lansia dan 1 pasien lainnya merupakan pasien anak-anak dimana pembuluh darah pasien cenderung lebih rentan phlebitis dan mendapatkan injeksi antibiotic. Dari 5 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus. 3. Monitoring teknik aseptic dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 4. Monitoring penyuntikan yang aman. 5. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic. 6. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. 7. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)

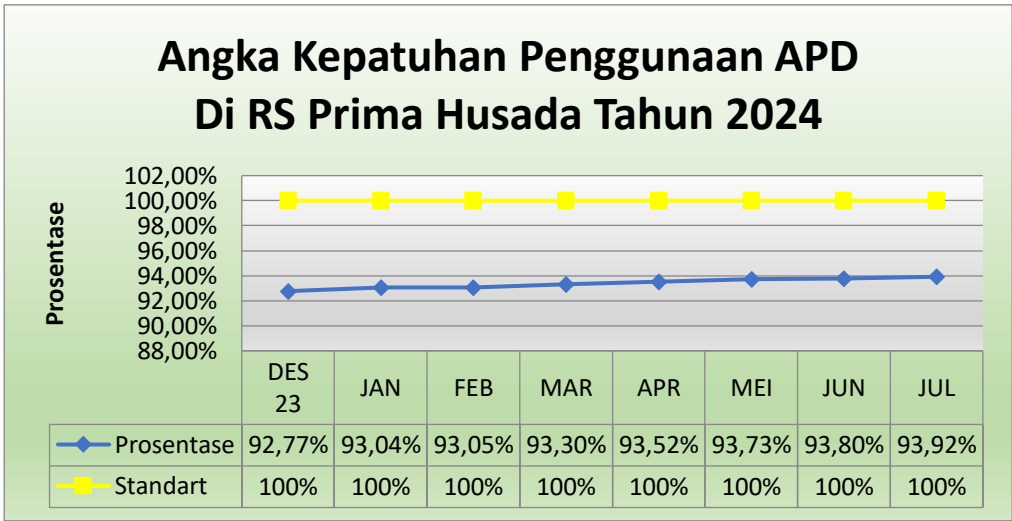


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,42%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,31%) dan nakes lain (83,40%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (75,83%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat

	di audit baru patuh). Namun beberapa perawat sudah mengurangi penggunaan sarung tangan bedah sesuai dengan kebutuhannya saja. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatnkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

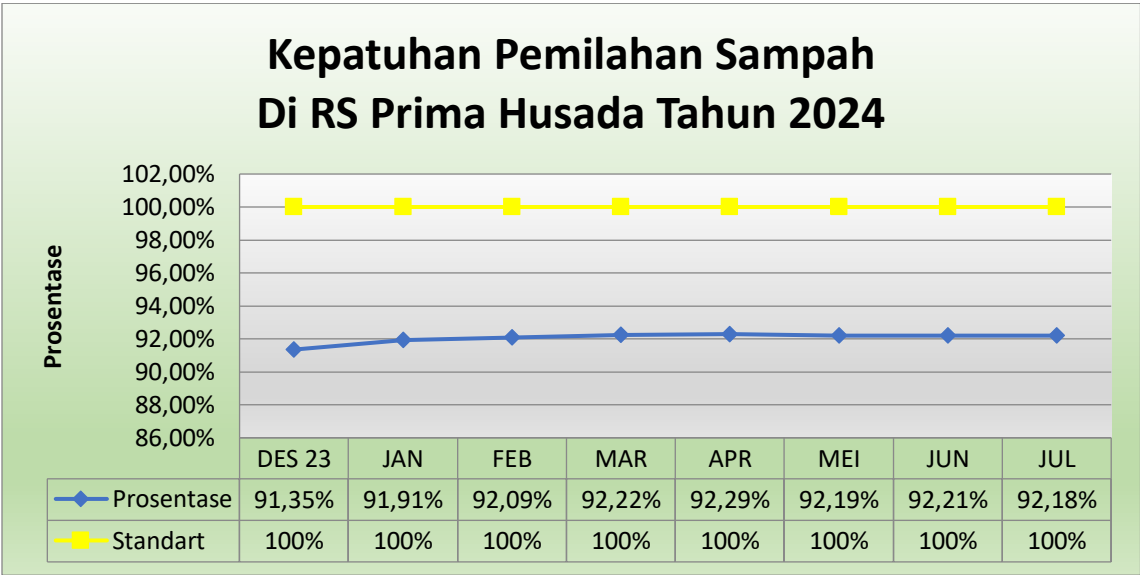


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,92% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit sudah mulai sedikit paham dan bisa menggunakan APD yang sesuai.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. 2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. 3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 4. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan
---------------------------------------	---	--	--	---	------------

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.
DO	1. Melakukan supervise terkait pemilahan pembuangan sampah di unit pelayanan pasien. 2. Melakukan supervise terkait pembuangan sampah di ruang TPS B3. 3. Melakukan sosialisasi pemilahan sampah yang yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar.
STUDY	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,18%, sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan kesalahan pemilahan sampah terutama pada sampah infeksius yang peletakkannya di area umum, karena keluarga pasien sering salah membuang sampah rumah tangga di sampah infeksius meskipun sudah diberi stiker tempelan penanda sampah infeksius. Selain itu masih ditemukan petugas yang tidak tertib membuang isi cairan terlebih dahulu sebelum membuang botol infus.

	2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervisi terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	MEI	JUN	JUL	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

Analisis : Pelaksanaan KIE individu dilakukan oleh Perawat di ruangan, kelemahan terdapat pada pendokumentasian hasil dari KIE yang telah dijelaskan

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi untuk Ketertiban dalam pendokumentasian dalam DRM

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	MEI	JUN	JUL	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	8	8		Isi sesuai	Ya	Kekurangan TTD pada nama petugas
2	SBAR	8	8		Isi sesuai	Ya	Ketidaklengkap an pada

							penulisan nama petugas dan nama pasien yg jelas
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	8	8		Isi sesuai	Ya	Nama Petugas tidak terisi lengkap
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	8	8		Isi sesuai	Ya	
5	KIE Informed Consent	8	8		Isi sesuai	Ya	Nama Petugas Tidak terisi lengkap
6	CPPT	8	8		Isi sesuai	Ya	-
7	Ringkasan Pasien Pulang	8	8		Lengkap	Ya	-
8	Discharged Planning	8	8	0			
9	Edukasi kolaborasi	8	8	0	Isi sesuai	Ya	-
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	1	1	0	Isi sesuai		
12	Form AMA	1	1	0	Isi Sesuai	Ya	
13	Semua Form yang ada Pemberian Informasi Ke Pasien	8	8	0	Isi Sesuai	Ya	
14	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	1	1	0	Isi Sesuai	Ya	

Analisis : Seluruh DRM edukasi terisi , terdapat beberapa ketidaklengkapan meliputi kekurangan pada penulisan nama petugas pemberi KIE , kekurangan pada isi yang kurang lengkap di perencanaan edukasi .

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi kepada PPA Pelaksana untuk melengkapi DRM dengan baik dan benar

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

NO	UNIT	TARGET	KEGIATAN	MEI	JUN	JUL	%	MANDOK	KET
1	Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						
2	Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						
3	Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Karya wisata						
4	Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
5	Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
6	General Meeting Karyawan	1x/2Bulan			100%			Terlaaksana	

7	Pembinaan Fatayat	1X/Tahun	
---	-------------------	----------	--

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	MEI	JUN	JUL	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	100%	100%		
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	100%	100%		
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	100%	100%		
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	50%	50%		
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		

Analisis : PROGNAS telah memulai Kegiatan Edukasi di bulan Juli

Rencana Tindak Lanjut : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat untkatkan produktivitas Tim Prognas

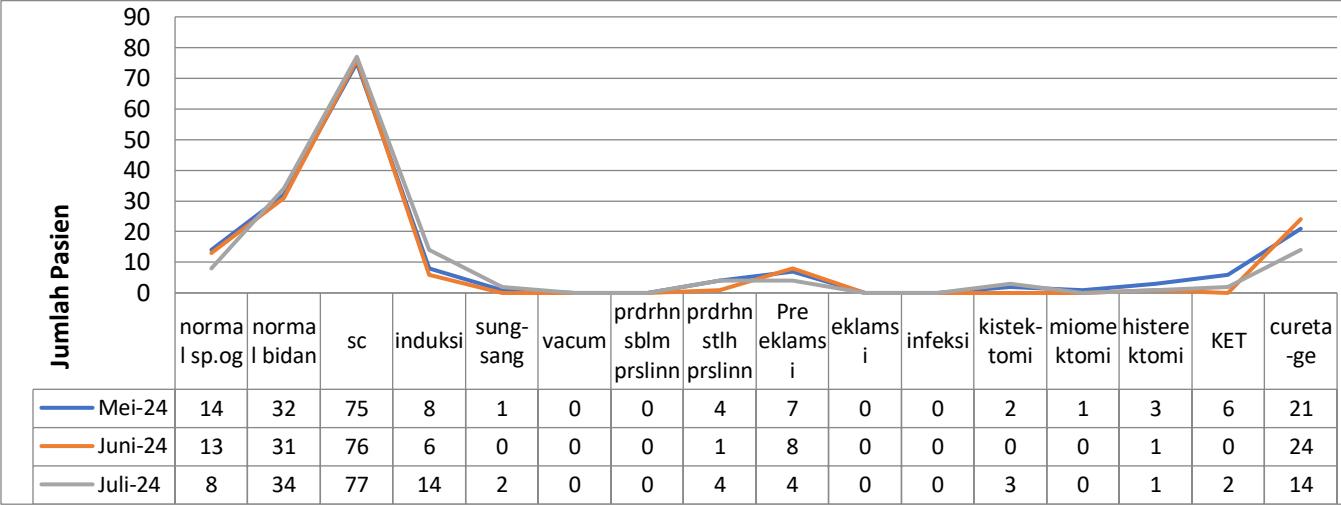
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Juli 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	14	13	8
	b. Persalinan Normal Bidan	32	31	34
	c. <i>SectioCaesaria</i>	75	76	77
2				
	a. Induksi / Drip	8	6	14
	b. Sungsang	1	0	2
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	4	1	4
	c. Pre Eklamsi	7	8	4
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	0	0	0
4				
	a. Curretage	21	24	14
	b. Kistektomi	2	0	3
	c. Miomektomi	1	0	0
	d. Histerectomy	3	1	1
	e. KET	6	0	2

3.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada Juli 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 77 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 8 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan juga mengalami sedikit peningkatang jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 34 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Terdapat 2 Persalinan sungsang pada bulan Juli 2024 sedangkan pada bulan Mei ada 1 persalinan sungsang. Sedangkan untuk persalinan dengan vacum pada bulan Mei sampai dengan Juli 2024 tidak ada.
4. Induksi Persalinan pada bulan Juli mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 14 pasien
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 4 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Mei sampai dengan Juli 2024.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan Juli menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 14 pasien. *Curetage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

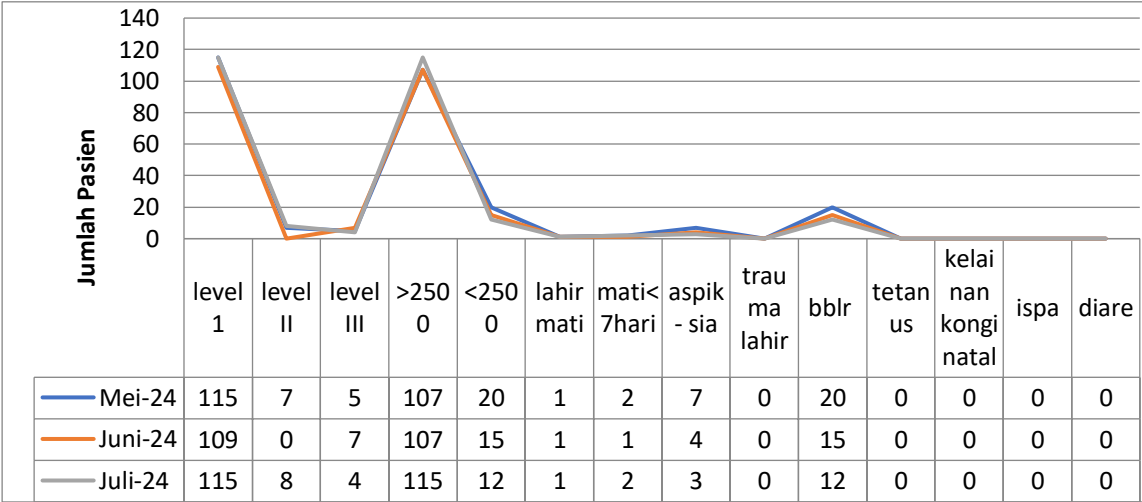
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponек Juli 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1				
	a. Level 1	115	109	115
	b. Level II	7	6	8
	c. Level III	5	7	4
2				
	a. ≥ 2500 gram	107	107	115
	b. ≤ 2500 gram	20	15	12
3				
	a. Kelahiran Mati	1	1	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	2	1	2
4				
	a. Asphyxia	7	4	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	20	15	12
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Juli 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 115 bayi. Dan pada level 2 juga meningkat yaitu 8 bayi. Sedangkan pada level 3 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 4 bayi.
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Juli 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya tetap sebanyak 115 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

4. Kasus BBLR pada bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 12 bayi.
5. Kasus kelahiran mati pada bulan Mei sampai Juli tetap yaitu sebanyak 1 kasus
6. Masih ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Mei dan Juli sama yaitu 2 kasus, sedangkan pada bulan Juni terdapat 1 kasus kematian.

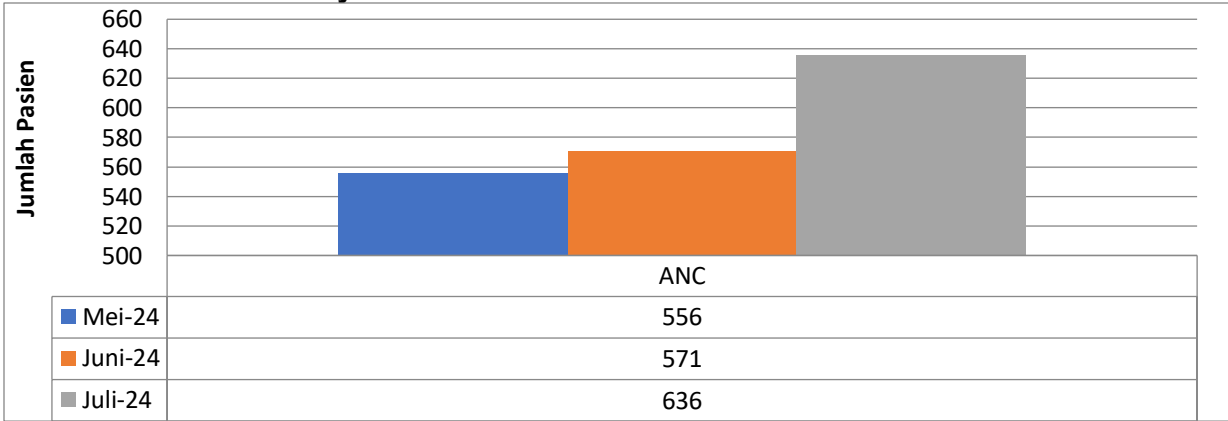
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek RSPHM Juli 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	ANC	556	571	636

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Juli 2024

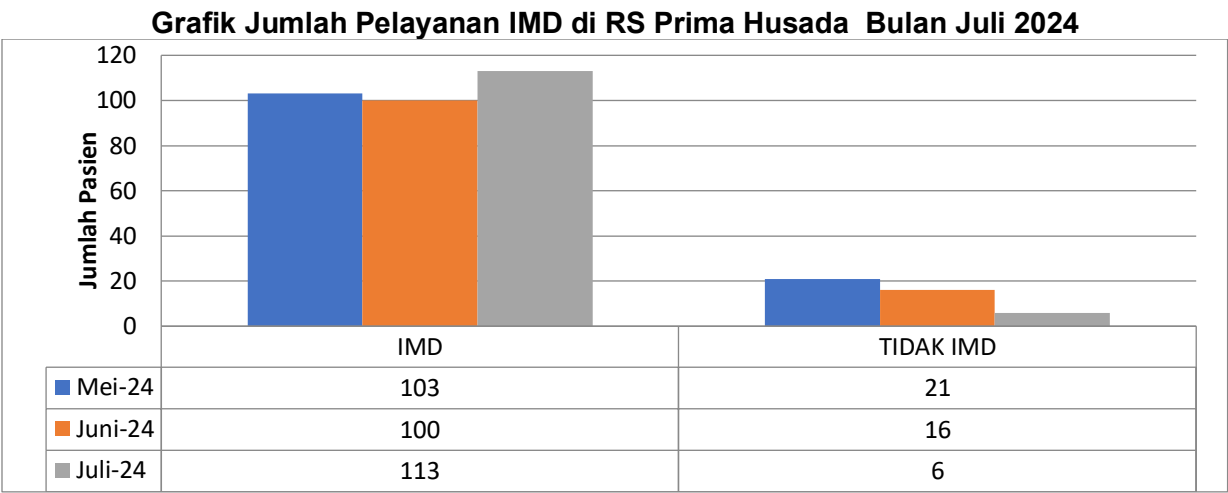


Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Juli 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 636 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Juli 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	IMD	103	100	113
2	Tidak IMD	21	16	6



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juli 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 113 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

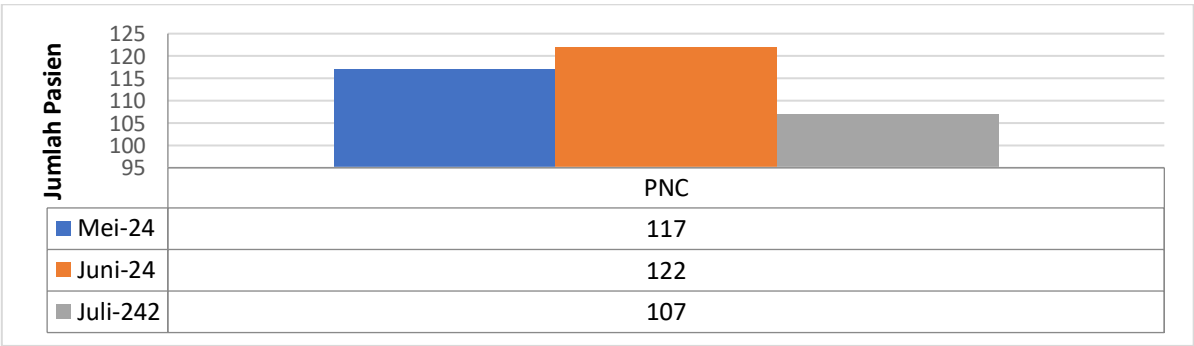
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Juli 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	PNC	117	122	107

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan Juli 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 107 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

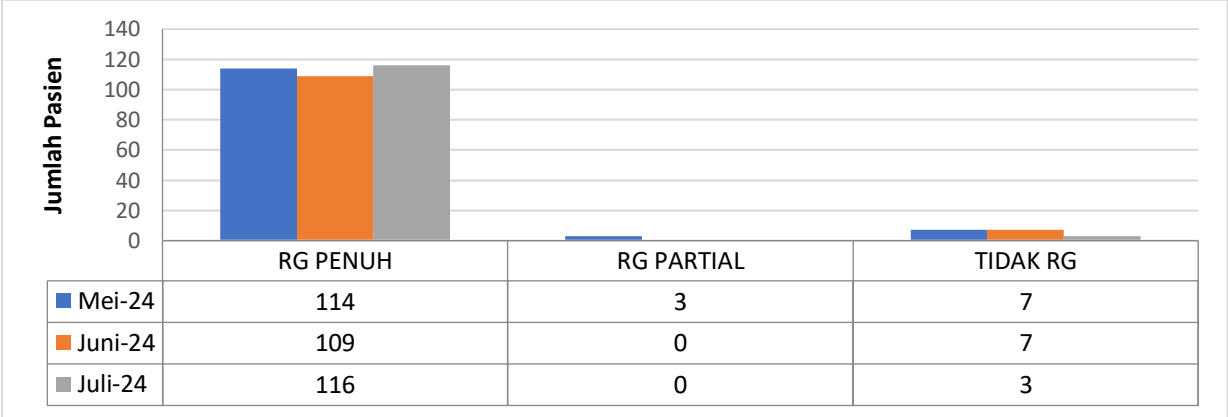
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung

Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Juli 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	Rawat gabung penuh	114	109	116
2	Rawat gabung partial	3	0	0
3	Tidak Rawat gabung	7	7	3

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Juli 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 116 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Juli menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu sebanyak 3 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

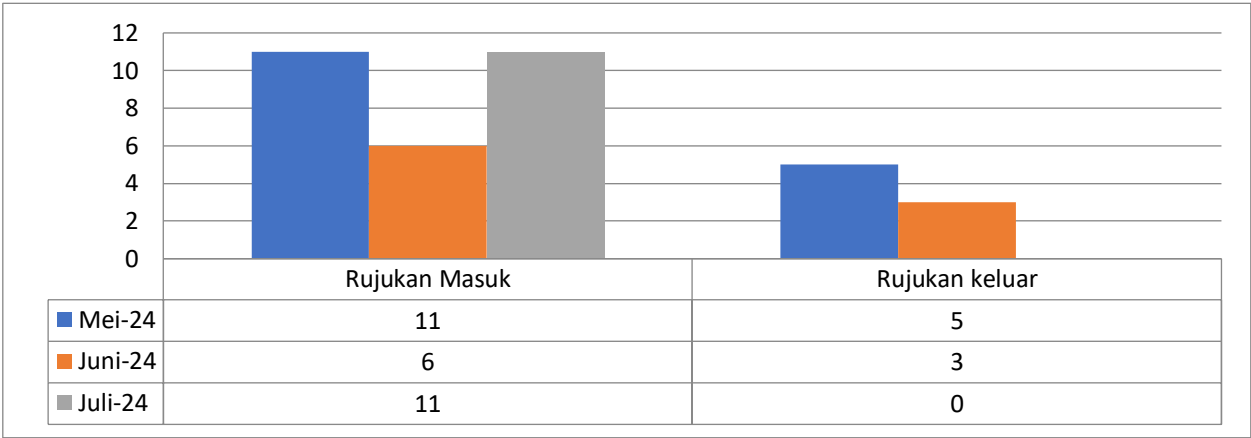
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan

Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponek Juli 2024

NO	RUJUKAN	BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	Rujukan Masuk	11	6	11
2	Rujukan keluar	5	3	0

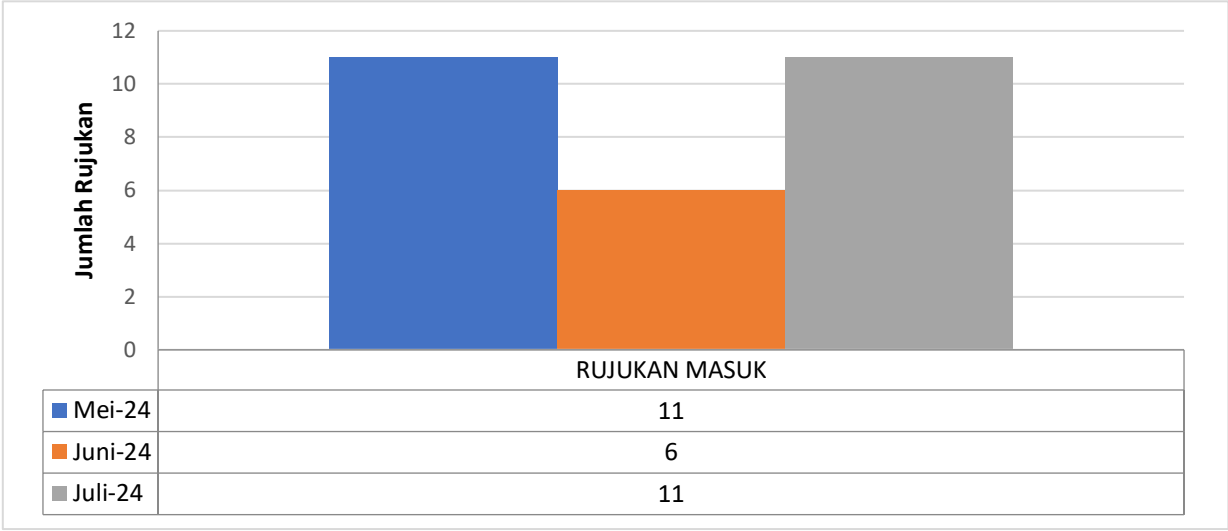
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Juli 2024



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponек Juli 2024

BULAN MEI 2024		
1	G1 P0000 Ab000 Uk 35-36 mgg dg PPR0M	RS Permata Bunda
2	Late HPP + lekosinosis + anemia	PKM Pakis
3	G2 P1001 ab000 Uk 35-36 mgg dg PPI + letak lintang	RS Munir
4	G3 P2002 Ab000 Uk 32-33 mgg dg BSC 2x	BPM Indah M
5	G2 P0000 Ab000 Uk 30 mgg dg PPI	RS Permata Bunda
6	G2 P1001 ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	PKM Ardimulyo
7	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Tri Widiyawati
8	G1 P0000 Ab000 Uk 28-30 mgg dg Gemeli + PPI	BPM Nuri Afanti
9	G3 P2002 Ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Suma'iyah
10	KET + ANEMIA	Klinik Putra Husada
11	G1 P0000 ab000 Uk 32-34 mgg dg KIFL + PPI	Rs Permata Bunda
BULAN JUNI 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 31-32 mgg dg PEB + PPI + PTS	RS Permata Bunda
2	G3 P2002 Ab000 UK 12-14 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
3	G2 P1001 Ab000 UK 40 – 41 mgg dg PE	BPM Indah M
4	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Tri Widiyawati
5	G4 P0302 Ab000 UK 28-30 mgg dg Letsu + BSC + KIFA	BPM Dillah Sobirin
6	G3 P1001 Ab100 UK 39-40 mgg dg Kala 1 fase aktif	BPM Susmui
BULAN JULI 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD	BPM Siti Rubaiyah
2	P2002 Ab000 dg Post partum H-10 + late HPP	BPM Tri Widiyawati
3	G2 P1001 Ab000 Uk 37 mgg dg KIFA	BPM Suci Astuti
4	G3 P1001 Ab100 UK 38-39 mgg dg HT	BPM Sofia Faridah
5	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg Dg KPD + kala 2 lama	BPM Titik S
6	G3 P2002 Ab000 Uk 8 -10 mg dg Abortus Imminen + Apendicitis Akut	RS Permata bunda
7	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg dg TPHA reaktif	PKM Singosari
8	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFL + KPD + IUGR	PKM Singosari
9	G1 P0000 Ab000 UK 39 – 40 mgg dg HT Gestasional	PKM Singosari
10	G3 P0010 Ab100 UK 11-12 mgg dg abortus Inkomplit	PKM Singosari
11	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg PRM + OBS Febris+ lekositosis	PKM Ardimulyo

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 rujukan masuk.

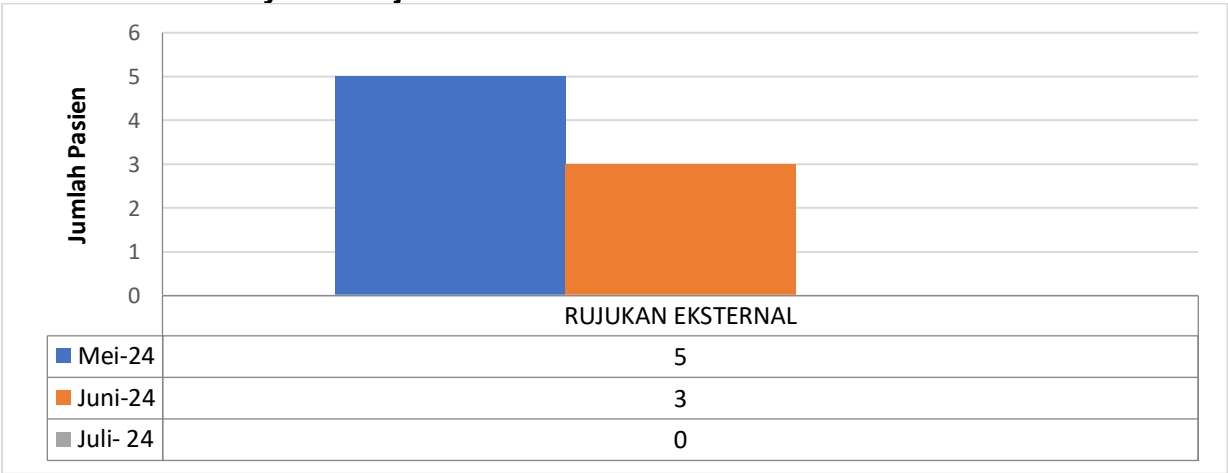
Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponek Juli 2024

BULAN MEI 2024		
1	G4 P2012 Ab000 Uk 26-28 mgg dg Gemeli + PE + edema paru	RS Saiful Anwar
2	G4 P2002 Ab000 UK 28-30 mgg dg Inpending Eklamsia	RS Saiful Anwar
3	Prematur BBLASR + RDS okHMD dd Neonatal Pneumonia	RS Saiful Anwar
4	Post Op Eksplorasi Laparatomi + CKD	RS Saiful Anwar
5	Neonatal seizure	Rs Soepraoen
BULAN JUNI 2024		
1	G1 P0000 Ab000 Uk 37-38 mgg dg Kala 2 + letak Sungsang	RS Prasetya Husada
2	G3 P0101 Ab000 Uk 32-34 mgg dg PPI + DF+ Trombositopenia	RS Saiful Anwar
3	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar
BULAN JULI 2024		
	-	
	-	

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

Pada bulan Juli 2024 tidak ada pasien yang dirujuk keluar

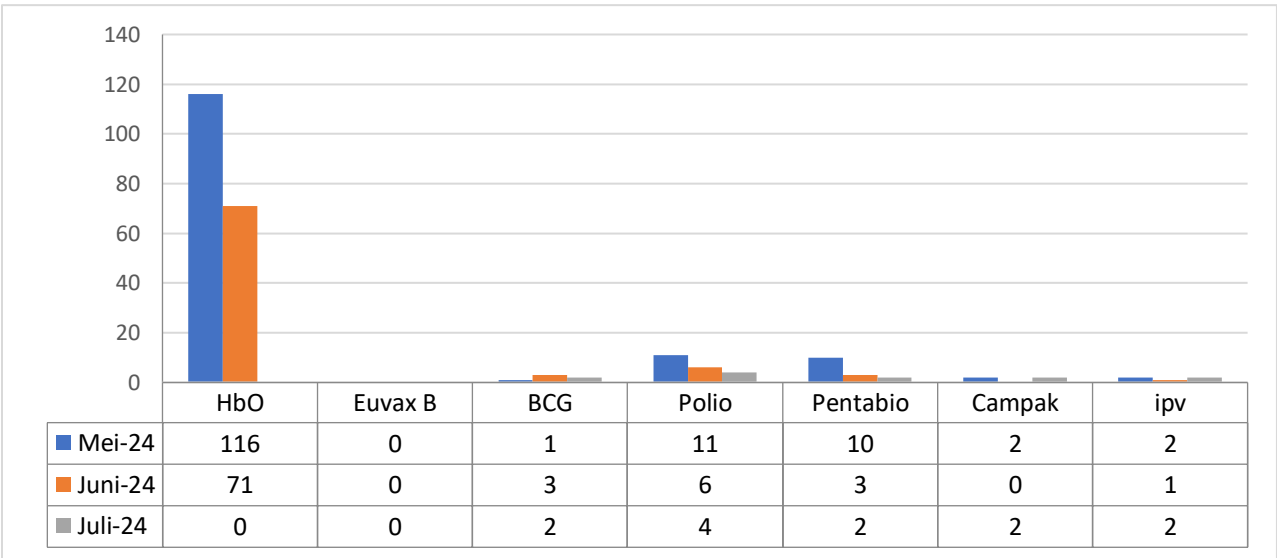
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Juli 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	HbO	116	71	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	3	2
3	Polio	71	66	4
4	Pentabio	70	63	2
5	Campak	2	0	2
6	IPV	2	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Juli 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
2. Tidak ada Imunisasi Hbo pada bulan Juli dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juli sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juli 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien.
5. Pada periode Juli 2024 Imunisasi Campak mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 bayi

7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien

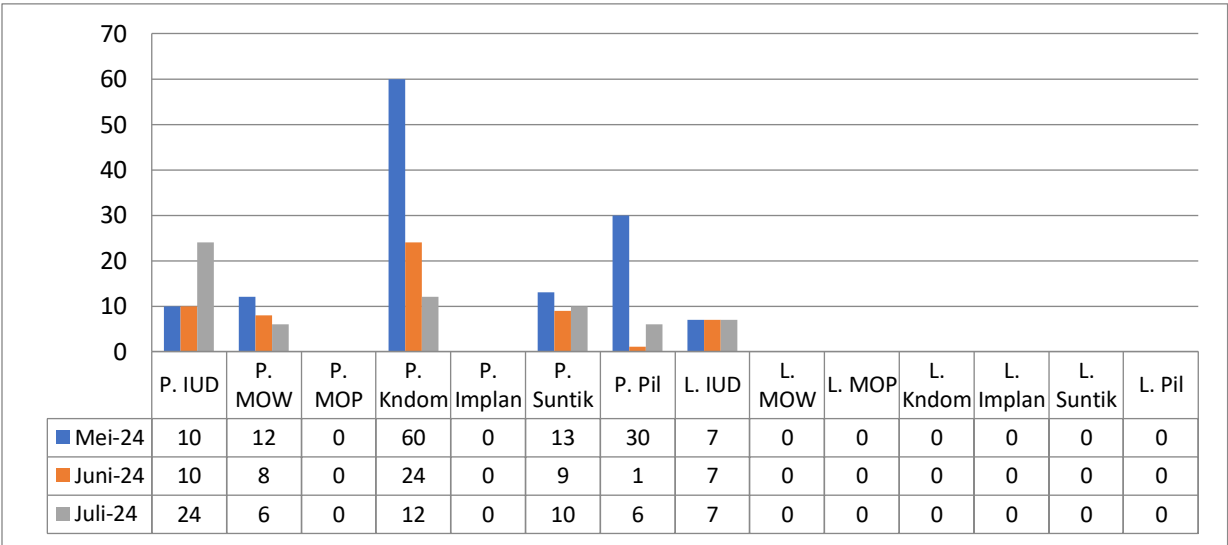
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Juli 2024

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	IUD	10	10	24	7	7	7
2	MOW	12	8	6	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	60	24	12	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	13	9	10	0	0	0
7	Pil	30	1	6	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Aanalisis :

1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Juli meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 24 akseptor yang terdiri dari 14 akseptor IUD Nova T dan 10 akseptor IUD copper T
2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu hanya 12 pengguna
4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Juli 2024 mengalami sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 6 pengguna
5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Juli 2024 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 penggunaan

Rencana dan Tindak Lanjut :

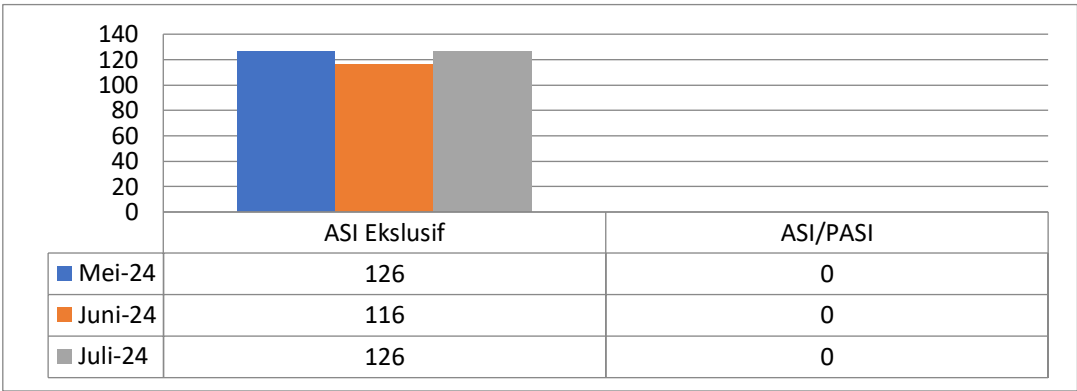
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponek Juli 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	Asi eksklusif	126	116	126
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Juli 2024



- Analisis :
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Juli mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 126 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

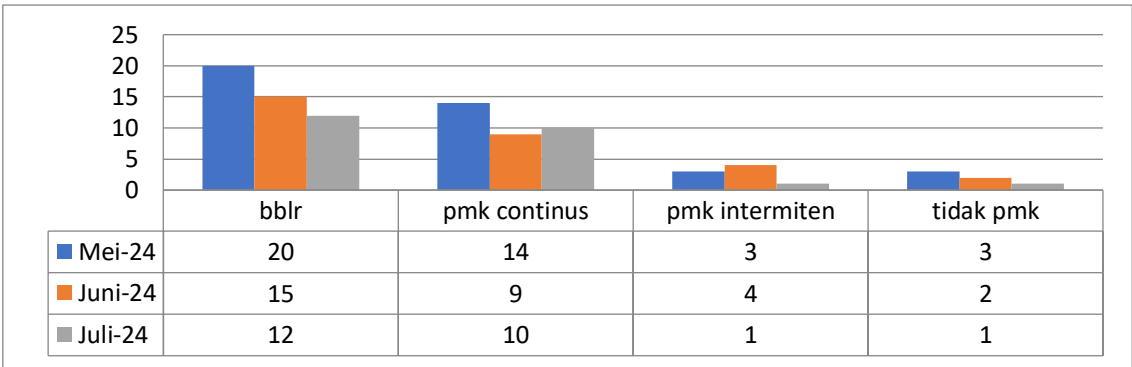
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek RSPHM Juli 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	Bayi BBLR	20	15	12
2	PMK continuos	14	9	10
3	PMK Intermiten	3	4	1
4	Tidak PMK	3	2	1

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Juli 202



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, menjadi 1 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Juli 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan terdapat 1 bayi yang masih tidak dilakukan PMK pada bulan Juli 2024, dan menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

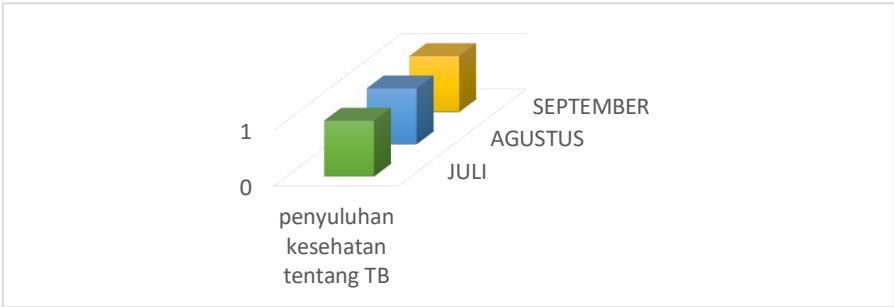
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1		

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

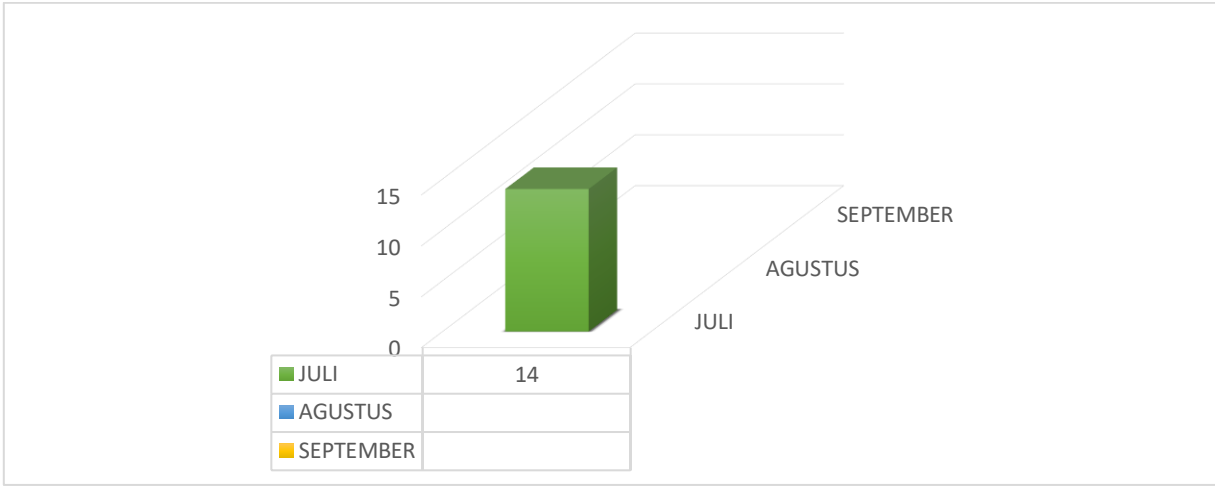
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian Masker	14		

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada



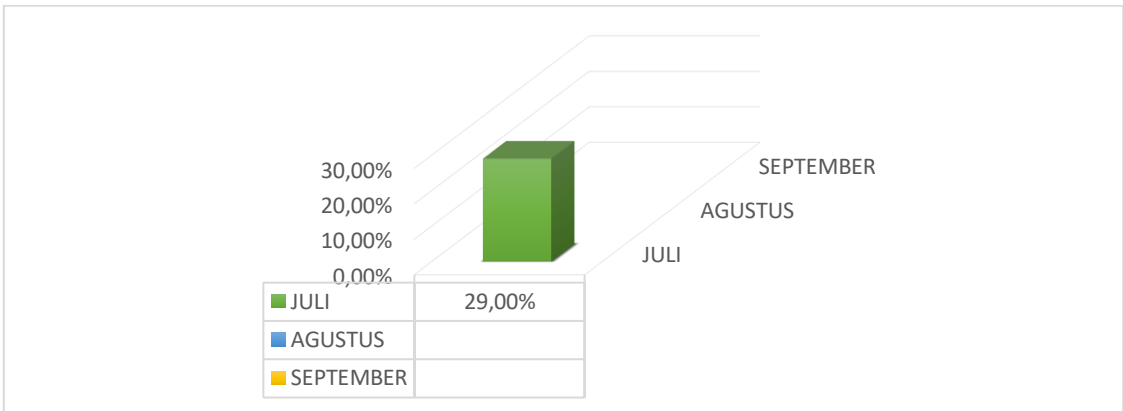
Analisis :
Pada bulan Jul 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut:**
- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
 - 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi
Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	29		

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Di RS Prima Husada



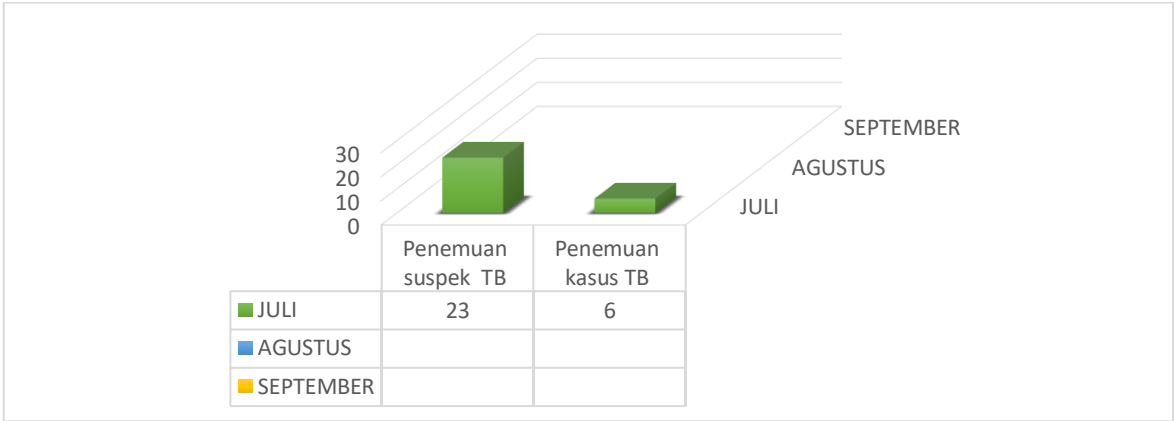
Analisis :
Pada bulan Juli 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 29

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penemuan suspek TB	23		
2	Penemuan kasus TB	6		

Grafik Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



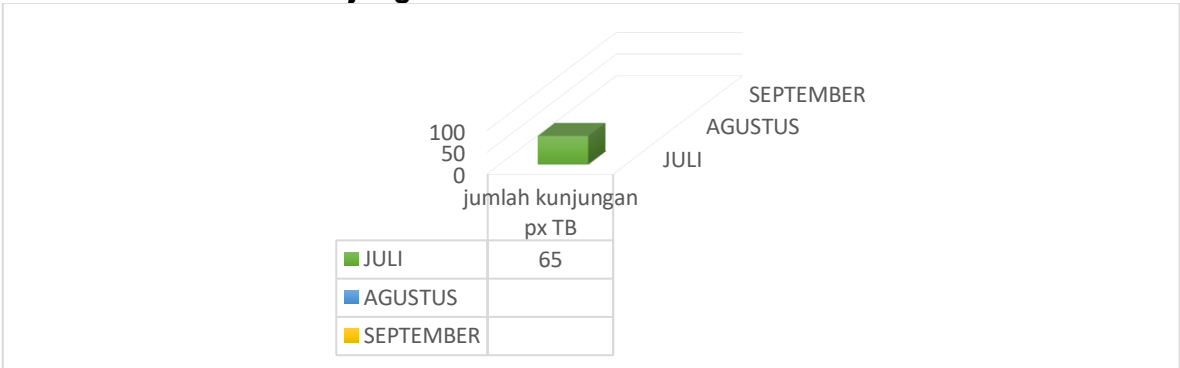
Analisis :
Pada bulan Juli 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	65		

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



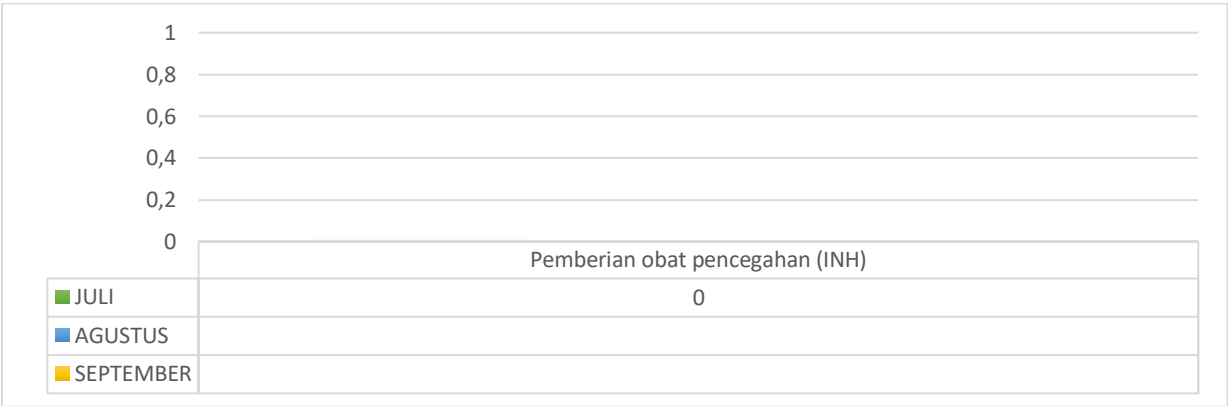
Analisis:
Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juli 2024 di poli pasien TBC mencapai 65 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0		

Grafik Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima



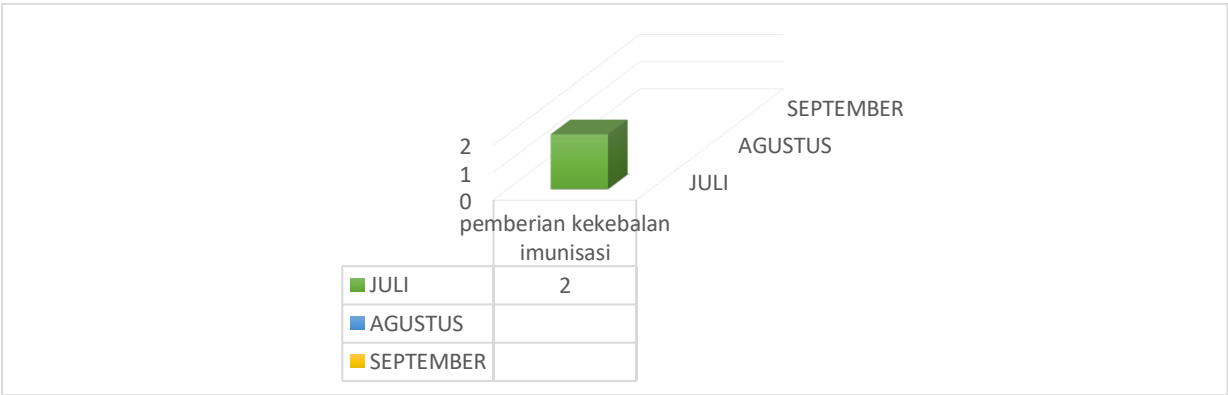
Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
 - 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	2		

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :
Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan JULI

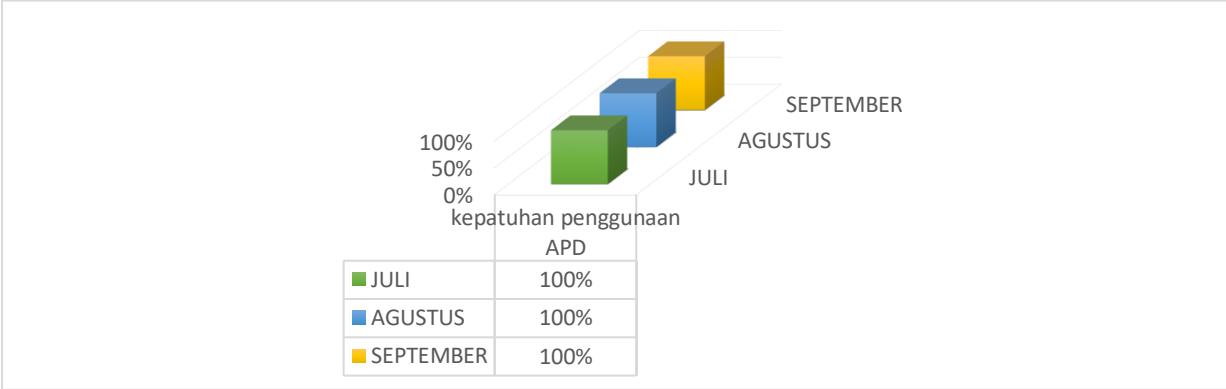
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%		

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



Analisis :

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

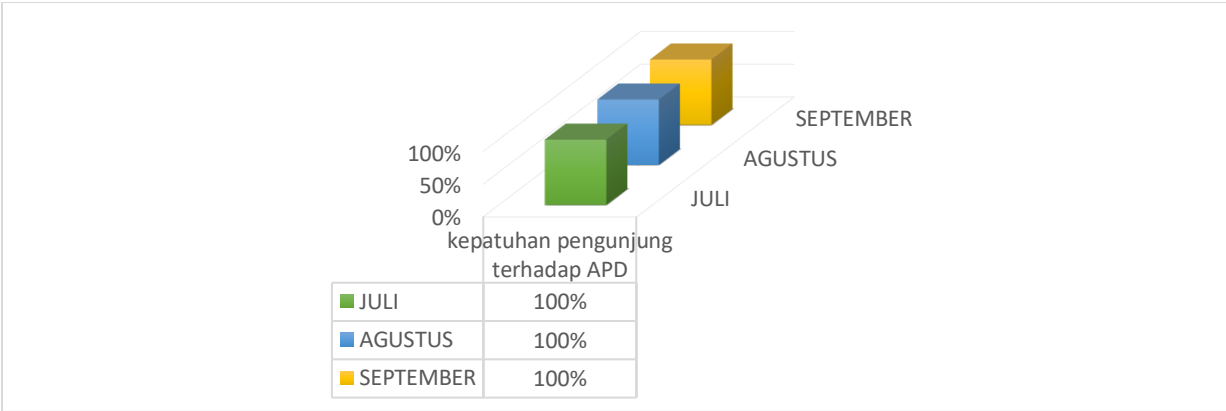
Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%		

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada



Analisis:

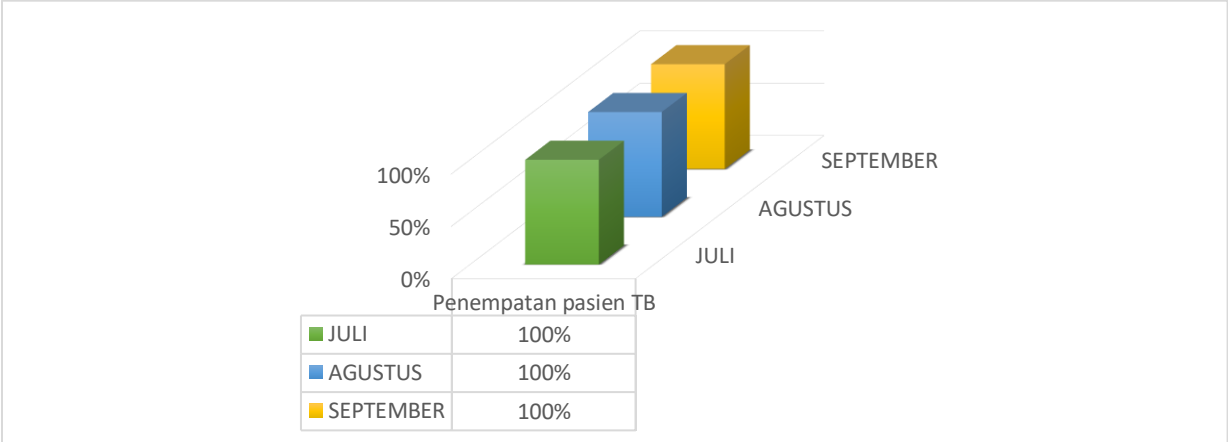
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penempatan pasien TB	100%		

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



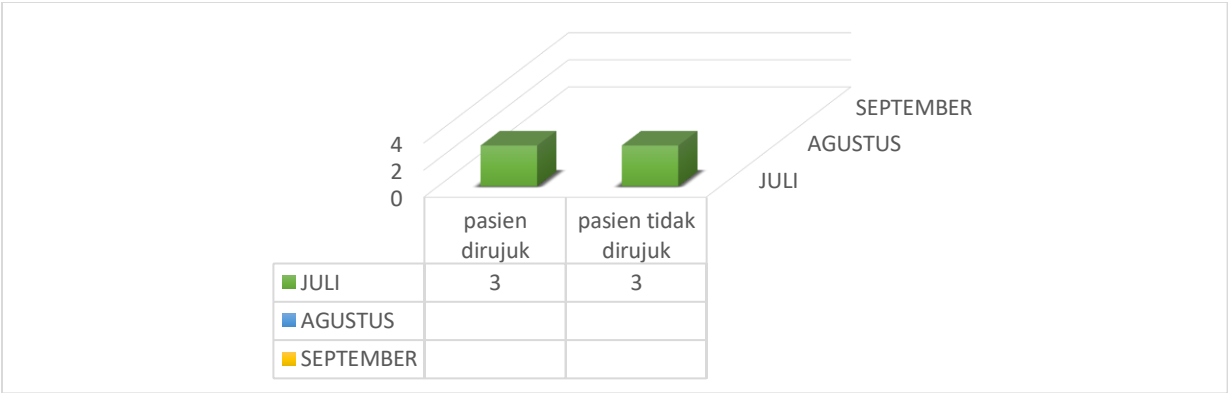
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB yang dirujuk	3		
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	3		

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



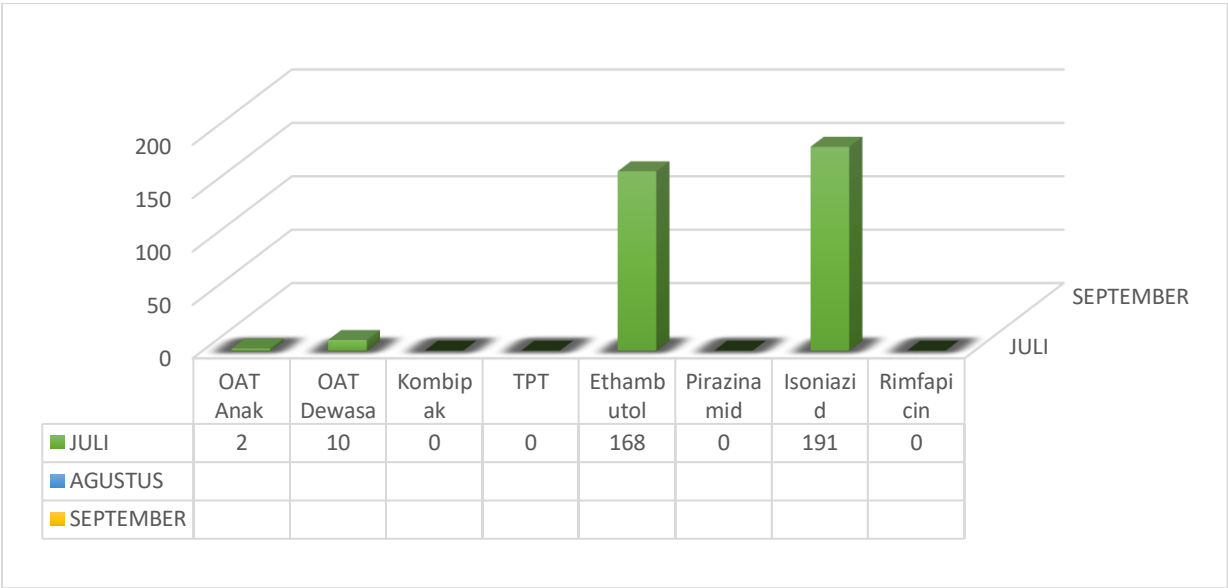
Analisis :
Pada bulan JULI 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	OAT Anak	2		
2.	OAT Dewasa	10		
3.	Kombipak	0		
4.	TPT	0		
5.	Ethambutol	168		
6.	Pirazinamid	0		
7.	Isoniazid	191		
8.	Rimfapicin	0		

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



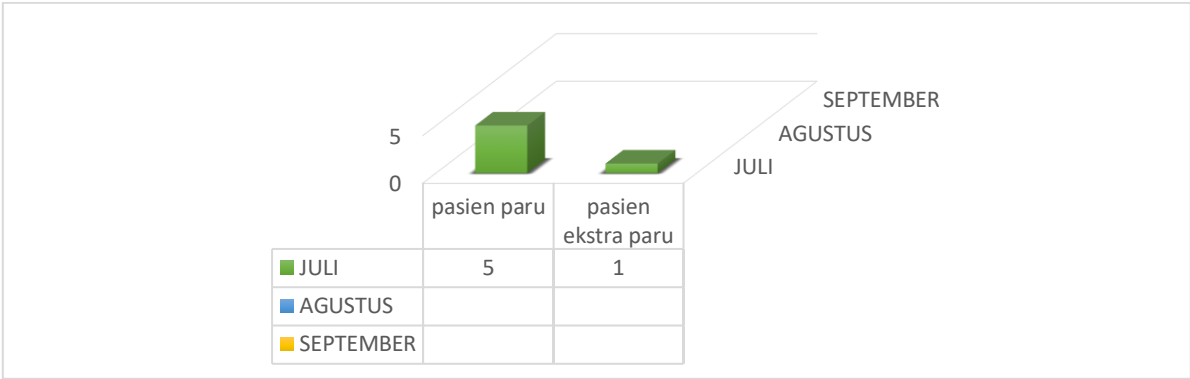
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien paru	5		
2.	Pasien Ekstra paru	1		

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



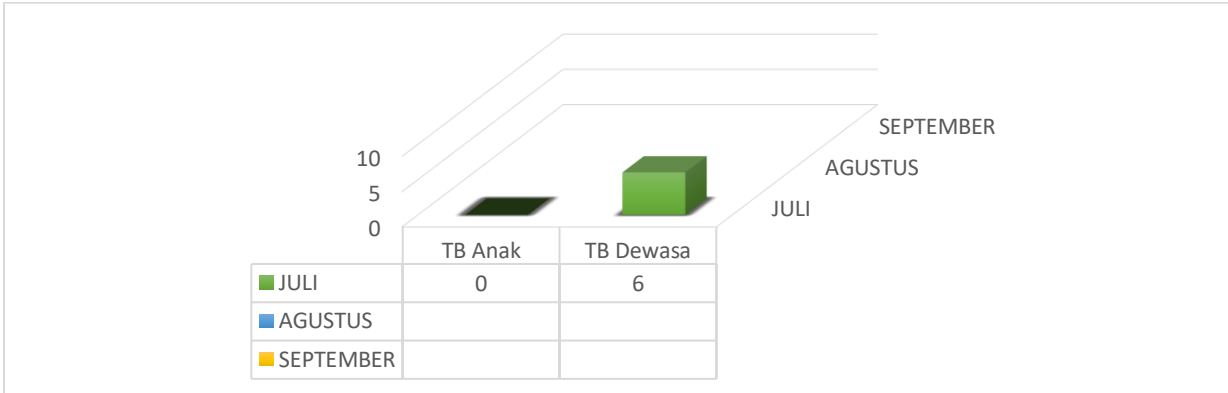
Evaluasi :
Pada bulan Juli 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien Anak	0		
2.	Pasien Dewasa	6		

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Pada bulan Juli terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		

2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P				
		Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P	Ny. S	V		

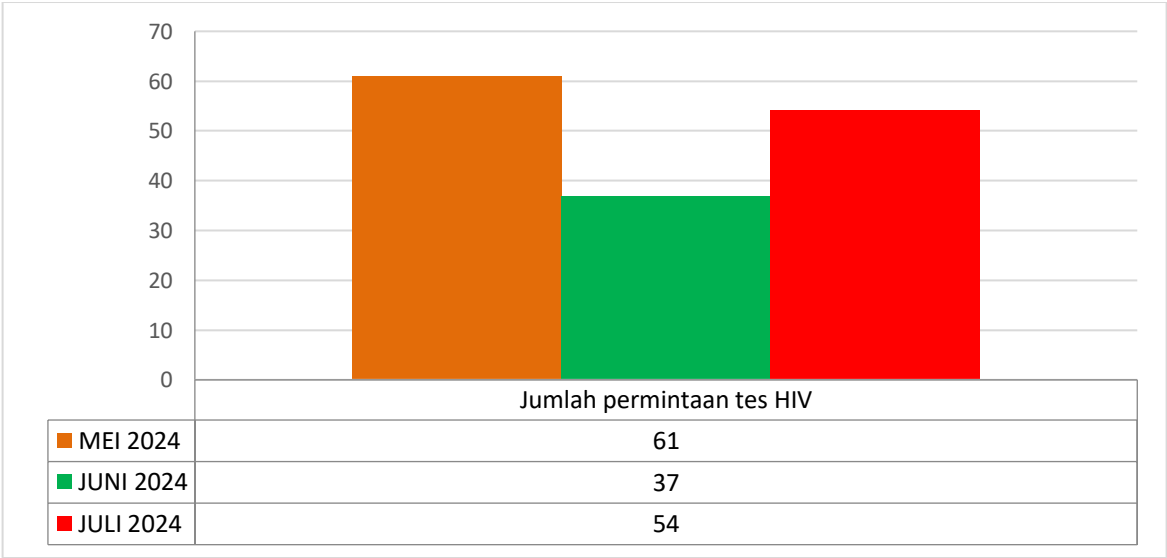
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Permintaan Test HIV	61	37	54

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Juli 2024 sebanyak 54 pemeriksaan. Pemeriksaan naik dibandingkan dengan bulan Juni 2024 sebanyak 37 pemeriksaan dan bulan Mei 2024 sebanyak 61 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

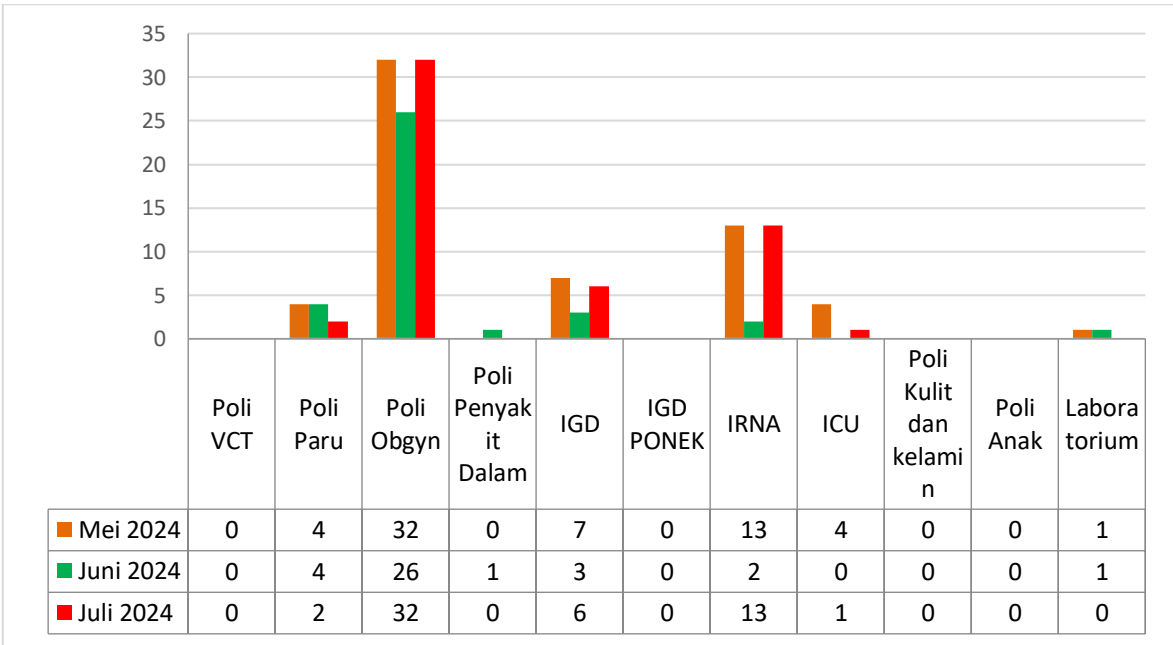
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	4	2
3	Poli Obgyn	32	26	32
4	Poli Penyakit Dalam	0	1	0
5	IGD	7	3	6
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	13	2	13
8	ICU	4	0	1
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	1	1	0

**Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan Mei 2024 sebanyak 32 pasien. Pada bulan Juni 2024 sebanyak 26 pasien. Sedangkan pada bulan juli sebanayak 54 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

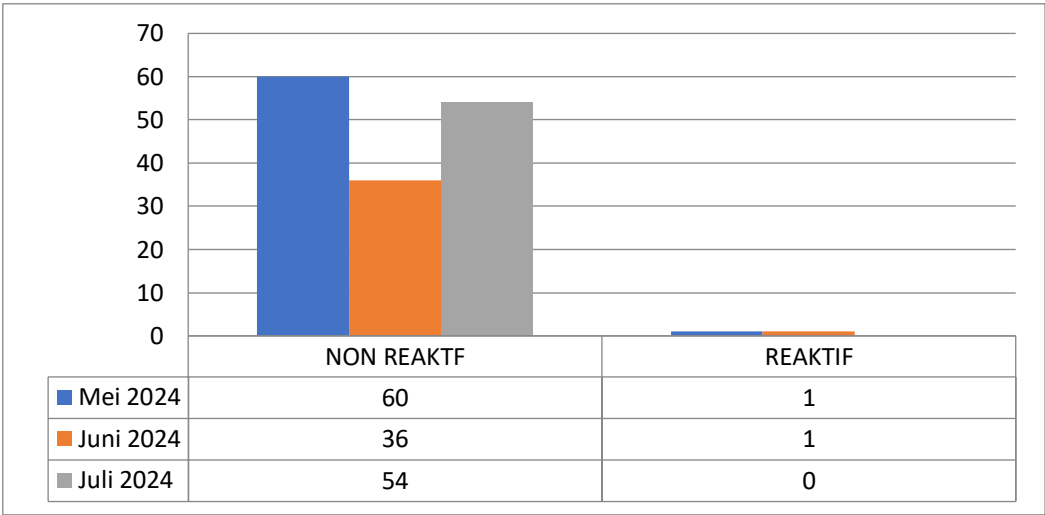
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Non Reaktif	60	36	54
2	Reaktif	1	1	0

**Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas tidak ditemukan data status HIV dengan status reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Juli 2024.

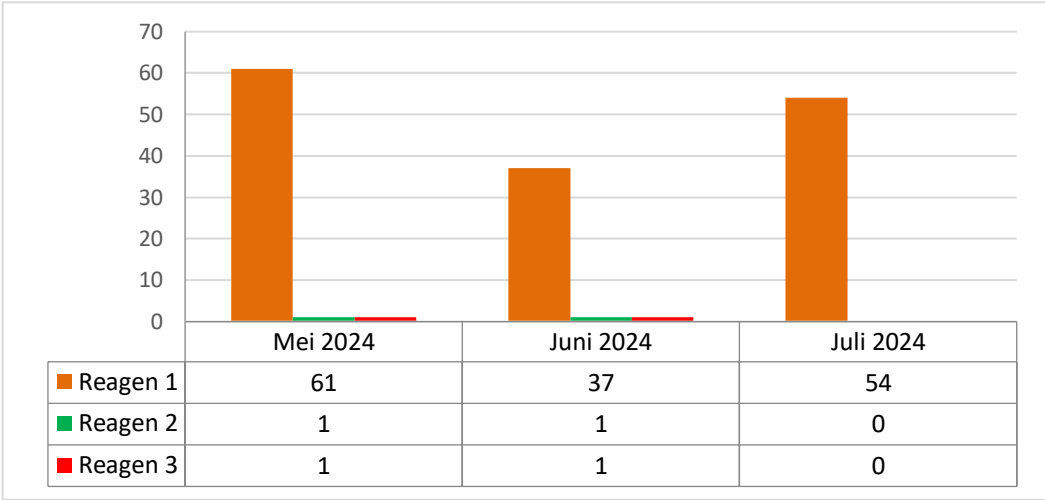
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Reagen 1	61	37	54
2	Reagen 2	1	1	0
3	Reagen 3	1	1	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2024



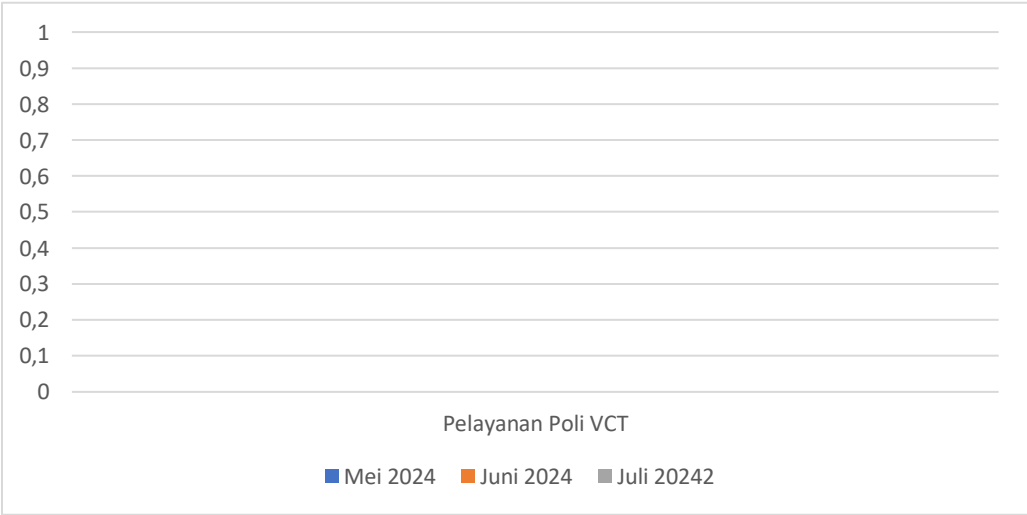
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada bulan Mei 2024 ditemukan memakai sampai dengan reagen 3. Pada bulan Juni memakai sampai dengan reagen 3. Sedangkan pada bulan Juli 2024 memakai reagen 1 saja. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei dan juni 2024 ditemukan pasien dengan hasil HIV Reaktif sebanyak 1 pasien. Sedangkan pada bulan Juli 2024 tidak ditemulan pasien dengan HIV Reaktif.

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2024	MEI 2024	JULI 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2024



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

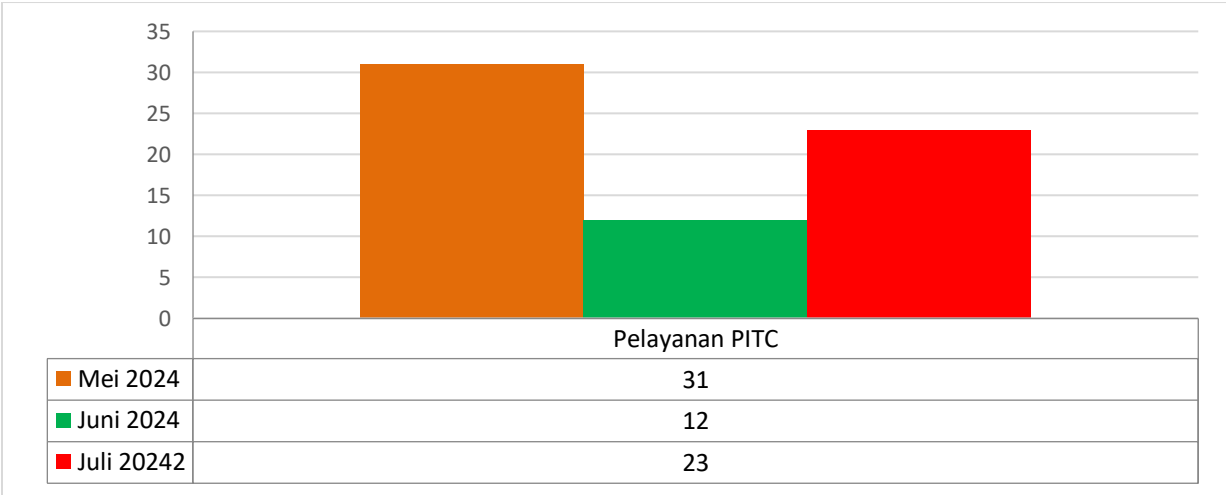
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Pelayanan PITC	31	12	23

**Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2024**



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan Mei 2024 sebanyak 31 pasien. Pada bulan Juni 2024 sebanyak 12 pasien. Sedangkan pada bulan juli 2024 sebanyak 23 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

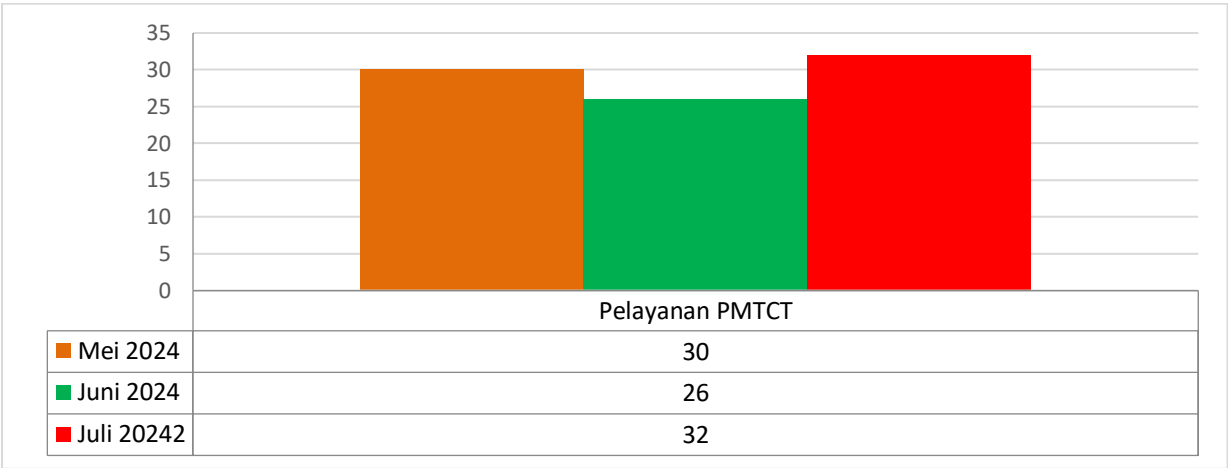
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Pelayanan PMTCT	30	26	32

Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2024



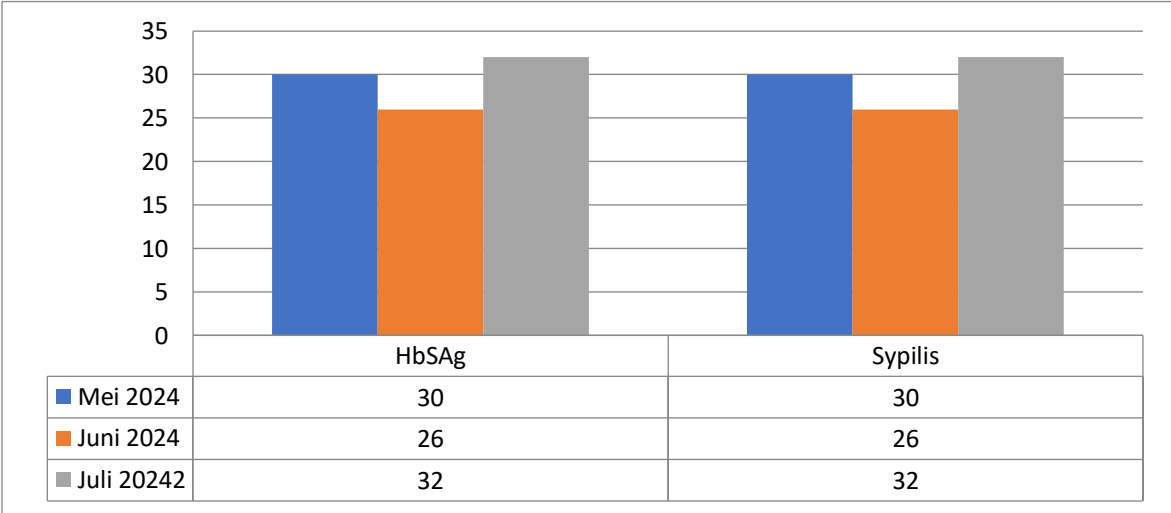
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan Mei 2024 sebanyak 30 pasien. Pada bulan juni 2024 sebanyak 26 pasien. Sedangkan pada bulan Juli 2024 sebanyak 32 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk *Prevention to Mother Of Child Transmision* bisa dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	HbSAg	26	26	32
2	Sypilis	26	26	32

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Syphilis pada bulan Mei 2024 sebanyak 30 pasien. Pada bulan juni 2024 sebanyak 26 pasien sedangkan pada bulan Juli 2024 sebanyak 32 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Syphilis bisa dilakukan.

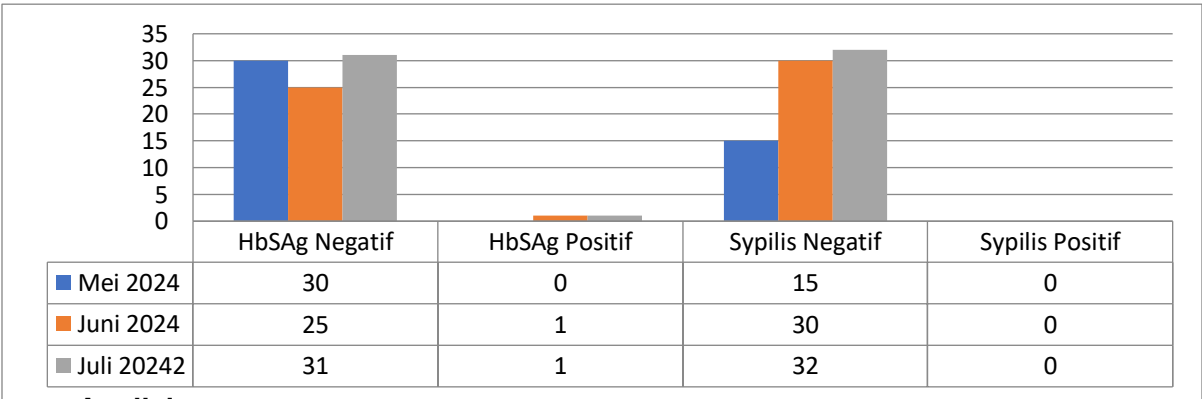
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	HbSAg			
	Negatif	30	25	31
	Positif	0	1	1
2	Sypilis			
	Negatif	15	30	32
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa Pada bulan Mei 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Syphilis dengan hasil positif. Pada bulan Juni 2024 didapatkan 1 pasien dengan HbSAg positif. Sedangkan pada bulan Juli 2024 ditemuka 1 pasien dengan HbSAg Positif.

Rencana Tindak Lanjut :

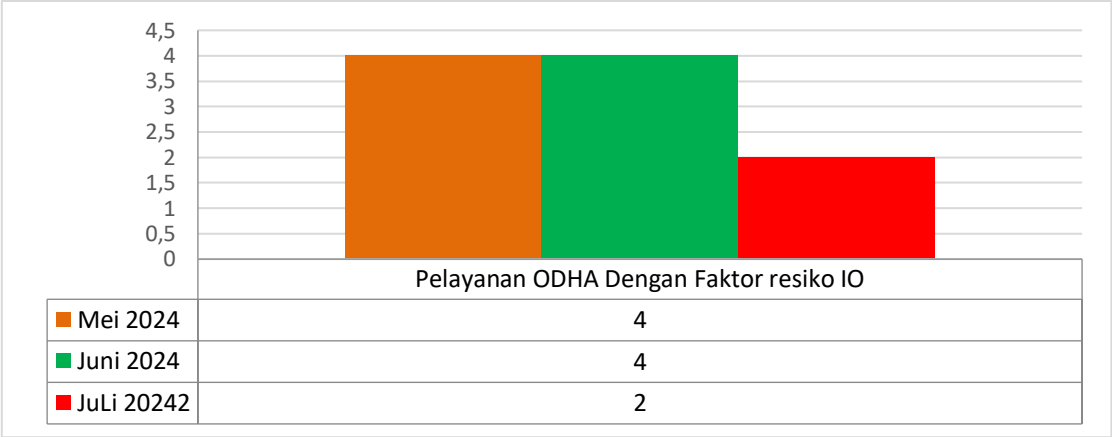
1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran akan ada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Syphilis

Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	4	2

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



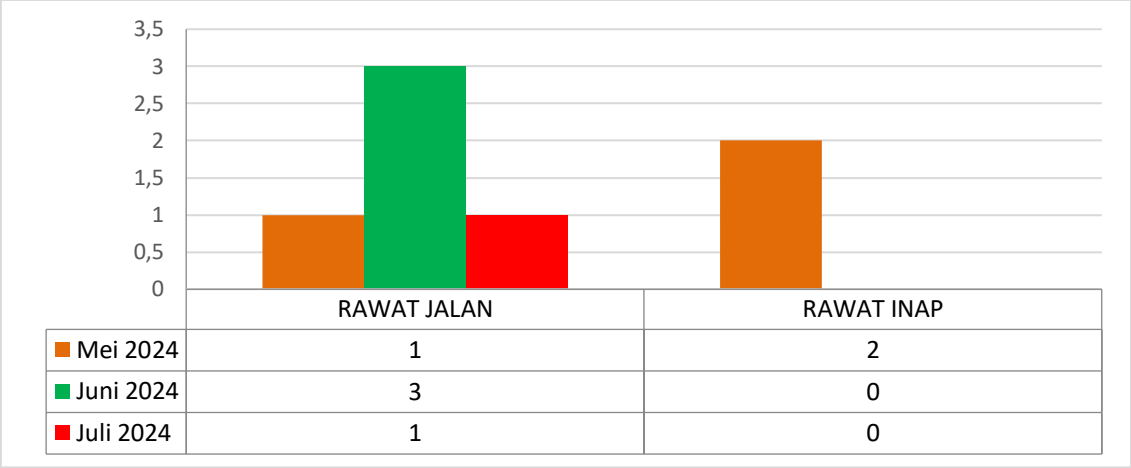
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Mei 2024 terjadi penurunan menjadi 4 pasien. Pada bulan juni 2024 sebanyak 4 pasien. sedangkan pada bulan juli di dapatkan 2 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :
Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di rRumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
1	Rawat Jalan	1	3	1
2	Rawat Inap	2	0	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan Mei 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk yaitu dari rawat jalan 1 pasien, dari rawat inap sebanyak 2 pasien. Pada bulan juni terdapat 3 pasien HIV yang dilakukan rujuk yang berasal dari rawat jalan. Sedangkan pada bulan juli didapatkan data pasien yang dilakukan rujuk yaitu 1 pasien dari poli rawat jalan (poli kandungan) dengan pasien membawa hasil pemeriksaan sendiri dari PKM domisili pasien. Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting
3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Juli 2024

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan

6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Pada Bulan Juni tidak terdapat Kerjasama dengan komunitas eksternal
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
- Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	APR 2024	MEI 2024	JULI 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	dan asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	2
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu	Pasien anak	Rawat Inap	0	0	2

	menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan					
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

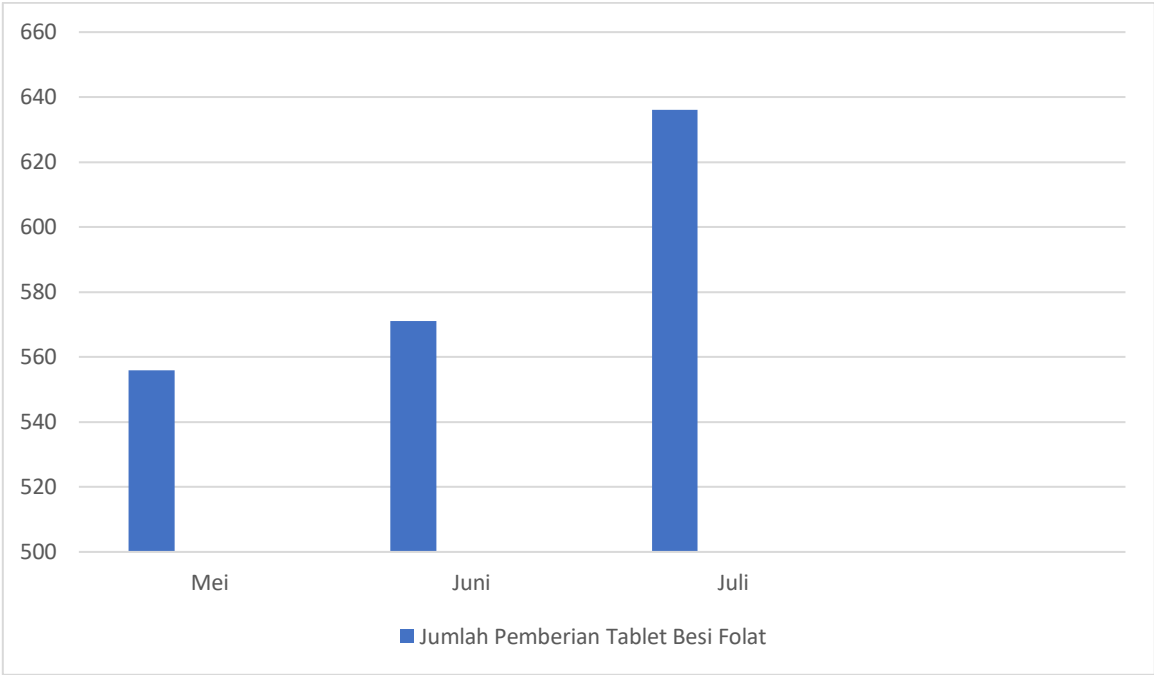
Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	556	571	636

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat meningkat pada bulan Juli yaitu 636 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

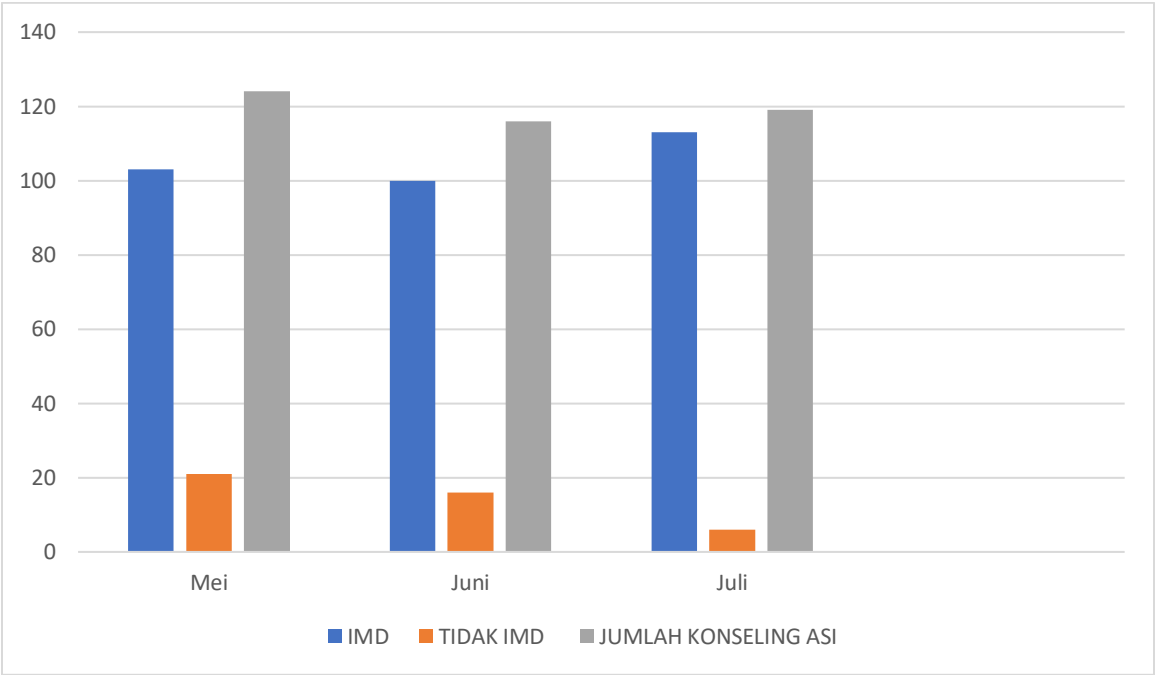
- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	IMD	103	100	113
2	Tidak IMD	21	16	6
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	124	116	119

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juli 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 113 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juli 2024 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Juli 2024 yaitu sebanyak 119 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

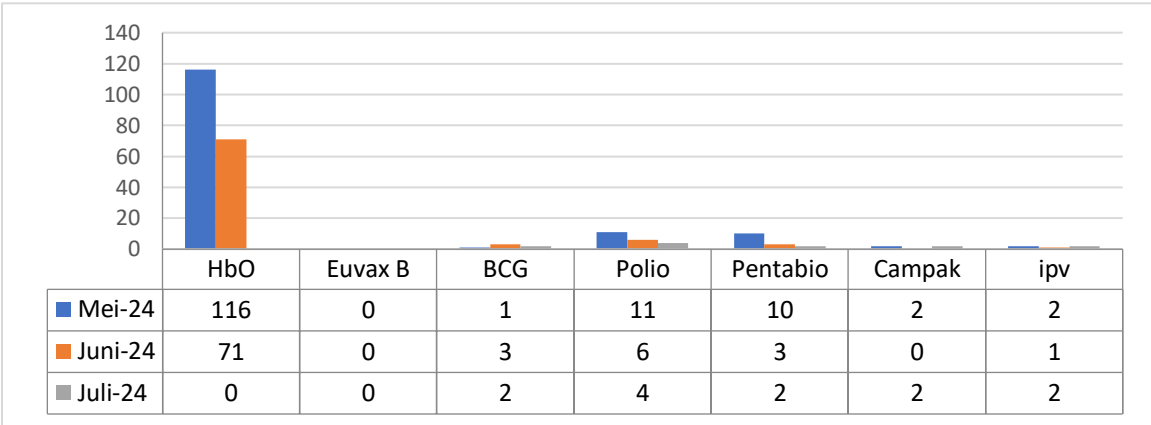
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	HbO	116	71	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	3	2
3	Polio	71	66	4
4	Pentabio	70	63	2
5	Campak	2	0	2
6	IPV	2	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis:

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Juli 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2. Tidak ada Imunisasi Hbo pada bulan Juli dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juli sedikit meningkat pada bulan Juli yaitu 2 bayi.
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien.
- 5. Pada periode Juli 2024 terdapat bayi yang melakukan Imunisasi Campak yaitu 2 bayi.
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien

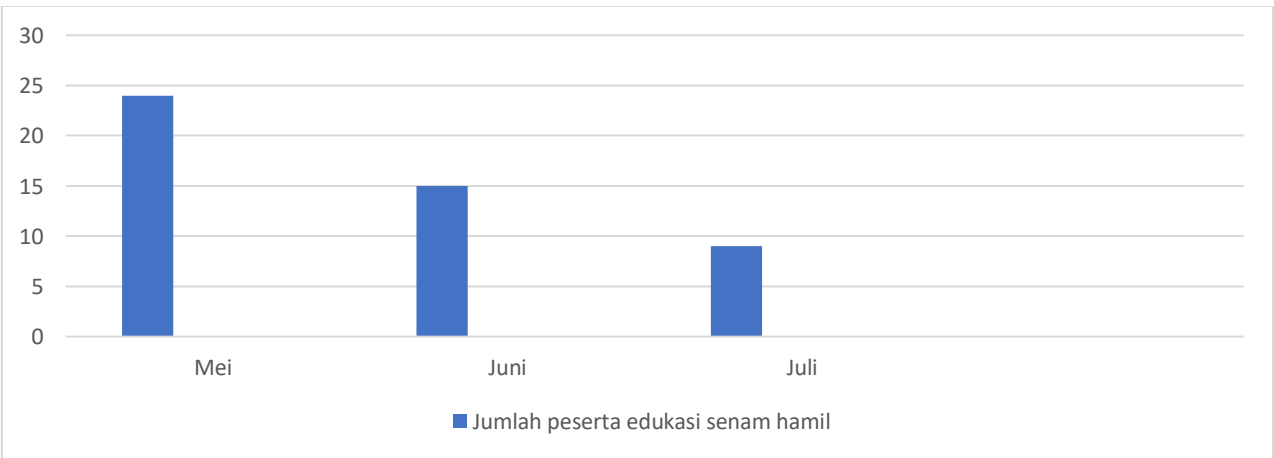
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	24	15	9
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2024



Analisis :

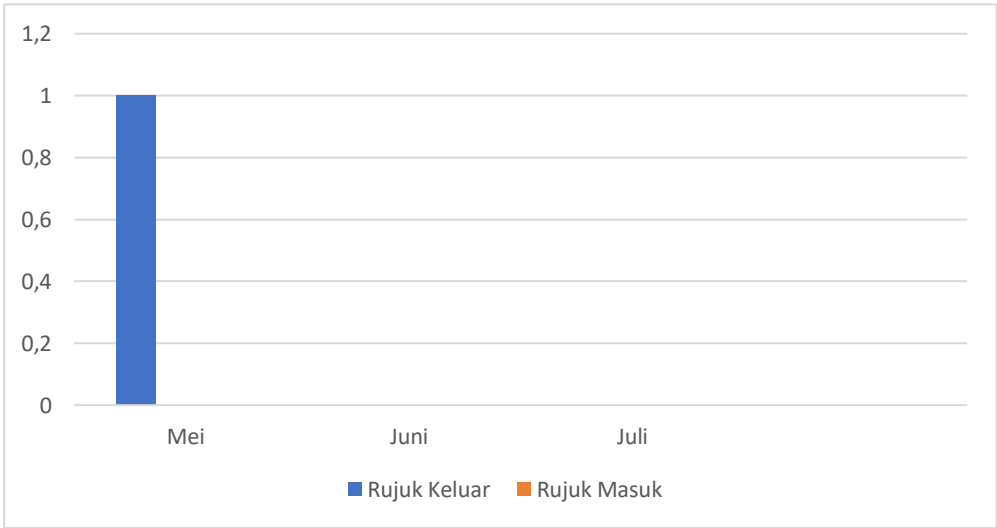
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Peserta Senam Hamil pada bulan Mei mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 24 peserta dikarenakan terdapat penambahan jumlah matras sebagai media senam hamil sehingga lebih banyak ibu hamil yang mendaftar untuk mengikuti senam hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

RUJUKAN MASUK				
BULAN	NAMA PX	USIA	DIAGNOSA	ASAL RUJUKAN
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
BULAN	NAMA PX	USIA	DIAGNOSA	ASAL RUJUKAN
Mei	Zahirul Ihsan	7 Bulan	Pneumonia, Gizi Buruk, Down Syndrome, PJB	RSUD Sidoarjo
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-



Analisis :

Terdapat 1 pasien pada bulan Mei dirujuk ke RSUD Sidoarjo dengan diagnosa Pneumonia, Gizi Buruk, Down syndrome, dan PJB Chronic.

Rencana Tindak Lanjut:

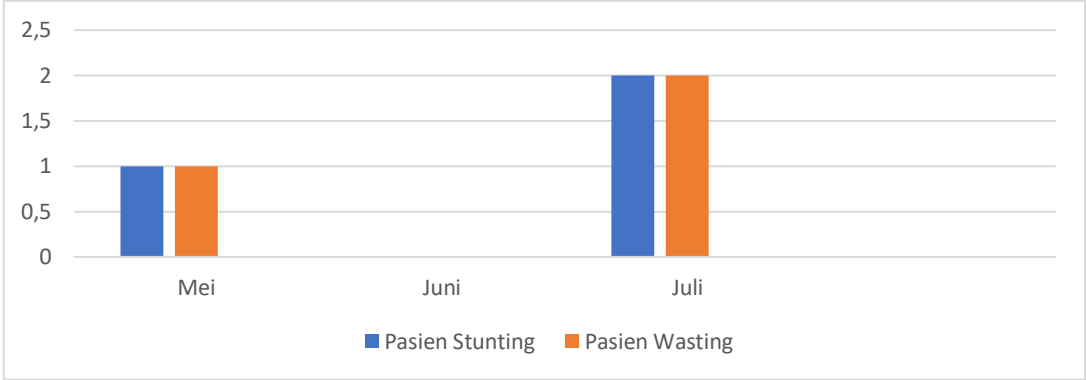
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8
Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	MEI 2024	JUNI 2024	JULI 2024
Jumlah Pasien Stunting	1	0	2
Jumlah Pasien Wasting	1	0	2

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Terdapat 2 pasien stunting dan wasting pada bulan Juli. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :

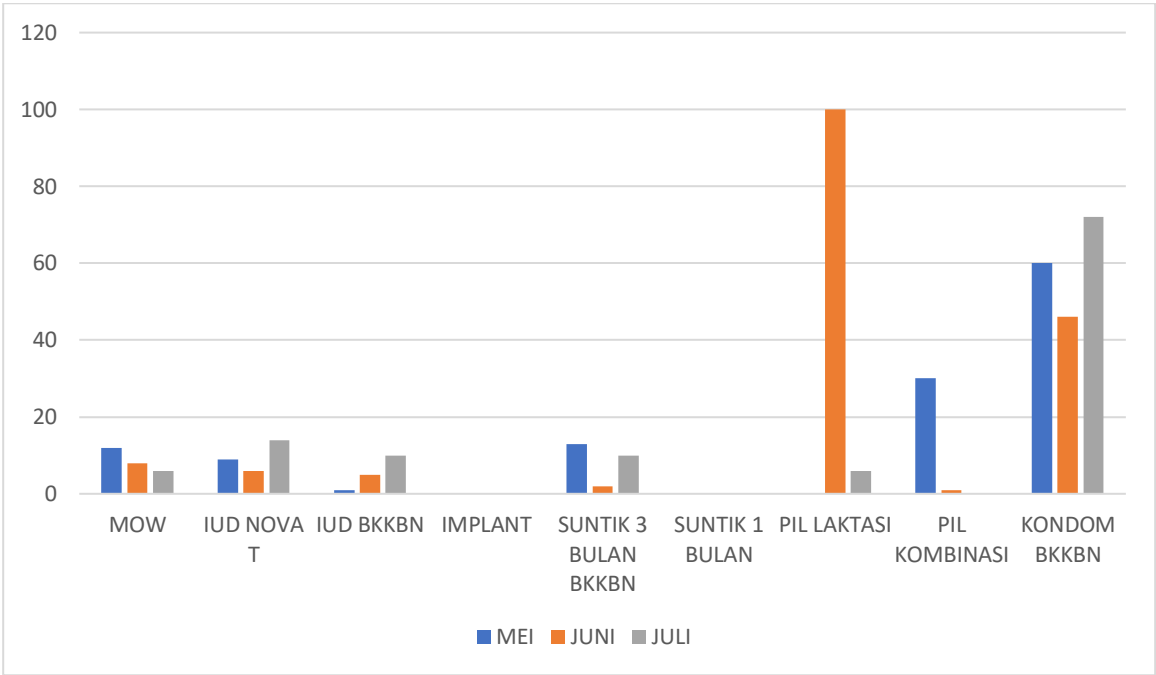
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

3.1.2.5
KBRs

3.1.2.6
Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	MOW	12	8	6
2	IUD Nova T	9	6	14
3	IUD BKKBN	1	5	10
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	13	2	10
6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL KOMBINASI	30	1	0
8	PIL LAKTASI	0	0	6
9	KONDOM BKKBN	60	46	72

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Mei (12) turun Juni (8) Juli (6)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Mei meningkat(9) menurun Juni (6) Juli (14)
- 3. Peserta IUD BKKBN, pada bulan Mei menurun (1) meningkat Juni (5) Juli (10)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Mei meningkat(13) menurun Juni (2) Juli (10)
- 5. Peserta KB pil kombinasi pada Mei meningkat (30) menurun Juni (1) karena stok kosong Gudang bkkbn Juli (0)pil KB laktasi Juli (6)
- 6. Peserta KB Kondom pada bulan Mei meningkat (60) menurun Juni (46) meningkat Juli (72)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

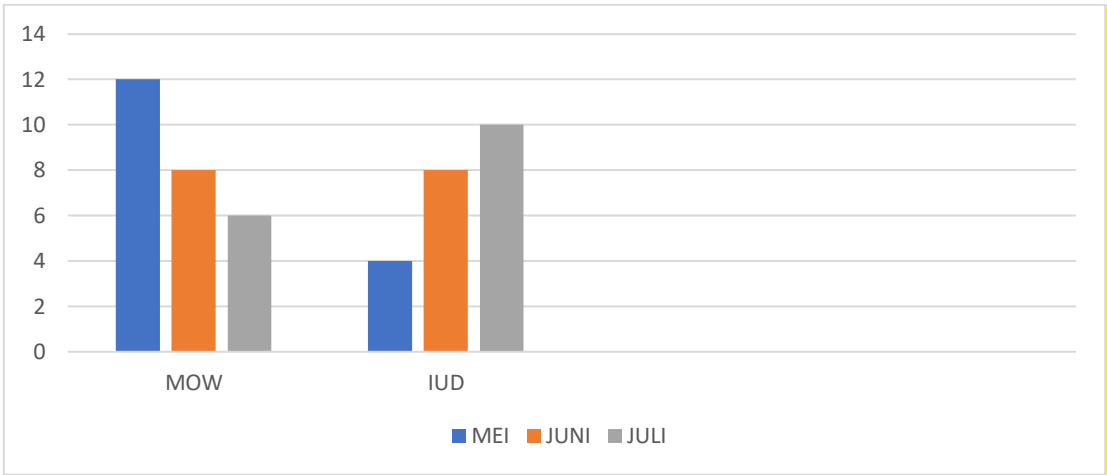
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

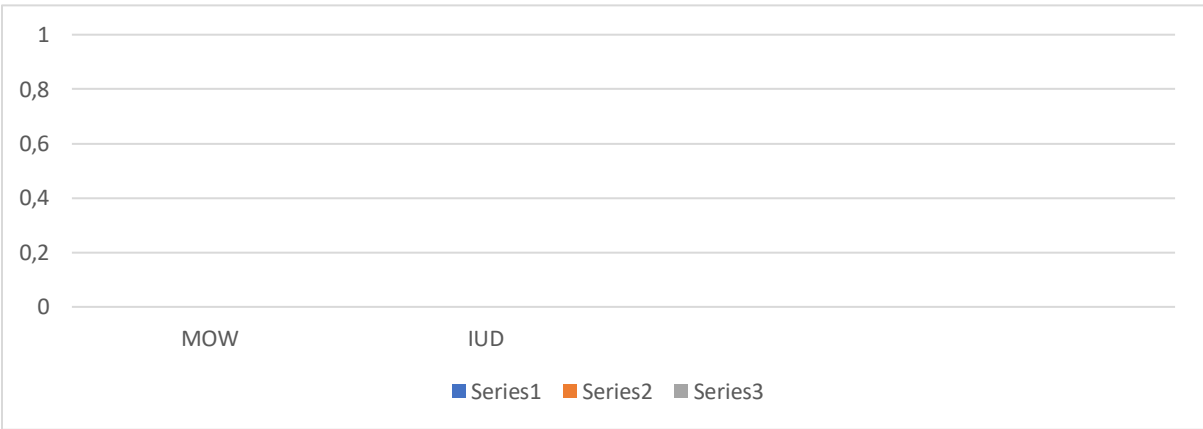
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	MOW	12	8	6
2	IUD	4	8	10

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Mei-Juni-Juli meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Mei-Juni-Juli menetap

Analisis

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan II Tahun 2024

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	RUSWANDI	L/59	DR. FARID, SP.S	212319	CVA INFARK	29/04/2024	06/05/2024	8	Ceftiaxone	2	2X1	7	2	3,5
									Levofloxacin Po		1X0,5	1,5	0,5	3
2	SULAKSONO	L/48	DR. EDI, SP. U	212963	NEFROLITIASIS BILATERAL	02/05/2024	06/05/2024	5	Ceftizoxime	1	1X2	2	4	0,5
3	LASIAMAH	P/74	DR. IRA, SP.JP	097978	ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER	03/05/2024	07/05/2024	5	Ceftiaxone	2	2X1	4	2	2
									Azitromycin		1X0,5	1	0,3	3,3
4	CHOTAMIN	L/56	DR. YUNITA, SP.P	207671	COPD	04/05/2024	07/05/2024	4	Levofloxacin Inf	1	1X0,75	3	0,5	6
5	SUPAAT	L/68	DR. YUNITA, SP.P	213556	PNEUMONI SUSP TB	08/05/2024	11/05/2024	4	Ceftriaxone	3	2X1	8	2	4
									Azitromycin Po		1X0,5	1,5	0,3	5
									Levofloxacin Inf		1X0,5	1	0,5	2
6	SUKRI	L/93	DR. MIRYANTI, SP. JP	213625	DYSPNEA	09/05/2024	14/05/2024	6	Levofloxacin Inf	2	1X0,5	1,5	0,5	2
									Levofloxacin Po		1X0.5	1,5	0,5	2
7	MUNYATUN	P/54	DR. ANDY, SP.P	140274	PNEUMONI, HT	12/05/2024	15/05/2024	4	Ceftriaxone	1	2X1	8	2	4
8	ESTER NINGMAWATI	P/58	DR. ANTON , SP.B	194608	NECROTIZING FACITIS DEXTRA, DM HIPERGLIMKEMI	13/05/2024	15/05/2024	3	Ceftriaxone	3	1X1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2X1	5	2	2.5
									Metronidazole Po		3X0,25	2	2	1
9	RUSLANI	L/67	TUMOR SHOULDER	064773	TUMOR SHOULDER (S)	15/05/2024	17/05/2024	3	Cefoperazone	2	1X2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2X1	5	2	2,5
10		L/47		213876		15/05/2024	17/05/2024	3	Ceftriaxone	2	3X1	8	2	4

	RACHMAD RIYADI		DR. ANTON, SP.B		GANGRENE AND NECROSIS OF LUNG				Metronidazole Po		3X0,25	1,75	2	0,875
11	ACHMAD SOBIM	L/49	DR. OKA, SP.OT	213924	CRUSH INJURY	16/05/2024	17/05/2024	2	Cefoperazone	1	2X1	4	4	1
12	ERNI KUSUMAWATI	P/50	DR. ANTON, SP.B	146928	GANGLION	19/01/2024	23/01/2024	5	Ceftizoxime	2	1X1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		1X1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2X0,5	1,5	2	0,75
13	DIAN PUTRI AMALIA	P/27	DR. ZORA, SP. PD	177321	VOLUME DEPLETION	16/05/2024	18/05/2024	3	Doxycyline	1	2X0,1	0,6	0,1	6
14	MISERI	L/60	DR. ANTON, SP.B	214064	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF TRUNK	19/05/2024	22/05/2024	4	Ceftriaxone	2	1X1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2X1	6	2	3
15	KARTIKA	P/29	DR. ARDHI, SP.PD	214161	GEA	20/05/2024	23/05/2024	4	Ceftriaxone	2	2X1	8	2	4
									Ciprofloxacin		2X0,5	2	1	2
16	WIDARSONO	L/48	DR. HERI , SP.PD	214179	ACUTE NASOPHARYNGITIS	20/05/2024	23/05/2024	3	Ceftriaxone	3	2X1	4	2	0.5
									Cefadroxile		3X0,5	2,5	2	1.25
									Levofloxacin Po		1X0,75	1,5	0,5	3
17	MUJIONO	L/68	DR. MIRYANTI, SP.JP	190448	JAUNDICE	20/05/2024	23/05/2024	4	Ceftriaxone	2	2X1	6	2	3
									Asam Pipemidat		2X0,4	1,6	0,8	2
18	KASIYANTO	L/64	DR. PRADANA, SP.U	113927	BPH	21/05/2024	23/05/2024	3	Ceftizoxime	1	1X2	2	4	0,5
20	SENJA AYU	P/26	DR. HUMAIRA, SP.OG	182583	PRM	22/05/2024	24/05/2024	3	Cefazoline	2	1X2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2X0,5	2	2	1
19	ALIFAH	P/40	DR.HERI, SP.PD	200272	DM TYPE 2	22/05/2024	27/05/2024	6	Ceftriaxone	2	2X1	7	2	3.5
									Cefixime		2X0,1	0,5	0,4	1,25

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	M Furqon B	L/36	dr. Nimim, Sp.THT	214625	Abses Mandibula	29/05/2024	01/06/2024	4	Clindamycin po	3	3x0,3	2,7	1,8	1,5
									Ceftriaxone		2x1	8	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	2	2,25
2	Jumiati	P/54	dr. Ardhi, Sp.PD	164052	Volume Depletion	29/05/2024	01/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
3	Abdi Suroyo	L/43	dr. Ardhi, Sp.PD	203535	Febris / Fever	02/06/2024	05/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
4	Ni'ah	P/74	dr. Yoga, Sp.JP	214835	Chest Pain	02/06/2024	06/06/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin po		3x0,5	3	0,5	6
5	Hasanuddin	L/55	dr. Ardhi, Sp.PD	214904	Volume Depletion	03/06/2024	06/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
6	Rubakyah	P/42	dr. Heri, Sp.PD	078562	Vomiting	05/06/2024	10/06/2024	6	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	3,2	0,8	4
7	Rochmayati	P/47	dr. Sigit, Sp.BP	215130	Post Repair Soft Tissue	07/06/2024	12/06/2024	6	Ceftiaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	10	2	5
8	Dyah Ramadhanty	P/23	dr. Zaki, Sp.B	215147	Colic Abdomen	08/06/2024	11/06/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
9	Sumartono	L/38	dr. Andy, Sp. P	215239	Athsma	09/06/2024	12/06/2024	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
10	Liman Harsono	L/70	dr. Edi, Sp. U	214658	Calculus of Ureter	10/06/2024	12/06/2024	3	Cefizoxime	1	1x2	2	4	0,5
11	Ni'matus S	P/27	dr. Aida, Sp.OG	104116	SC	13/06/2024	16/06/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
12	Rubinem	P/62	dr. Zaki, Sp.B	203990	Tumor Paru	14/06/2024	16/06/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x1	1	4	0,25

									Ceftiaxone		2x1	4	2	2
13	Endang Wahyuni	P/29	dr. Andy, Sp.P	215638	Febris / Fever	18/06/2024	20/06/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Azitromycin po		2x0,5	2	0,3	6,67
14	Suwandi	L/53	dr. Farid, Sp.N	210236	Dyspnea	20/06/2024	24/06/2024	5	Meropenem	2	3x1	15	3	5
									Levofloxacin inf		1x0,75	3,75	0,5	7,5
15	Ida Marlinawati	P/49	dr. Heri, Sp. B	100853	Shock hipovolemik, anemia	20/06/2024	24/06/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
16	Sujiono	L/59	dr. Zaki, Sp.B	116131	Colic abdomen	23/06/2024	27/06/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	5	1,5	3,3
17	Rochmatul J	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	215870	SC	24/06/2024	26/06/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
18	Firmansyah	L/39	dr. Meyrna, Sp.THT	215875	Sinuses	24/06/2024	28/06/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Metronidazole inf		3x0,5	6	1,5	4
19	Ferlyna Vivi	P/31	dr. Humaira, Sp. OG	151815	Kista	26/06/2024	28/06/2024	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilline tab		2x0,5	3	1,5	2
20	Paino	L/66	dr. Anton, Sp.B	215965	Necrotizing fasciitis pedis	26/06/2024	28/06/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	4,5	2	3,5

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juli 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Ngatemin	L/76	dr. Heri, Sp.PD	080191	Syok Hipokalemi	25/06/2024	03/07/2024	9	Ceftiaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefixime		2x0,1	1,4	0,4	3,5
2	Dian Nuriana	P/37	dr. Anton, Sp.B	216048	Acute Appendicitis	27/06/2024	01/07/2024	5	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Ceftriaxone		3x1	9	2	4,5
									Metronidazole po		3x0,25	2,25	2	1,125
3	Asmat	L/46	dr. Andy, Sp.P	216224	Dyspnea	30/06/2024	04/07/2024	5	Ceftriaxone	3	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		2x0,5	1	0,3	3,33
									Levofloxacin inf		1x0,5	1	0,5	2
4	Rihat Rico	L/29	dr. Zaki, Sp.B	216335	Ulcus Diabeticum	02/07/2024	05/07/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftiaxone		2x1	7	2	3,5
5	Roberto Bagio	L/21	dr. Yunita, Sp. P	169390	Obs Dyspneu dd Athsma dd COPD	03/07/2024	05/07/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	2	0,75
6	Agus Wahyudi	L/36	dr. Ardhi, Sp.PD	083488	Gastroneocitis	08/07/2024	12/07/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Ciprofloxacin po		2x0,5	5	1	5
7	Ernawati	P/44	dr. Vika, Sp.K	192126	Anogenital	09/07/2024	11/07/2024	3	Dohixat	1	2x0,1	0,6	0,1	6
8	Iwan Darsoni	L/39	dr. Yunita, Sp. P	208370	Dyspnea	09/07/2024	13/07/2024	5	Levofloxacin inf	1	1x0,75	3,75	0,5	7,5
9	Meirul Wahyu	L/21	dr. Kuntadi, Sp.OT	216664	Fingertrip Injury	10/07/2024	12/07/2024	3	Ceftiaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Kasiadi	L/48	dr. Yoga, Sp.JP	216773	DM Type 2	12/07/2024	18/07/2024	7	Ceftiaxone	2	2x1	14	2	7
									Levofloxacin po		1x0,5	1,5	0,5	3
11	Ngatemi	P/63	dr. Ardhi, Sp.PD	198384	DM Type 2	15/07/2024	18/07/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
12	Suwarni	P/64	dr. Heri, Sp.PD	216944	DM Type 2	15/07/2024	20/07/2024	6	Ceftriaxone	3	2x1	9	2	4,5

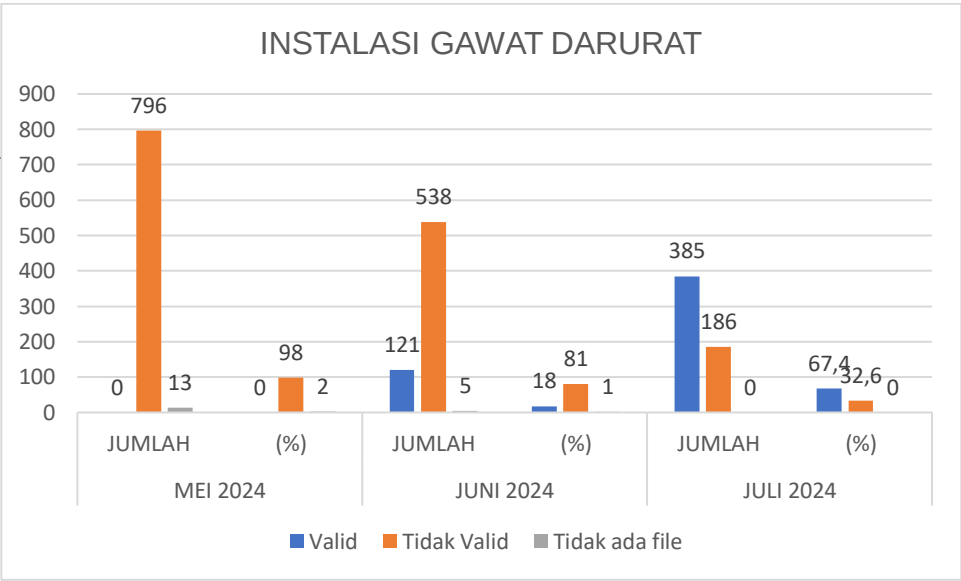
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
									Asam pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2
13	Ngatemin	L/77	dr. Heri, Sp.PD	080191	Abdomal Pain	16/07/2024	18/07/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Sulfasalazine		2x0,5	2,5	2	1,25
14	Ren Wijayanti	P/46	dr. Anton, Sp.B	216962	Necrotizing Faciitis	16/07/2024	18/07/2024	4	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
15	Ibrahim Muhammad	L/63	dr. Heri, Sp.PD	184234	DF	18/07/2024	21/07/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	3	2	1,5
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
16	Suyono	L/59	dr. Ardhi, Sp.PD	130971	Colic Abdomen	22/07/2024	25/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	6	2	3
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
17	Suli'ati	P/43	dr. Humaira, Sp.OG	130746	Cervix uteri	24/07/2024	25/07/2024	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin po		3x0,5	1,5	1,5	1
18	Munirotul K	P/43	dr. Andi, Sp. B	217219	TU Mamae (S)	24/07/2024	26/07/2024	3	Cefoperazone sodium	1	1x2	2	4	0,5
19	Ngatminah	P/45	dr. Anton, Sp.B	217296	Soft Tissue of Thorax	24/07/2024	26/07/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
20	Rizki Wulandari S	P/28	dr. Aida, Sp.OG	171126	SC	24/07/2024	26/07/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

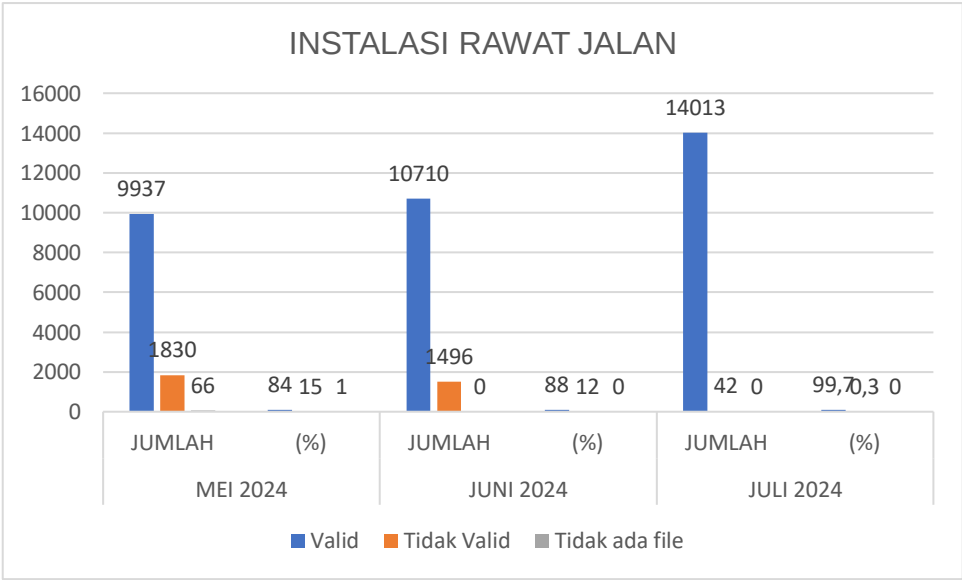
3.6.6.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Mei - Juli 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			MEI 2024		JUNI 2024		JULI 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	0	0	121	18	385	67,4
		Tidak Valid	796	98	538	81	186	32,6
		Tidak ada file	13	2	5	1	0	0
Total			809		664		571	
2.	IRJA/POLI	Valid	9937	84	10710	88	14013	99,7
		Tidak Valid	1830	15	1496	12	42	0,3
		Tidak ada file	66	1	0	0	0	0
Total			11833		12206		14055	

3.6.6.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Mei - Juli 2024



3.6.6.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Mei - Juli 2024



Analisis :

- 1. Terjadi kenaikan signifikan pada data valid di IGD sebanyak 385 Data E-RM dari 571 Data E-RM atau sebesar 67.4%, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyetoran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD.
- 2. Masih ditemukan 32.6% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis, setelah ditelusur sudah pengkajian awal IGS sudah diisi lengkap tetapi tidak terbaca, system bermasalah.
- 3. Terjadi penurunan data tidak valid di IRJA, hal ini juga disebabkan adanya perubahan alur penyetoran casemix/data kunjungan pasien per hari, data valid sudah mencapai 99.7%.

Masalah :

- 1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
- 2. Ada beberapa tanda tangan pasien belum muncul.
- 3. Pada fitur “keadaan umum” di lembar triage pengkajian awal medis igd muncul di Billing rekam medis, tetapi di Billing IGD tidak muncul.
- 4. Berikut link permasalahan yang ditemui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

- 1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juli 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
- 2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- 3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Satu DPJP Orthopedi meminta miniplate untuk disediakan di IKO (ready) bukan disediakan hanya saat dibutuhkan	P	Menganalisa kebutuhan miniplate
		D	Koordinasi dengan 2 DPJP ortho lain, keuangan dan vendor
		S	Miniplate jarang digunakan sehingga tidak perlu direadykan
		A	Tetap menggunakan system yang lama, komunikasi dengan DPJP
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
2	Vinyl dan lampu IKO perlu diganti	P	Mengganti lampu IKO
		D	Follow up Pengadaan barang yang belum datang Penjadwalan penggantian vinyl dan lampu
		S	Vinyl belum menemukan vendor yang sesuai

		A	Follow up berkala
3	Baterai bor ortho rusak	P	Koordinasi dengan ATEM
		D	Pengajuan bor dan baterai baru
		S	Follow up
		A	Bor sudah datang dan berfungsi dengan baik

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	ERM di IGD rancu tidak sama tampilan di IGD dan rekam medis	P	Melakukan telusur penyebab ketidaksesamaan antara ERM IGD dan ERM yang muncul di unit RM
		D	Koordinasi dengan programmer
		S	ERM dari IGD sudah diisi dengan lengkap namun tidak muncul di RM artinya terdapat kesalahan sistem
		A	Meminta programmer untuk memperbaiki system
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Dokter IGD kurang lengkap dalam pengisian ERM yang ada di IGD	P	Melakukan telusur alasan dokter IGD kurang lengkap dalam pengisian ERM yang ada di IGD
		D	Kordinasi dengan kabid pelayanan untuk perbaikan pengisian ERM untuk dokter IGD
		S	Beberapa rekam medis yang tidak lengkap di data dan di laporkan ke dr IGD secara langsung
		A	Melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap dr IGD untuk pengisian rekam medis

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Box emergency di maternitas pergantian dari pihak farmasi lama,penyegelan box dari pihak farmasi lama	P	Box emergency setelah digunakan terisi lagi dengan waktu kurang dari 1 jam
		D	Komunikasi dan koordinasi dengan pihak farmasi
		S	Terdapat banyak kasus,setelah box emergency di gunakan tidak langsung di ganti oleh pihak farmasi
		A	Memperbaiki sistem komunikasi atantara farmasi dan perawat/bidan unit
2	Hasil pembacaan USG oleh 1 DPJP radiologi yang meragukan sehingga LOS memanjang karena DPJP	P	Mencari Solusi terkait keraguan hasil bacaan USG DPJP radiologi ini
		D	Koordinasi dengan DPJP dan ketua Komite Medik
		S	1 DPJP radiologi tersebut menyatakan bahwa hasil bacaannya sudah benar
		A	Mengadakan forum komunikasi

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Fitur copy resep tidak bisa,jadi semua pasien input resep baru menyebabkan DPJP komplain karena membuat pelayanan menjadi lama karena DPJP harus mengetik resep ulang	P	Manajemen complain DPJP
		D	Koordinasi dengan PT dan programmer karena hal ini disebabkan oleh sentralisasi master barang
		S	Tidak bisa copy resep lama hanya bisa meresepkan ulang untuk resep-resep yang ada sebelum sentralisasi barang
		A	Komunikasi ke DPJP
2	ESWL dr Edi, SpU harus dibekukan	P	Mengurus izin Bapeten DPJP

	sementara karena terkendala izin Bapeten	D	Follow up berkala
		S	DPJP meminta alur jika pasiennya butuh ESWL
		A	Mengalihkan pasien ke DPJP lain

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama.	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuatkan fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	3. Follow up ke Programmer 4. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang.
2	Terjadi kekosongan konsinyasi implan sehingga pelayanan tidak maksimal	P	Proses pemesanan implan dilakukan setiap hari oleh bagian pengadaan PT sesuai dengan permintaan.
		D	Melakukan perubahan alur mulai dari penyerahan LPO dari IKO (maksimal 1x24jam setelah dipakai).
		S	Jumlah konsinyasi terbatas dari distributor, sehingga implant tidak tersedia ketika dibutuhkan saat durante operasi.
		A	1. Pengumpulan LPO dilakukan setiap hari dari perawat IKO ke Gudang farmasi. 2. Pengecekan kesesuaian implan yang tertulis di LPO dengan inputan tagihan dilakukan setiap hari oleh petugas Gudang farmasi. 3. Pemesanan implan ke distributor dilakukan setiap hari. 4. Koordinasi dengan pengadaan untuk menambah jumlah konsinyasi.
3	Selisih stok di Depo, Gudang Farmasi, IKO dan Gudang Retur Farmasi	P	Memperbaiki monitoring stok antara fisik dengan system.
		D	Menegakkan kembali sistem serah terima pada permintaan barang Depo ke Gudang Farmasi, melakukan double check ketika proses serah terima barang antara stok fisik yang telah disiapkan dan jumlah release di sistem.
		S	Terjadinya selisih stok secara terus menerus pada depo dan Gudang Farmasi,
		A	Koordinasi dengan Programmer terkait sistem IKO dan membuat kesepakatan alur dengan petugas IKO. Return barang IKO yang tidak sesuai jumlah FS ke Gudang Farmasi dilakukan setiap hari.
4	Retur penjualan obat yang tidak diambil	P	Memperbaiki alur retur penjualan obat

	pasien, di retur ke Gudang farmasi di fitur penerimaan hibah lainnya namun resep kronis tidak di hapus di apotek online, dan tidak dihapus di penjualan farmasi		yang tidak diambil pasien.
		D	Koordinasi dengan Kabid, Keuangan, Verifikator dan Managemen PT DPM.
		S	Tidak ada laporan tarikan data pasien khusus BPJS kesehatan karena berkaitan dengan data pasien yang akan di hapus datanya di apotek online.
		A	Obat belum direturn ke apotek online beserta racikannya. Hasil keputusan PT racikan di anggap kerugian maka racikan tetap di retur tapi dihapus dari penjualan.
5	Waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan lama sehingga banyak complain pasien.	P	Mengurangi waktu tunggu di Farmasi. Mendisiplinkan DPJP dalam penginputan e-resep per pasien (tidak dilakukan rapel).
		D	Koordinasi dengan Kabid Pelayanan untuk mengedukasi DPJP.
		S	Jumlah pasien rawat jalan per kunjungan tidak ada batasan sehingga terjadi penumpukan pasein di Poli sampai menunggu di Farmasi.
		A	1. Pasien ditawarkan PRIMANTARA agar tidak menunggu obat lama. 2. Resep obat diinput per pasien oleh DPJP.
6	Terjadi kekosongan obat amitriptilin, haloperidol 5 mg, spironolakton 100 mg	P	Melakukan pengadaan menggunakan e-katalog.
		D	Pengajuan akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
		S	1. Kekosongan obat terjadi karena kosong distributor dan pabrik. 2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.
		A	Menunggu approve dari Kemenkes.
7	Ruangan LAF tidak sesuai standar.	P	Mengajukan ruang LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.
		D	Melakukan list pengajuan perpindahan ruangan dan ditujukan ke PT.
		S	Pedoman dasar dispensing sediaan steril.
		A	Dalam proses mengajukan perpindahan ruangan.

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ketidaksesuaian antara fitur E-RM poli dengan rekam medis	P	Memperbaiki fitur E-RM poli dan rekam medis.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk meminimalisir data yang tidak valid akibat ketidaksesuaian fitur.
		S	Mencatat temuan permasalahan E-RM dan dilaporkan kepada Programmer.
		A	Melakukan koordinasi dengan Programmer setiap ditemukan masalah E-RM.

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2	Pencatatan jumlah linen tidak valid	P	Memperbaiki pencacatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai di Bulan Agustus 2024.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Penurunan jumlah pemeriksaan CT Scan karena alat rusak.	P	Mengajukan pembelian sparepart untuk perbaikan alat. Meningkatkan kunjungan radiologi setelah alat siap digunakan.

		D	Koordinasi dengan ATEM dan Humas&Marketing.
		S	Melakukan rujuk ke luar RS untuk pemeriksaan penunjang, pendapatan RS berkurang.
		A	Koordinasi dengan ATEM dan Humas&Marketing.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	6	1	5	1
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	SMK	42	5	0	5	0
		D3 Farmasi		20	4	16	0
		S1 Apoteker		12	0	12	0
		S1 Farmasi		3	0	3	0
		S1 Analisis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		S1 Ekonomi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	SMA	11	1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		D3 Kesehatan		3	0	3	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 RMIK		5	0	5	0
10	CSSD	SMK	5	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	3	2	1	0
		D3 Kesehatan		0	0	0	1
		S1 Terapi Wicara		1	0	1	0
12	Gizi	SMP	17	2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		D3 Gizi		2	2	0	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
13	Humas & Marketing	S1 Kesehatan Masyarakat	2	1	0	1	0
		Profesi Ners		1	0	0	0
14	ICU dan HCU	D3 Keperawatan	12	5	1	4	0
		Profesi Ners		6	4	2	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
15	IGD	D3 Kebidanan	27	1	0	1	0

		D4 Kebidanan		5	0	5	0
		D3 Keperawatan		9	0	9	0
		D4 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		7	1	6	0
16	IKO	D3 Kebidanan	12	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		3	1	2	0
		Profesi Ners		8	3	5	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	D3 TEM	6	1	0	1	0
		SKM		1	0	1	0
		S1 Teknik		1	0	1	0
		SMA		3	1	2	0
19	IRJA	D3 Kebidanan	27	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	4	4	0
20	IRNA 2C	D3 Keperawatan	7	2	0	2	0
		Profesi Ners		5	1	4	0
21	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	24	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		8	0	8	0
22	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
23	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	19	14	0	14	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
24	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	5	0	5	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
25	Maternitas	D3 Kebidanan	11	7	7	1	1
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		Profesi Bidan		2	0	2	0
26	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
27	Keuangan dan Akuntansi	SMA	10	4	1	3	0
		S1		5	3	2	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
28	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
29	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
30	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	3	6	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
32	Pendaftaran	SMA	15	6	1	5	0
		D3 RMIK		4	2	2	0
		D3 Kesehatan		2	0	2	0
		S1 Sosial		1	0	1	0
		D4 Manajemen		2	0	2	0
33	PIPP	Ners	6	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0

35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
38	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	3	3	0	3	0
39	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMP	44	3	1	2	0
		SMA		41	5	36	0
41	Security	SMA	12	12	6	6	0
42	Driver	SMA	5	5	1	4	0
43	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Syaraf		4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Paru		3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		3	3	0	3	0
48	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Bedah		4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
51	Dokter Spesialis Bedah Syaraf		1	1	0	1	0
52	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3	0	3	0
52	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
53	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
54	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
55	Dokter Spesialis Mata		3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Obstetry Ginekology		4	3	0	3	1
59	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
60	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis THT		2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Radiologi		2	2	0	2	0
TOTAL			449				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Juli 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Juli 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Agustus 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	INSTANSI	NAMA PKS	NOMOR RS	NOMOR INSTANSI	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017	12 Desember 2017	Berlaku
2	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
3	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
4	PT Prudential Life Insurance	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		3143/PMN-PA/IV/2020	13 April 2020	Berlaku
5	PT AIA Financial	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020	4 November 2020	Berlaku
6	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016		28 November 2016	Berlaku
7	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015	19 September 2019	Berlaku
8	PT. Suprima Mitra Adihusada	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019	26 agustus 2019	Berlaku
9	PT. Equity Life IND-Corporate	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		091/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
10	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013	15 Agustus 2013	Berlaku
11	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012	9 Oktober 2012	Berlaku

	Sinarmas Msig	Kerjasama Pelayanan Kesehatan				
12	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	010/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019	9 April 2019	Berlaku
13	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015	16 Maret 2015	Berlaku
14	PT. Equity Life IND-Cassles	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		090/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
15	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013	24 Oktober 2013	Berlaku
16	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018	17 September 2018	Berlaku
17	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716	24 Juli 2019	Berlaku
18	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	025/RSPH/E-PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015	28 April 2018	Berlaku
19	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	070/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019	10 Oktober 2019	Berlaku
20	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015	25 Februari 2015	Berlaku
21	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	508/RSPH/E-IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017	02 Januari 2017	Berlaku
22	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	017/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020	2 Maret 2020	Berlaku

	Manulife Indonesia	Pelayanan Kesehatan Peserta Individu				
23	PT. AJ Central Asia Raya (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019	29 November 2019	Berlaku
24	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C	21 Agustus 2020	Berlaku
25	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019	30 Oktober 2019	Berlaku
26	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS.031/GHASKES/157-1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020	28 Agustus 2020	Berlaku
27	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016	7 September 2020	Berlaku
28	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	017/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-PHMS/VIII/2020	31 Agustus 2020	Berlaku
29	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	-	-	4 Januari 2014	Berlaku
30	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022	10 maret 2022	Berlaku
31	PT. Asuransi Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	149/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023	10 Oktober 2023	Berlaku
32	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang			11 September 2012	Berlaku
33	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	55/Perj/HMS/IX/2014	1 Juni 2014	Berlaku
34	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku

		Pemeriksaan Medicak Chek Up				
35	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan			1 April 2013	Berlaku
36	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85	5 Januari 2012	Berlaku
37	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019	9 Januari 2019	Berlaku
38	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)			1 Oktober 2014	Berlaku
39	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan			20 Maret 2015	Berlaku
40	Harris Hotel & Convensions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018	14 Oktober 2019	Berlaku
41	PT. Duha Mulya Abadi	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac			11 Januari 2019	Berlaku
42	RS Sahabat Pasuruan	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2021		2 Desember 2016	Berlaku
43	PT. Asuransi Dayin Mitra TBK		003/MKT/HLT/PKS/II/2015	PH/IKS/269/XII/2014	1 Mei 2015	Berlaku
44	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022	4 Juli 2022	Berlaku
45	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan			7 Februari 2023	Berlaku

		Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan				
46	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024		23 Januari 2024	Berlaku
47	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024		6 Februari 2024	Berlaku
48	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850	1 September 2022	Berlaku
49	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022	10 Oktober 2022	Berlaku
50	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023	26 Juni 2023	Berlaku
51	ASABRI	PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023	13 Desember 2023	Berlaku
52	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023	15 April 2023	Berlaku
53	Klinik Tirto Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023	18 September 2023	Berlaku
54	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23	24 April 2023	Berlaku
55	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023	3 Juli 2023	Proses di Pihak Kedua

56	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023	1 Desember 2023	Berlaku
57	Klinik Rawat Inap Wijaya Husada	Rujukan Asuhan Pasien	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	15 April 2023	Berlaku
58	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH	21 Juli 2023	Berlaku
59	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	188/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023	3 Oktober 2023	Berlaku
60	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	131.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023	31 Mei 2023	Berlaku
61	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023	5 Juni 2023	Berlaku
62	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	142.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023	22 Juni 2023	Berlaku
63	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023	1 November 2023	Berlaku
64	PT. Arthawena Sakti Gemilang	Pelayanan Rujukan kesehatan	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-	15 Juni 2023	Berlaku
65	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit			22 April 2022	Berlaku
66	CV. Aumireta Anggun	Rujukan Pelayanan Kesehatan	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-	28 Agustus 2023	Berlaku
67	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023	30 Oktober 2023	Berlaku
68	RS Islam Unisma Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT	1 Januari 2024	Berlaku
69	RS Puri Bunda	Rujukan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024	6 Februari 2024	Berlaku

		Pelayanan Kesehatan dan Penunjang				
70	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024	1 Maret 2024	Berlaku
71	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023		24 Agustus 2023	Berlaku
72	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123	30 Januari 2023	Berlaku
73	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-	10 Januari 2022	Berlaku
74	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			2 Agustus 2022	Berlaku
75	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	200.11/DPM/I-PKS/DIR/I/2022		5 Januari 2022	Berlaku
76	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	112.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022	2 Agustus 2022	Berlaku
77	PT. Jaya Obayashi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	360/DPM/I-PKS/VIII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
78	PT. Malang Intermedia Pers	Pelayanan Kesehatan	025/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020	1 Juli 2020	Berlaku
79	PT. Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	032/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
80	PT. Yamaha Musical Product Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP BAGI KARYAWAN DAN KELUARGA	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/PKS/III/2020	1 Juni 2022	Berlaku
81	PT. Tirta Investama	PELAYANAN			31 Agustus 2020	Berlaku

		KESEHATAN KARYAWAN & KELUARGA				
82	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023	1 Januari 2023	Berlaku
83	PT. Kemas Super Indonesia (KSI)	Pelayanan Kesehatan				Berlaku
84	PT. Nayaka Era Husada	Pelayanan Kesehatan	143.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023	30 Mei 2023	Berlaku
85	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!	1 Juni 2023	Berlaku
86	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023	20 November 2023	Berlaku
87	RS Lavalette	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124	10 Agustus 2023	Berlaku
88	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019	21 Februari 2022	Berlaku
89	RS Panti Nirmala	Kerjasama Pelayanan Rujukan	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022	7 Oktober 2022	Berlaku
90	PT Kimberly Clark	Pasokan produk		106/KCS-PNS/MOU/II/2023	1 Januari 2024	BERLAKU
91	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019	18 September 2019	Berlaku
92	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2	28 Januari 2020	Perpanjang Otomatis
93	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223	1 Januari 2024	Berlaku

		Bagi Peserta Program JKN				
94	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022	1 Januari 2023	Berlaku
95	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022		10 Maret 2021	Progres Pihak Kedua
96	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021	16 Juni 2021	Progres Pihak Kedua
97	PT. Etercon Pharma	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	132.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023	1 Juni 2023	Proses Pihak Kedua
98	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022	1 Maret 2022	Proses Review Kabid
99	PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG)	Pelayanan Kesehatan	174.1/DPM/E- PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021	12 Desember 2021	Berlaku
100	PT. Rentokil	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	173.1/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023	11 September 2023	Berlaku
101	PT. Pillar Utama Cortindo	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023	1 Juni 2023	Progres di PT
102	PT. Global Trans Jaya Mulia & PT Global Enviro Nusa	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	115/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	044/SPK-T/DPM-GTJM/GEN/IV/2024	15 April 2024	Berlaku

103	PT. Uniplastindo Interbuana	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021	8 Juni 2023	Proses TTD Pihak Kedua
104	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019	1 November 2022	Berlaku
105	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	152.40/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022	16 September 2022	Berlaku
106	RS Siti Miriam Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022	4 Oktober 2022	Berlaku
107	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	234/DPM/E-PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024	1 November 2024	Berlaku
108	RSU Muhammadiyah (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	159.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023	21 Agustus 2023	Disposisi SIMRS
109	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023		PROSES PERMOHONAN
110	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			23 Februari 2024	Berlaku
111	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan				PROSES TTD DILUAR

112	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan				PROSES DISPOSISI SIM
113	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Asuransi Pelayanan Keshatan				PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS
114	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	294/E-PKS/DIR/I/2024		17 Januari 2024	Berlaku
115	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Protesa Ortesa				PROSES DISPOSISI SIM
116	PT Pesta Pora Abadi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024			Review Pihak kedua
117	Batas Media 99	Rujukan Pelayanan Kesehatan			5 Juni 2024	Berlaku
118	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan				TTD Dir PT
119	PT Tentrem Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
120	Klinik Utana Rawat Jalan Akasia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	25 April 2024		Berlaku	
121	PT Ustegra	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
122	PT Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	12 Juni 2024		Berlaku	
123	PT Unggul Anugerah Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
124	PT Bestari Murni Anugerah	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
125	PT Indonesian Marine	Rujukan			Review Pihak kedua	

126	PT Randi Cones Indonesia	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					
127	PT Indonesian Tobacco	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
128	PT Tonggak Ampuh	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
129	Klinik Beauty Medika	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	145/DPM/E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2004	25 Mei 2024		Berlaku
130	Ibazz Aesthetic and Medical Center	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	180/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024		14 Juni 2024		Berlaku
131	RS Universitas Brawijaya	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	178/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024				Review Pihak kedua
132	PT Citra Karsa Dinamika	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					Proses TTD Pihak Kedua
133	PT Moor Sukses Internasional	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	200/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	001/MSI/VI/2024	8 Juli 2024		Berlaku
134	BPM Nia Irawati	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	081/DPM/E-PKS/DIR/III/2024		7 Februari 2024		Berlaku
135	Instruktur Zumba	Instruktur Zumba Rujukan Pelayanan Kesehatan			23 Februari 2024		Berlaku
136	Klinik Esweje	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9120200211338	1 Maret 2024		Berlaku
137	PT Alfiza Medika Utama	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024	7 Maret 2024		Berlaku
138	PT Medilink Digital Medika	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024	22 Maret 2024		Berlaku

139	BPM Riza Khutmi	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
140	BPM Indah Maharany	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
141	PT Indostar Building Material	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
142	Rajawali Plastik	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Proses TTD Pihak Kedua
143	Green Mountain Natural Foods	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
144	PT Indonusa Algaemas Prima	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak Kedua
145	RSUD Bangil	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024	22 Juli 2024	Berlaku